INSURANCE INFORMATION

보험 인포메이션

고객 계약과 무관한 **공통 참고 자료**입니다. v786 · 2026.10.17 · 60쪽 · 주제별 목차 · 오른쪽 숫자 = 쪽

암

01 **암 보장률 리포트** — 공단 「2024년도 진료비 실태조사」 — 2 – 4

02 **암 급여 한도표** NEW — 산정특례 5%가 빠지는 두 길 — 5

03 **표적항암 「인자」 · 선납 · 중입자** NEW — 인자 / 치료명 : 선납 / 금액 / 중입자 대상·불가 — 6

04 **3대 주요치료비 변천사** — 비례형 → 정액형 → 비급여 → 생활비 — 7

05 **암 · 뇌 · 심 치료 용어** — 관혈 · 비관혈 · 수술 · 시술 · 약물 — 8 – 9

06 **방사선치료 · 항암 약물치료** NEW — 방사선 5종 · 항암약물 4종 · 담보 연결 — 10

07 **암 치료비 4단계 · 암 키워드** — 급여 · 선별급여 · 전액본인부담 · 비급여 — 11

08 **현대해상 여성 특화 담보 플랜** NEW — 간편 3.10.10 / 내삶엔(3N) · 갑상선 · 유방 · 자궁 — 12

09 **통합치료비 세부보장항목** — KB 암 · 순환계 · 삼성화재 — 13 – 16

10 **흥국화재 10억통장** — [갱신형]플래티넘 건강 리셋월렛II — 17

뇌 · 심

11 **뇌 · 심장 급여 한도표** NEW — MRI·심장초음파 횟수 · TAVI 5/50/80% · 재활 · 간병 — 18

12 **현대해상 심장질환 분류표** NEW — 질병코드(I00~I52) × 담보 7열 ○표 — 19

13 **순환계 한눈에 정리** — 심장 · 혈관 · 혈액 구조와 순환 경로 — 20

14 **보험사별 심혈관 담보 분류** — 회사별 · 질병코드 기준 — 21 – 24

실손

15 **국민건강보험공단 지원제도** — 산정특례 · 재난적의료비 · 상한제 · 검진 · 상병수당 — 25 – 26

16 **외래 300회 초과 90%** — 2027.01.01 시행 · 5세대 연동 — 27

17 **5세대 실손보험** — 급여 통원 공제 · MRI/도수/주사 · 중증 vs 비중증 — 28 – 33

18 **위고비 · 마운자로 실손** NEW — 비만(E66) = 실손 보상 안 됨 · 처방 기준 — 34

수술비

19 **1~5종 수술분류표** — 요약 · 신입용 · 회사별 비교 · 약관 원문 — 35 – 45

재무

20 **연금계좌 세액공제** — 연금저축 · IRP 납입 한도 · 공제율 — 46

21 **MAKEONE LIFE PLAN** — 재무상태 · 미래가치 · 달러자산 — 47 – 50

제도

22 **고지의무 체크리스트 · 내 진료기록 조회 4가지** — 3개월 · 1년 · 5년 질문 / 공단 PC · 건강보험25시 · 심평원 · 건강e음 — 51 – 52

23 **대한민국 상급종합병원 47곳** — 권역별 명단 — 53

기타

24 **알츠하이머 신약 레켐비** — 치료 원리 · 보험 담보 핵심 — 54

25 **교통사고 경상환자** — 자배법 시행령 개정 · 8주 기준 — 55

26 **질병 후유장해** — 세부 장해와 지급률 · 청구 전 체크 — 56

27 **CI 약관 — 「중대한」 담보 정의** NEW — 중대한 암 · 급성심근경색 · 뇌졸중 · 말기 질환 · 화상 · 수술 — 57 – 58

28 **보험금 청구 — 무료 필수서류 4종 · 방법** NEW — 처방전 · 통원확인서 · 상세내역서 · 약봉투 / 금액별 · 기한 — 59

29 **각사 콜센터 · 인콜 · 청구 FAX** NEW — 손보 16 · 생보 21 · 공제 — 60

암, 보장률은 내려가고 비급여는 올라갔다

2024년 건강보험 보장률은 **64.9%**로 전년과 같지만, **암질환만 1.3%p 하락**했다. 법정 본인부담은 그대로인데 **비급여 본인부담이 14.8% → 16.0%**로 뛴 것이 원인이다.

암질환 보장률	암 비급여 본인부담	4대 중증질환	전체 보장률
75.0%	16.0%	81.0%	64.9%
▼ 1.3%p	▲ 1.2%p	▼ 0.8%p	전년 동일

4대 중증질환 산정특례대상자 건강보험 보장률 단위: %

구 분	2023년			2024년		
	보장률	법정 본인부담	비급여 본인부담	보장률	법정 본인부담	비급여 본인부담
전체	81.8	8.3	9.9	81.0 (-0.8)	8.3	10.7 (+0.8)
암질환	76.3	8.9	14.8	75.0 (-1.3)	9.0	16.0 (+1.2)
뇌혈관질환	88.2	6.7	5.1	87.9 (-0.3)	6.4	5.7 (+0.6)
심장질환	90.0	5.1	4.9	90.3 (+0.3)	4.9	4.8 (-0.1)
희귀·중증난치	89.0	8.4	2.6	89.3 (+0.3)	8.1	2.6

4대 중증질환 보장률은 현금급여(본인부담상한제 사후환급금)를 포함함 · 원문 보도자료 붙임2

연도별 건강보험 보장률 10년간 63.4% → 64.9%, 1.5%p 상승에 그침

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
63.4	62.6	62.7	63.8	64.2	65.3	64.5	65.7	64.9	64.9

출처: 국민건강보험공단 보도자료 붙임1「연도별 건강보험 보장률」

읽는 법 — 뇌혈관 87.9% · 심장 90.3%는 **10만원 중 1만원 안쪽**만 내 돈이다. 그런데 암은 75.0%, 즉 **4분의 1이 내 돈**이고 그중 대부분(16.0%)이 **건강보험이 한 푼도 안 내는 비급여**다.

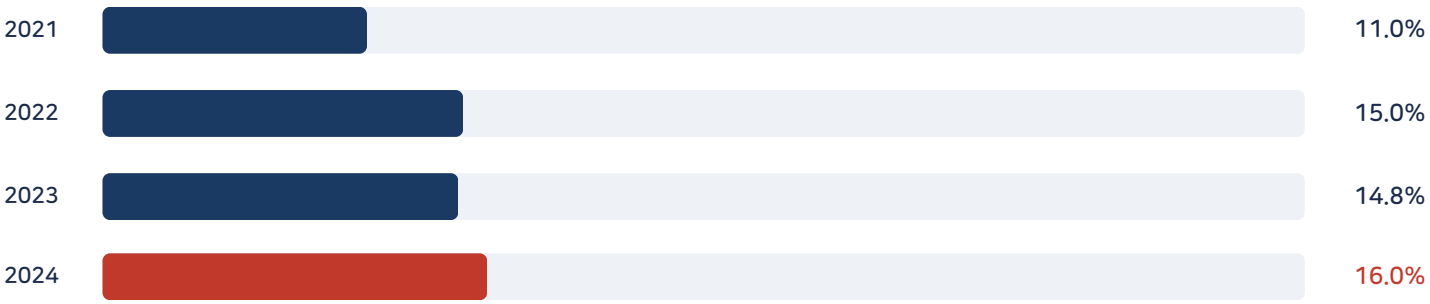
암 보장률 4년째 내리막

암질환 보장률 연도별 추이 4대 중증질환 산정특례대상자



2021년 80.2% → 2024년 75.0% · **4년간 5.2%p 하락**

같은 기간 암 비급여 본인부담률 막대는 50% 기준 축



2021년 11.0% → 2024년 **16.0%, 1.45배**

연도별 부문별 진료비 규모 변화 괄호는 전년 대비 증가율

연도	보험자부담금	법정 본인부담금	비급여 진료비	총 진료비
2017	52.5조 (7.5%)	16.9조 (7.2%)	14.3조 (6.6%)	83.7조 (7.3%)
2018	59.5조 (13.3%)	18.3조 (8.1%)	15.5조 (8.3%)	93.3조 (11.4%)
2019	66.3조 (11.5%)	20.3조 (11.2%)	16.6조 (7.0%)	103.3조 (10.7%)
2020	67.1조 (1.2%)	20.1조 (-1.2%)	15.6조 (-6.2%)	102.8조 (-0.5%)
2021	71.6조 (6.8%)	22.1조 (9.9%)	17.3조 (11.3%)	111.1조 (8.1%)
2022	79.2조 (10.5%)	23.7조 (7.5%)	17.6조 (1.8%)	120.6조 (8.5%)
2023	86.3조 (9.0%)	26.5조 (11.7%)	20.2조 (14.4%)	133.0조 (10.3%)
2024	90.0조 (4.3%)	26.8조 (1.0%)	21.8조 (8.1%)	138.6조 (4.2%)

출처: 국민건강보험공단 보도자료 2쪽「연도별 부문별 진료비 규모 변화」

핵심 — 급여는 **4.3%** 늘 때 **비급여는 8.1%** 늘었다. 공단이 부담을 늘려도 **비급여가 더 빨리 커져** 보장률이 제자리인 구조다. 그 한가운데에 **암**이 있다.

어디서 치료받느냐가 내 돈을 정한다

암 환자가 실제로 겪는 보장률

요양병원 암(산정특례)	약국 암(주상병)	상급종합 전체	요양병원 전체
36.3%	77.7%	72.2%	67.3%
▼ 1.0%p ('23 37.3)	▼ 4.0%p ('23 81.7)	▲ 1.4%p	▼ 1.5%p

공단 설명 — 요양병원·약국 보장률 하락은 「암질환 중심으로 비급여 진료비가 증가」한 것이 원인 · 원문 3쪽

요양기관 종별 건강보험 보장률 (2024년) 단위: % · 현금급여 미포함

요양기관 종별	건강보험 보장률	법정 본인부담률	비급여 본인부담률
상급종합	72.2 (+1.4)	19.1	8.7
종합병원	66.7 (+0.6)	21.7	11.6
병원	51.1 (+0.9)	18.1	30.8
요양병원	67.3 (-1.5)	18.5	14.2 (+1.9)
의원	57.5 (+0.2)	20.1	22.4
약국	69.1 (-0.3)	28.0	2.9 (+0.5)

원문 3쪽

1인당 중증·고액진료비 상위 30위 절반 이상이 암

순위	질환
1	백혈병
2	췌장의 악성신생물
4	기타 림프·조혈 악성신생물
5	뇌의 악성신생물
6	기관·기관지·폐의 악성신생물

순위	질환
8	비호지킨 림프종
11	기타 소화기관의 악성신생물
12	간 및 간내담관의 악성신생물
13	식도의 악성신생물
25	유방의 악성신생물

상위 30위 내 질환 보장률 80.2%(-0.7%p) · 50위 내 78.5%(-0.5%p) · 원문 붙임3

상담 포인트 —

- 암 진단 후 **요양병원**으로 옮기면 보장률이 **36.3%**까지 떨어진다. 내 돈이 **3분의 2**다.
- 암 **약값**도 보장률이 1년 만에 **81.7% → 77.7%**로 떨어졌다.
- 공단이 못 내는 **비급여 16.0%**는 **진단비·주요치료비**로만 메울 수 있다.

암, 병원비 5%가 안 되는 때

정해진 횟수·조건 안에서만 5% — 넘으면 내 돈 (산정특례 C코드 5년)

21쪽 4단계와 연결 — 산정특례 5%는 ① 급여 ✓ 에만 · ② 선별급여 × · ③ 전액본인부담 × · ④ 비급여 ×

① 하다 보면 넘는 것 — 횟수 · 조건

재발 확인하려고 찍는 PET
내 돈 전부

증상·검사 소견 없이 찍으면 급여 아님. 급여는 진단·효과판정·재발 의심 때만

MRI · 초음파 횟수 넘기면
내 돈 80%

복부·흉부 MRI 1년 1~2번, 간 초음파 1년 1번까지만 5%

조건 안 맞는 항암주사
내 돈 전부

병기 · 차수(1차/2차) · 인자 — 하나라도 벗어나면 같은 약이 100%

면역항암 2년 넘기면
내 돈 전부

키트루다·옵디보 등 적응증별 상한 (폐암 1차 병용만 2024.3 삭제)

급여약 + 새 약 같이 쓰면
새 약 몫 내 돈

2025.6부터 급여약은 5% 그대로, 신약 몫만 100%

산정특례 5년 끝나면
내 돈 20~60%

잔존암·전이·치료 중이 아니면 재등록 안 됨

② 처음부터 내 돈인 것 — 산정특례 안 붙음

선별급여 항암제
내 돈 30~50%

퍼제타·할라벤(유방) / 엑스탄디·자이티가(전립선)

유전자 검사 (NGS)
내 돈 50~80%

표적약 고르는 검사 · 폐 선암 3·4기만 50%

로봇수술
내 돈 전부

평균 1,000만(800~3,800만) · 전립선·갑상선·자궁·위·대장

중입자치료
내 돈 전부
선납 4,000~5,000만

연세암병원 · 전이암 불가 · 12회

양성자 (적응증 밖)
내 돈 전부

1,000~3,000만 · 소아암·뇌종양·식도·췌장은 급여

온열 · 면역세포 · 액체생검
내 돈 전부

상급병원 권유 많음 · 실손도 제외 많음

돈 계산 예시 — 숫자는 가정(실제는 병원 견적) [예시]

중입자 5,000만
실손 통원 12회×20만 = 240만 → **내 돈 4,760만**

로봇수술 1,200만
실손 입원 한도 안이면 일부 · 자기부담 20~30% + 한도 초과 → **내 돈 300만~**

선별급여 항암 월 400만 × 6개월
본인부담 30% → **내 돈 720만** (산정특례 ×)

→ 보험으로 준비 : 암 주요치료비 · 비급여 항암 · 로봇수술 · 암 진단비

먼저 돈을 내야 하는 치료 보험금은 치료 뒤에 나온다 — 고객이 먼저 들고 있어야 한다

선납 흐름 — 진단 → 치료계획 → 선납(고객 돈) → 치료 → 보험 청구 → 입금(2~4주 뒤) … 그 사이 돈은 고객이 들고 있어야 한다

① 치료명 : 선납 / 금액

중입자치료
선납 4,000~5,000만
연세암병원 · 치료 전 수납 · 전이암 불가 · 12회

CAR-T (비급여)
선납 3.6억
킴리아 급여 조건 밖일 때

로봇수술
입원 예납 평균 1,000만 (800~3,800만)
퇴원 때 정산 · 병원별

비급여 표적 · 면역항암
매달 300~1,000만
2~4주 처방마다 결제 = 매달 선결제

양성자 (적응증 밖)
사전 수납 1,000~3,000만
소아암·뇌종양·식도·췌장은 급여 5%

급여 표적 · 면역항암
선납 없음 · 5%
처방마다 5% · 조건 밖이면 100%

② 표적약 = 「인자 양성」 + 병기·차수 조건이 맞아야 급여 — 검사비 내 돈 50~80만 · 인자 없으면 그 약 못 씀

암종	검사하는 인자	대표 약
폐암	EGFR · ALK · ROS1 · KRAS · MET · RET · BRAF · HER2 / PD-L1	타그리소 · 렉라자 · 알렉티닙 · 키트루다
유방암	HER2 · 호르몬수용체 · BRCA · PIK3CA	허셉틴 · 퍼제타 · 엔허투 · 입랜스 · 린파자
대장암	RAS 야생형 · BRAF · MSI-H	얼비툭스(RAS 야생형만) · 아바스틴 · 키트루다
위암	HER2 · CLDN18.2 · PD-L1	허셉틴 · 빌로이 · 옵디보
난소 · 전립선	BRCA · HRD · PSMA	린파자 · 제줄라 · 플루빅토
혈액암	BCR-ABL · CD20 · CD19 · CD38	글리벡 · 리툭시맙 · 킴리아 · 다잘렉스

돈 계산 예시 — 숫자는 가정(실제는 병원 견적) [예시]

중입자 5,000만
선납 5,000만 → 치료 → 청구 → 항암중입자 1,000만 + 진단비 → 모자라면 내 돈

CAR-T 3.64억
급여 조건이면 5%+본인부담상한제 · 조건 밖이면 전액 내 돈

비급여 표적항암 월 400만
매달 결제 → 암주요치료비(치료당) · 비급여 항암 담보로 매달 메움

→ 보험으로 준비 : 암 진단비 · 항암중입자 · 비급여 항암 · 로봇수술

3대 주요치료비 담보의 변천사

①비례형(구간) → ②정액형 → ③비급여 → 생활비 · 정액형 가입금액 100만원부터

■ 상담 화법

"5세대 실손은 비급여가 1천만원으로 줄었고 통원비는 20만원 입니다."

● 암 주요치료비

4세대 진화

1 비례형(구간형) — 치료비 발생 기준

~24.11 단종

치료비 발생	지급	치료비 발생	지급
300~500만	300만	4,000~5,000만	4,000만
500~700만	500만	5,000~6,000만	5,000만
700~1,000만	700만	6,000~7,000만	6,000만
1,000~2,000만	1,000만	7,000~8,000만	7,000만
2,000~3,000만	2,000만	8,000~9,000만	8,000만
3,000~4,000만	3,000만	9,000~1억	9,000~1억

· 치료비 지출액이 구간 하한 도달 시 그 구간 정액 지급(지출 없으면 미지급)

· 최소 하한 미달분 미지급(삼성 1,000만 시작 → 농협 300만까지)

· 실손과 중복 수령 가능 · 2024.11 단종(재가입 불가) — 보유자 해지 금지

2 정액형

24.11~ 현재 신규

· 치료 사실만으로 약정금 정액 지급(실비 무관, 고정금액)

· 암수술·항암방사선·항암약물 각 보장, 특약 시 입원·검사 추가

· 면책 90일, 감액기간 일부(~50%) · 가입금액 100만원부터

3 비급여(하이클래스)

25.03~

· 급여 전액본인부담금 + 비급여 치료비 정액 보장

· 산정특례가 안 주는 비급여(양성자·중입자·표적·면역) 커버

· 면책 90일, 연 1회 · 2천만×10년=2억(삼성 최초)

4 암주요치료비 생활비

25.08~

· **치료비가 아니라 소득 공백을 메우는 담보** — 항암 중 휴직·감축으로 끊기는 생활비를 정액 지급

· **★1회 지급이 전부가 아니다** — **1회차**는 치료 중 1번 지급, 이후 **2회차·3회차·4회차**까지 이어지는 다회 지급형이 있다

· 암 치료(수술·항암방사선·항암약물) 중 **하나만 받아도** 지급 · 치료비 담보와 **중복 수령**

· 하이클래스(비급여)에 **치료 + 소득보상**이 결합된 형태로 25.08 등장 · **회차별 지급액·지급조건·최대 회차는 회사별 상이[확인]**

5 설명 — 왜 필요한가

※ 실손으론 부족 — 5세대 기준

· 비중증 비급여: 자기부담 50%·통원 회당 5만원·한도 1,000만(4세대 5천만→축소)

· 중증(암·산정특례): 자기부담 30%·연 5천만이나 표적·면역 고가 약값엔 부족

· 외래(통원) 주사 반복 → 주요치료비·하이클래스가 메움

● 뇌·심장 주요치료비

암과 동일 진화

1 비례형(병원비형) — 급여 본인부담 기준

~24.11 단종

급여 본인부담	지급	급여 본인부담	지급
100만원 미만	미지급(면책)	1,000~2,000만	1,000~2,000만
100~500만	100~500만	2,000~3,000만	2,000~3,000만
500~1,000만	500~1,000만	3,000만 이상	3,000만(한도)

· 지급 = 본인부담금 전액(비례) · 암(치료비 발생 하한 정액)과 축이 다름

· 예) 종합병원 2대질병 주요치료비 = 급여 본인부담 연 100만↑ → 3,000만 한도 ·10년 지급 · 구간액 회사별 상이[확인]

2 정액형(2대)

24.11~ 메리츠 최초

· 수술·혈전용해·중환자실 치료 사실만으로 정액(100만~) · 메리츠 최초, 연 2천만×5년=1억

3 순환계주요치료비

25.01~

· 부정맥·심부전·동맥류까지 **확대**(52질환·연 8천만·100세) — 2대(뇌·심)만 보던 범위를 순환계 전체로 넓힌 단계

4 순환계주요치료비 생활비

25.06~

· **치료 중 소득보상** — 뇌·심 치료로 인한 휴직·소득 감소를 정액으로 보전

· **★1회 지급이 전부가 아니다** — **1회차**는 치료 중 1번 지급, 이후 **2회차·3회차·4회차**까지 이어지는 다회 지급형이 있다

· 수술·혈전용해·중환자실 중 **치료 하나만 받아도** 지급 · 진단비·주요치료비와 **중복 수령**

· 순환계 확대(부정맥·심부전·동맥류 52질환)와 함께 설계 · **회차별 지급액·지급조건·최대 회차는 회사별 상이[확인]**

5 재발률 · 실제 수술비용

심평원·건보공단

▶ 한 번으로 안 끝난다

뇌경색 재발 1년 10%·5년 20~30% / 급성심근경색 1년 30%·3년 50% / 스텐트 5년 재협착 15%

수술	건당 총진료비(평균)
심장수술(개흉)	2,832만원
관상동맥우회술(CABG)	2,690만원
뇌동맥류 코일색전술	1,100~1,600만원
심장 스텐트(다발혈관)	1,000~1,400만원
뇌기저부수술	1,475만원

총진료비 기준(심평원·건보공단 통계) · 재발 시 이 비용이 반복 — 주요치료비가 채운다

암 치료 용어

① 수술 절개해서 떼어낸다

맘모톰	비관혈1종	유방에 바늘로 조직을 흡입
다빈치로봇	관혈준용	로봇으로 암 부위 정밀 절제
복강경	관혈준용3종	배에 구멍 내고 병변 제거
흉강경	관혈준용	가슴에 구멍 내고 병변 제거
EMR	비관혈3종	위 · 대장 점막층 병변 절제
ESD	비관혈3종	점막 아래층까지 박리해 제거
원추절제술	관혈	자궁경부를 원뿔로 절제
림프절절제	관혈	전이 확인 · 림프절 제거

② 시술 · 정밀치료 장비 · 에너지 중심

RFA	비관혈3종	전극 열로 암세포를 태운다
TACE	비관혈3종	암 혈관 막고 항암제 주입
스텐트삽입	비관혈3종	막힌 통로에 금속관 삽입
담도배액술	확인	막힌 담즙 길을 뚫어 배출
감마나이프	확인	뇌 병변에 고선량 집중
사이버나이프	확인	로봇이 추적하며 정밀 조사
냉동절제술	비관혈3종	얼려서 암세포를 파괴
HIFU	확인	초음파를 한 점에 집중

③ 방사선치료 수술이 아니다

양성자치료	수술X	양성자 입자로 에너지 집중
중입자치료	수술X	무거운 입자로 강한 에너지
IMRT	수술X	세기를 부위별로 조절
SBRT	수술X	몸통 작은 병변 단기 집중
SRS	수술X	한 지점에 고선량 정밀 조사
토모테라피	수술X	회전하며 나누어 조사
브라키	수술X	방사선 물질을 병변에 삽입
IGRT	수술X	영상으로 위치 확인하며 조사

관혈 / 비관혈 — 약관 정의 여기서 금액이 갈린다

관혈수술 피부를 **절개**해 병변을 **눈으로 직접 보며** 조작

비관혈수술 내시경수술 · 카테터수술 · 신의료수술

★ 준용 대뇌내시경 · 복강경 · 흉강경은 **관혈수술에 준해** 보상

★ 축이 다르다 관혈 · 비관혈과 **1~5종**은 별개 — 복강경은 **관혈 준용 + 3종**

④ 항암제 종류 방식에 따라 이름이 다르다

세포독성	빨리 자라는 세포를 공격하는 전통 항암제
표적항암제	특정 유전자 변이 · 단백질만 겨냥
면역항암제	내 면역세포가 암을 공격하도록 돕는다
호르몬치료	호르몬으로 자라는 암의 성장 억제
허가항암약물	식약처 허가 범위 안의 항암약물치료
비급여항암	건보 미적용 — 환자가 전액 부담
유지요법	재발 · 진행을 늦추려 계속하는 치료
보조항암	수술 후 남은 암세포를 줄이는 치료

⑤ 대표 치료제 약제명까지 알면 설명이 쉽다

CAR-T	T세포를 바꿔 암을 공격하게 만든다
킴리아	대표적 CAR-T 치료제
키트루다	대표적 면역항암제
옵디보	대표적 면역항암제
타그리소	EGFR 변이 폐암 표적항암제
렉라자	EGFR 변이 폐암 표적항암제
허셉틴	HER2 양성 유방암 표적치료제
린파자	BRCA 변이 관련 암 표적치료제

⑥ 검사 · 바이오마커 변이를 찾아 치료제를 고른다

조직검사	조직을 떼어 암인지 확인
생검	조직 · 세포를 채취해 질병 확인
PET-CT	대사 활동으로 전이 · 병기 판단
종양표지자	혈액에서 암 관련 수치 확인
유전자검사	변이를 확인해 치료 방향 결정
NGS 검사	여러 유전자를 한 번에 분석
액체생검	혈액 속 암 유전자 조각 분석
IHC	조직의 특정 단백질 발현 확인
HER2	많으면 **허셉틴** 대상
PD-L1	높으면 **면역항암제** 대상
EGFR	변이 시 **타그리소 · 렉라자**
BRCA	변이 시 **린파자** 대상

뇌 · 심 치료 방식

① 뇌 — 수술 · 시술 터지면 / 막히면

기계적혈전제거	비관혈3종	카테터로 혈전을 꺼낸다
혈전흡인술	확인	관으로 혈전을 빨아낸다
스텐트삽입	비관혈3종	좁아진 혈관에 금속관
풍선성형술	비관혈3종	좁은 뇌혈관을 풍선으로 넓힘
코일색전술	비관혈3종	카테터로 코일 채워 막는다
스텐트+코일	비관혈3종	입구 넓은 동맥류에 병용
클립결찰술	관혈5종	머리 열고 동맥류 목을 집는다
개두혈종제거	관혈5종	머리 열어 고인 피를 제거
감압두개절제	확인	붓는 뇌 위해 뼈를 떼어 둔다
뇌실외배액	확인	고인 물을 빼 뇌압을 낮춘다
뇌실복강단락	관혈	관을 심어 뇌척수액을 배로
경동맥내막절제	관혈	목 혈관 죽상판을 긁어낸다

② 심장 — 수술 · 시술 좁아지면 / 막히면

관상동맥조영	수술X	조영제로 혈관을 촬영
심장카테터	비관혈3종	관을 넣어 막힌 곳을 뚫는다
풍선확장술	비관혈3종	좁은 부위를 풍선으로 넓힘
스텐트삽입	비관혈3종	다시 좁아지지 않게 지지
회전죽종절제	비관혈3종	굳은 석회를 갈아낸다
전극도자절제	비관혈3종	부정맥 부위를 지진다
인공심박기	비관혈3종	느린 맥을 기계로 잡는다
삽입형제세동기	확인	위험한 부정맥을 전기로 멈춤
TAVI	비관혈	관으로 인공판막을 넣는다
판막치환술	관혈5종	가슴 열어 인공판막 교체
CABG	관혈5종	가슴 열어 새 혈관 길을 낸다
심장이식	관혈5종	말기 심부전에 심장 교체

수술의 정의 — 약관 원문 이게 안 되면 수술비가 없다

수술 기구를 사용해 생체에 **절단 · 적제 등의 조작**을 가하는 것 신의료기술 인정 최신 기법 포함

제외 흡인 · 천자 · 적제 · 신경차단(NERVE BLOCK) — 약을 넣거나 빼는 조치는 수술이 아니다

재발이 진짜 리스크 1회성이 아니다

뇌경색 1년 내 10% · 5년 내 20~30% 재발

급성심근경색 1년 내 30% · 3년 내 50% 재발

산정특례 암은 5년 · 뇌 · 심은 최대 30일(재수술 +30)만 — 그 뒤 수십 년은 보험이 낸다

연간 1회 산정특례대상 진단비는 매년 반복 지급 가능

③ 약물 방식 뇌 · 심 공통 — 수술이 아니다

혈전용해제	수술X	정맥 투여로 혈전을 녹인다
항혈소판제	수술X	아스피린 · 클로피도그렐
항응고제	수술X	와파린 · NOAC 혈전 예방
스타틴	수술X	콜레스테롤↓ 죽상판 안정
베타차단제	수술X	심박수↓ 심장 부담 감소
ACE · ARB	수술X	혈압↓ 심부전 진행 억제
니트로글리세린	수술X	협심증 흉통을 빠르게 완화
이뇨제	수술X	고인 물을 빼 부종 감소

④ 치료 단계 → 담보 어디서 무엇이 나오나

1 응급실	응급 이송 · 처치	응급실내원 · 실손
2 검사	CT · MRI로 판단	실손 · MRI 특약
3 진단	뇌졸중 · 심근경색	진단비 · 산정특례
4 약물	정맥 혈전용해제	혈전용해치료비 수술비X
5 시술	혈전제거 · 스텐트	카테터수술비 · 3종
6 수술	개두 · 개흉	뇌 · 심수술비 · N대 · 5종
7 회복	중환자실 · 재활	중환자실 · 후유장해

⑤ 1~5종 종별 사례 회사 · 가입시기별로 다르다

1종	백내장 · 치핵 · 편도절제 · 하지정맥류 · 체외충격파 · 대장용종(KB · 메리츠)
2종	대장용종(현대 · 삼성 · DB) · 위 용종 · 자궁근종 · 충수절제
3종	녹내장 · 디스크 · 갑상선 관혈 · **뇌 · 심 내시경 · 경피적 · 인공심박조율장치** · 복강경
4종	위 절제 · 식도 · 부신 절제 · 간장 · 췌장 · 직장 · 방광 · 요관 관혈
5종	**심장 내 관혈 · 두개 내 관혈** · 대동맥 · 관동맥 관혈 · **악성신생물 근치수술**
용종	1종 메리츠 · KB「대장 용종 내시경적 절제술은 1종」단서 조항 / 2종 현대 · 삼성 · DB 복부장기 내시경 2종 명시 코드 Q7701~03 올가미 수술 인정 / E7660 · N0041 펀치 · 겸자 생검 성격 → 확인 주의 1~5종 / 1~8종 / 1~9종 체계 상이 · 구분 없다 질병 · 상해 · N대 · 암 · 뇌 · 심수술비 · 1~5종 불가 흡인 · 천자 · 배액술

⑥ 암 · 뇌 · 심 → 종별 같은 부위도 방법 따라 갈린다

암 3종	EMR · ESD 내시경 · **복강경 · 흉강경** · RFA · TACE
암 4 · 5종	위 절제 **4종 / 관혈적 악성신생물 근치수술 5종**
뇌 3종	기계적 혈전제거 · 스텐트 · 코일색전 · 풍선성형
뇌 5종	**두개 내 관혈** — 개두 혈종제거 · 클립결찰술
심 3종	카테터 PCI · 스텐트 · 전극도자 · **인공심박조율장치**
심 5종	**심장 내 · 관동맥 관혈** — 판막치환 · CABG · 심장이식

방사선치료 · 항암 약물치료 — 무엇이 다른가





방사선 담보 · 방사선치료는 **수술이 아니다** → 수술비 X · **항암방사선치료비** · 세기조절(IMRT)·양성자·중입자는 상품마다 특정 담보가 따로(중입자 = 「항암중입자방사선치료비」 만) · 정위적(사이버·감마나이프)은 회사 기준 확인

약물 담보 · 세포독성 = **항암약물치료비** · 표적 = **표적항암약물허가치료비** · 면역 = 면역항암(약물허가) 담보 · 호르몬 = 호르몬약물 담보(일부 상품) · 통합치료비·주요치료비는 「방사선」「약물」 항목 · 대표 약제명은 16쪽 ⑤

암 치료비, 4단계로 나뉩니다 암 질환 키워드 5가지 · 급여 → 비급여 4단계

암 질환 키워드

암 발생률 약
41%
약 2.5명 중 1명

암 5년 내 생존률 약
74%

암 통원 치료 약
93%
*실손한도 일 20만원 (5세대 기준)

원발 + 전이암 동시진단 약
47%

남성 1위 **전립선암**
여성 1위 **유방암**



· 선별급여는 산정특례 미적용

※ 왼쪽 수치는 보험사 교육자료(2026)의 인용값을 MAKEONE이 다시 그린 것 · 원출처(국가암등록통계·건강보험공단) 연도별 수치는 변동 — 상담 전 최신값 확인 · 통원 93%는 암 진료 중 외래 비중.

현대해상 여성 특화 담보 플랜 간편 3.10.10 / 내삶엔(3N) · 여성 1~5종 포함

여성 특·화·담·보 플랜

간편 3.10.10 / 내삶엔(3N) | 여성 1-5종 포함

갑상선 · 유방 · 자궁 · 여성 1-5종 — 담보명·가입금액 그대로 · 오른쪽 = 현대해상이 미는 포인트

구분	담보	가입금액	현대 포인트
갑상선	갑상선항진증치료	50만	누구나 발생
	갑상선기능저하증진단	50만	
	BEST 로봇암수술 (다빈치 · 레보아이)		갑상선암 로봇수술 1천만
	갑상선암, 전립선암 외 (연1회)*	1천만	
	갑상선암, 전립선암 (연1회)*	1천만	
유방	BEST 암주요치료비IV 치료당 (10년 / 상급병원)		유방암 항암 무제한 치료당
	수술 · 방사선 · 약물 (치료당) / 유사암	1백만 / 20만	
	BEST 유방주요치료비		중증 유방암 진단 1천만 (보험료 1천원)
	삼중음성유방암진단	1천만	
	유방바늘생검조직검사	20만	
	특정유방병변진공흡인 (맘모톰)	50만	
	유방암으로 인한 유방수술	30만	
자궁	BEST 특정질환 로봇수술 (연1회)		비중증 / 비급여 로봇수술
	자궁 및 난소 (11종)*	2백만	
	전립선 및 방광 (18종)*	2백만	
	내분비 및 소화계질환 (11종)*	2백만	
	자궁내막증진단	30만	5년간 40% 환자 급증
	자궁내막증진단(중증)	1백만	
	자궁내막증수술	50만	
여성 1-5종	여성생애주기 (50세 전후 종 변경) 1종/2종/3종/4종/5종	10만 / 10만 / 1백만 / 3백만 / 5백만	누적 없는 여성용 1-5종 업셀링

간편 3.10.10 (30년납 30년만기)

35세 여 33,910원 | 40세 여 35,470원

※ 기본계약 · 납면최소 · 암수술 1백만 포함 · *담보 10년 갱신 · 현대해상 판매자 교육자료(2026)의 플랜표를 MAKEONE이 글자 표로 다시 그린 것 — 보험료·담보 구성은 판매 시점 전산 설계가 정본, 상담 전 전산 재확인.

① 암 통합치료비Plus(기본형)

KB 고당지 맞춤 간편건강보험(세만기)(무배당)(26.07) — **암통합치료비Plus(기본형) 특별약관** 세부보장항목

구분	보장항목	보장항목별 대상질병	지급방식	기준 지급금액		
				보험가입금액 5천만원	보험가입금액 1억원	보험가입금액 1억5천만원
암 통합치료 (검사)	암 자기공명영상(MRI)검사(급여)	암(유사암제외) 및 유사암	연간1회한	5만원	10만원	10만원
	암 양전자방출단층촬영(PET)검사(급여)		연간1회한	5만원	5만원	5만원
	암 전산화단층촬영(CT)검사(급여)		연간1회한	5만원	5만원	5만원
	암 초음파(Ultrasonography)검사(급여)		연간1회한	5만원	5만원	5만원
	암 내시경검사(급여)		연간1회한	5만원	5만원	5만원
	암 특정단일유전자검사(급여)		연간1회한	5만원	5만원	5만원
	암 특정생검조직병리검사(급여)		연간1회한	10만원	20만원	20만원
	특정NGS유전자패널검사(급여)	암(유사암제외), 기타피부암 및 갑상선암	연간1회한	100만원	100만원	100만원
암 통합치료 (주요치료)	암(유사암제외) 수술	암(유사암제외)	수술1회당	500만원	1,000만원	1,500만원
	유사암 수술	유사암	수술1회당	100만원	200만원	300만원
	암(유사암제외) 항암방사선치료	암(유사암제외)	연간1회한	500만원	1,000만원	1,500만원
	유사암 항암방사선치료	유사암	연간1회한	100만원	200만원	300만원
	암(유사암제외) 항암약물치료(항암호르몬약물치료제외)	암(유사암제외)	연간1회한	500만원	1,000만원	1,500만원
	유사암 항암약물치료(항암호르몬약물치료제외)	유사암	연간1회한	100만원	200만원	300만원
	암(유사암제외) 항암호르몬약물치료	암(유사암제외)	연간1회한	50만원	100만원	150만원
	유사암 항암호르몬약물치료	유사암	연간1회한	10만원	20만원	30만원
	암(유사암제외) 중환자실치료	암(유사암제외)	연간1회한	250만원	500만원	750만원
	유사암 중환자실치료	유사암	연간1회한	50만원	100만원	150만원
	항암세기조절방사선치료	암(유사암제외), 기타피부암 및 갑상선암	연간1회한	500만원	750만원	1,000만원
암 통합치료 (비급여(전액본인부담 포함) 특정 주요치료)	비급여(전액본인부담 포함) 다빈치로봇 암수술(갑상선암및전립선암제외)	암(갑상선암및전립선암제외)	수술1회당	500만원	1,000만원	1,000만원
	비급여(전액본인부담 포함) 다빈치로봇 암수술(갑상선암및전립선암)	갑상선암 및 전립선암	수술1회당	100만원	200만원	200만원
	비급여(전액본인부담 포함) 표적항암약물허가치료(유사암제외)	암(유사암제외)	연간1회한	1,000만원	2,000만원	3,000만원
	비급여(전액본인부담 포함) 표적항암약물허가치료(기타피부암및갑상선암)	기타피부암 및 갑상선암	연간1회한	200만원	400만원	600만원
	비급여(전액본인부담 포함) 특정면역항암약물허가치료(유사암제외)	암(유사암제외)	연간1회한	1,000만원	2,000만원	3,000만원
	비급여(전액본인부담 포함) 특정면역항암약물허가치료(기타피부암및갑상선암)	기타피부암 및 갑상선암	연간1회한	200만원	400만원	600만원
	비급여(전액본인부담 포함) 항암양성자방사선치료(유사암제외)	암(유사암제외)	연간1회한	1,000만원	2,000만원	3,000만원
	비급여(전액본인부담 포함) 항암양성자방사선치료(기타피부암및갑상선암)	기타피부암 및 갑상선암	연간1회한	200만원	400만원	600만원
암 통합치료 (통증완화치료)	암특정통증완화치료(급여)	암(유사암제외)	연간1회한	30만원	40만원	50만원
암 통합치료 (재활치료)	입원 암재활치료(급여)	암(유사암제외), 기타피부암 및 갑상선암	연간30회한 (각각 1일1회)	2만원	2만원	2만원
	통원 암재활치료(급여)			2만원	2만원	2만원

주1) 보험금 지급 예시 및 보험금 지급 세부규정 등에 관한 보다 상세한 내용은 약관을 필히 확인하시기 바랍니다.
주2) 위 표는 **최초계약일부터 1년이상**의 계약 및 갱신된 계약의 기준 지급금액입니다. 1년 미만 지급비율은 가입상품·특별약관별로 다르므로 보험증권 가입내용 및 해당 약관을 확인하시기 바랍니다. **보험가입금액은 연간 총 지급한도**이며 개별 치료항목별 지급금액과 다릅니다.

② 비급여(전액본인부담 포함) 암 통합치료비Plus

KB 고당지 맞춤 간편건강보험(세만기)(무배당)(26.07) — **비급여(전액본인부담 포함) 암 통합치료비Plus 특별약관** 세부보장항목

구분	보장항목	보장항목별 대상질병	지급방식	기준 지급금액		
				보험가입금액 4천만원	보험가입금액 8천만원	보험가입금액 1억원
암 통합치료 (비급여(전액본인부담 포함) 주요치료)	비급여(전액본인부담 포함) 암수술(기타피부암및갑상선암제외)	암(기타피부암및갑상선암제외)	수술1회당	500만원	1,000만원	1,000만원
	비급여(전액본인부담 포함) 암수술(기타피부암및갑상선암)	기타피부암 및 갑상선암	수술1회당	100만원	200만원	200만원
	비급여(전액본인부담 포함) 항암방사선치료(기타피부암및갑상선암제외)	암(기타피부암및갑상선암제외)	연간1회한	500만원	1,000만원	1,000만원
	비급여(전액본인부담 포함) 항암방사선치료(기타피부암및갑상선암)	기타피부암 및 갑상선암	연간1회한	100만원	200만원	200만원
	비급여(전액본인부담 포함) 항암약물치료(기타피부암및갑상선암제외)	암(기타피부암및갑상선암제외)	연간1회한	500만원	1,000만원	1,000만원
	비급여(전액본인부담 포함) 항암약물치료(기타피부암및갑상선암)	기타피부암 및 갑상선암	연간1회한	100만원	200만원	200만원
암 통합치료 (비급여(전액본인부담 포함) 특정 주요치료)	비급여(전액본인부담 포함) 다빈치로봇 암수술(갑상선암및전립선암제외)	암(갑상선암및전립선암제외)	수술1회당	500만원	1,000만원	1,000만원
	비급여(전액본인부담 포함) 다빈치로봇 암수술(갑상선암및전립선암)	갑상선암 및 전립선암	수술1회당	100만원	200만원	200만원
	비급여(전액본인부담 포함) 표적항암약물허가치료(기타피부암및갑상선암제외)	암(기타피부암및갑상선암제외)	연간1회한	1,000만원	2,000만원	3,000만원
	비급여(전액본인부담 포함) 표적항암약물허가치료(기타피부암및갑상선암)	기타피부암 및 갑상선암	연간1회한	200만원	400만원	600만원
	비급여(전액본인부담 포함) 특정면역항암약물허가치료(기타피부암및갑상선암제외)	암(기타피부암및갑상선암제외)	연간1회한	1,000만원	2,000만원	3,000만원
	비급여(전액본인부담 포함) 특정면역항암약물허가치료(기타피부암및갑상선암)	기타피부암 및 갑상선암	연간1회한	200만원	400만원	600만원
	비급여(전액본인부담 포함) 항암양성자방사선치료(기타피부암및갑상선암제외)	암(기타피부암및갑상선암제외)	연간1회한	1,000만원	2,000만원	3,000만원
	비급여(전액본인부담 포함) 항암양성자방사선치료(기타피부암및갑상선암)	기타피부암 및 갑상선암	연간1회한	200만원	400만원	600만원

주1) 보험금 지급 예시 및 보험금 지급 세부규정 등에 관한 보다 상세한 내용은 약관을 필히 확인하시기 바랍니다.
주2) 위 표는 **최초계약일부터 1년이상**의 계약 및 갱신된 계약의 기준 지급금액입니다. 1년 미만 지급비율은 가입상품·특별약관별로 다르므로 보험증권 가입내용 및 해당 약관을 확인하시기 바랍니다. **보험가입금액은 연간 총 지급한도**이며 개별 치료항목별 지급금액과 다릅니다.

③ 신특정순환계질환 통합치료비Plus

KB 고당지 맞춤 간편건강보험(세만기)(무배당)(26.07) — **신특정순환계질환 통합치료비Plus 특별약관** 세부보장항목

구분	보장항목	지급방식	기준 지급금액				
			보험가입금액 1천만원	보험가입금액 3천만원	보험가입금액 5천만원	보험가입금액 8천만원	보험가입금액 1억원
신특정순환계질환 통합치료(검사)	자기공명영상(MRI)검사(급여)	연간1회한	5만원	5만원	5만원	10만원	10만원
	전산화단층촬영(CT)검사(급여)	연간1회한	5만원	5만원	5만원	5만원	5만원
	양전자방출단층촬영(PET)검사(급여)	연간1회한	5만원	5만원	5만원	5만원	5만원
신특정순환계질환 통합치료(주요치료)	지속적신대체요법(CRRT)(급여)	연간1회한	200만원	200만원	200만원	300만원	500만원
	인공호흡기(12시간초과)치료(급여)	연간1회한	100만원	100만원	100만원	150만원	200만원
	저체온요법치료(급여)	연간1회한	100만원	100만원	100만원	100만원	100만원
	에크모치료(체외순환막형산화요법)(급여)	연간1회한	500만원	1,000만원	1,000만원	1,500만원	2,000만원
	수술(혈전제거술 제외)	수술1회당	200만원	700만원	1,000만원	1,500만원	2,000만원
	혈전제거술	수술1회당	200만원	700만원	1,000만원	1,500만원	2,000만원
	뇌혈관질환 혈전용해치료	연간1회한	500만원	700만원	1,000만원	1,500만원	2,000만원
	허혈성심장질환 및 기타순환계질환 혈전용해치료	연간1회한	500만원	700만원	1,000만원	1,500만원	2,000만원
	종합병원 중환자실치료 (주3)	연간1회한	100만원	350만원	500만원	750만원	1,000만원
신특정순환계질환 통합치료(재활치료)	입원 신특정순환계질환 재활치료(급여)	연간20회한 (각각 1일1회)	2만원	2만원	2만원	2만원	2만원
	통원 신특정순환계질환재활치료(급여)		2만원	2만원	2만원	2만원	2만원
신특정순환계질환 통합치료(약물치료)	항응고제주사치료(급여)	연간1회한	50만원	50만원	50만원	50만원	50만원
	항혈소판제주사치료(급여)	연간1회한	50만원	50만원	50만원	100만원	100만원

주1) 보험금 지급 예시 및 보험금 지급 세부규정 등에 관한 보다 상세한 내용은 약관을 필히 확인하시기 바랍니다.

주2) 위 표는 **최초계약일부터 1년이상**의 계약 및 갱신된 계약의 기준 지급금액입니다. 1년 미만 지급비율은 가입상품·특별약관별로 다르므로 보험증권 가입내용 및 해당 약관을 확인하시기 바랍니다. **보험가입금액은 연간 총 지급한도**이며 개별 치료항목별 지급금액과 다릅니다.

주3) 단, 신특정순환계질환 통합치료비Plus(상급종합병원 및 권역심뇌혈관질환센터) 특별약관의 경우 "상급종합병원" 또는 "권역심뇌혈관질환센터"에서 받은 중환자실치료를 말합니다.

4 삼성화재 통합치료비

무배당 삼성화재 건강보험 마이스타0515(2601.7) — **암 전액본인부담(비급여포함) 통합치료비 · 특정순환계질환 통합치료비 특별약관** 세부보장항목

종합병원 암 전액본인부담(비급여포함) 통합치료비(표준형/실속형) 특별약관에 관한 사항

(단위 : 만원)

구분	치료행위		대상질병	지급방식	지급금액	
					표준형	실속형
암 통합치료 (전액본인부담 (비급여포함) 치료)	주요치료	수술	암(기타피부암 및 갑상선암 포함)	수술 1회당	1,000	1,000
		항암방사선치료	암(기타피부암 및 갑상선암 포함)	연 1회한	1,000	1,000
		항암약물치료	암(기타피부암 및 갑상선암 포함)	연 1회한	1,000	1,000
	특정치료	다빈치로봇 수술	암(특정암 제외)	연 1회한	1,000	1,000
			특정암	연 1회한	500	500
		항암양성자방사선치료	암(기타피부암 및 갑상선암 포함)	연 1회한	3,000	1,000
		표적항암약물허가치료	암(기타피부암 및 갑상선암 포함)	연 1회한	3,000	1,000
		특정면역항암약물허가치료	암(기타피부암 및 갑상선암 포함)	연 1회한	3,000	1,000
연 최대 한도					10,000	5,000

주1) 각 치료행위의 상세 내용 등에 관한 보다 자세한 내용은 약관을 통해 확인 바랍니다.
주2) 보장개시일(책임개시일)은 최초 계약일 또는 부활(효력회복)일부터 90일이 지난 날의 다음날로 합니다.
단, 피보험자의 보험나이가 15세 미만인 경우에는 계약일을 보장개시일(책임개시일)로 합니다.
주3) 특정암 : 전립선암, 갑상선암

종합병원 특정순환계질환 통합치료비(표준형/실속형) 특별약관에 관한 사항

(단위 : 만원)

구분	치료행위	지급방식	지급금액	
			표준형	실속형
검사	MRI촬영(급여)	연 1회한	10	5
	양전자단층촬영(PET)(급여)	연 1회한	10	5
	CT촬영(급여)	연 1회한	10	5
주요치료	수술(혈전제거술 제외)	수술 1회당	2,000	1,000
	혈전용해치료	연 1회한	2,000	1,000
	혈전제거술	연 1회한	2,000	1,000
입원	중환자실 입원	연 1회한	500	200
중증치료	에크모(ECMO)(급여)	연 1회한	2,000	1,000
	지속적 신대체요법(CRRT)(급여)	연 1회한	500	200
	인공호흡(12시간초과)(급여)	연 1회한	200	100
	저체온요법치료(급여)	연 1회한	100	50
약물치료	항응고제주사치료(급여)	연 1회한	50	50
	항혈소판제주사치료(급여)	연 1회한	100	50
재활치료	전문재활치료(급여)	연 1회한	50	50
연 최대 한도			10,000	5,000

주) 각 치료행위의 상세 내용 등에 관한 보다 자세한 내용은 약관을 통해 확인 바랍니다.

주) 각 치료행위의 상세 내용 등에 관한 보다 자세한 내용은 약관을 통해 확인 바랍니다. 표준형/실속형은 가입한 형태에 따라 지급금액이 다릅니다.

흥국화재 10억통장

[갱신형] 플래티넘 건강 리셋월렛II

보장한도 10억원 · 갱신마다 10억 리필(20년 갱신형)

구분	보장 내용	면책	감액	보장 금액
암	비급여 암 수술 (갑·기 포함) · 회당보장	90일	1년미만 50%	회당 1,000만
	비급여 항암 방사선 치료 (갑·기 포함)	90일	1년미만 50%	연간 5,000만
	비급여 항암 약물치료 (1~3기) (갑·기 포함)	90일	1년미만 50%	연간 5,000만
	비급여 항암 약물치료 (4기) (갑·기 포함)	90일	1년미만 50%	연간 1억
	암 중환자실 치료 (연 1회)	90일	×	연간 1,000만
2대 순환계	비급여 2대질병 수술 · 회당보장	×	1년미만 50%	회당 1,000만
	2대 질병 중환자실 치료 (연 1회)	×	×	연간 1,000만
	특정 순환계질환 수술비 (수술당) — 관혈	×	1년미만 50%	회당 500만
	특정 순환계질환 수술비 (수술당) — 비관혈	×	1년미만 50%	회당 500만
수술 입원	상급종합병원 질병수술비 (수술당)	×	×	회당 50만
	질병 1~5종 수술 동반 입원비III — 1종(1~2일)	×	×	10만
	질병 1~5종 수술 동반 입원비III — 2종(1~4일)	×	×	10만
	질병 1~5종 수술 동반 입원비III — 3종(1~6일)	×	×	10만
	질병 1~5종 수술 동반 입원비III — 4종(1~8일)	×	×	25만
	질병 1~5종 수술 동반 입원비III — 5종(1~10일)	×	×	50만
사망	상해사망 (선택가능)	×	×	잔고의 30%

갱신마다 10억 리필
20년 갱신형 · 1원이라도 남아있으면 10억 리필

비급여 / 급여 전액본인부담금 모두 보장
암 비급여는 전액 본인부담 포함

갑상선암·기타피부암도 일반암과 동일 보장
표의 (갑·기 포함) 담보에 적용

※ **면책 = 계약일(부활일)부터 90일 이내 미지급 · 감액 = 가입 후 1년 미만 발생 시 보험금의 50% 지급**(× = 해당 없음). 담보별 적용은 위 표 기준이며 자세한 내용은 약관을 따릅니다.

※ 가입하는 시기에 따라 보장내용이 상이하고 보험료가 변동될 수 있습니다. 해당 특약가입 시 자세한 보장내용은 약관을 참조하시기 바랍니다.
※ 기재된 특약은 선택특약으로 가입연령 및 플랜에 따라 상이할 수 있습니다. ※ 출처: 흥국화재 고객용 안내자료(준법감시인 확인필 260626-06-001 · 유효기간 2026.06.26~2027.06.25) — 기간 경과 시 갱신본으로 교체할 것.

뇌 · 심장, 병원비 5%가 안 되는 때 수술 · 시술한 날부터 30일만 5% — 그 밖은 내 돈

① 5%가 되는 때 · 안 되는 때

입원해서 수술 · 시술
30일만 5%

혈전제거 · 스텐트 · 판막 · 기기 삽입 · 코일 (재수술 30일 추가)

약만 먹는 치료
특례 없음

입원 20% · 외래 30~60% — 뇌경색의 약 85%가 약물치료

뇌경색 재개통 조건
4.5시간 · 24시간

혈전용해 4.5시간, 혈전제거 24시간 안에 도착해야 시술

뇌 MRI 횟수 넘기면
내 돈 80%

1년 1번×2년 → 2년에 1번 (최대 6년)

심장초음파 횟수 넘기면
내 돈 80%

심부전·심근경색·판막·선천성 = 1년 1번까지만

TAVI 판막 시술
5%·50%·80%

고위험·80세↑ 5% / 중위험 50% / 저위험 80% (약 2,700만)

② 그 뒤 수십 년 — 전부 내 돈

회복기 6개월 지난 재활
내 돈 대부분

회복기 재활병원 = 발병 90일 이내 입원 · 최대 6개월

간병인
내 돈 전부

월 평균 370만(보사연 2025 · 공동간병 80~100만)

요양병원 입원
20% → 40%

경증 환자 20%→40% · 선택입원군 40%→60% (2026.7 복지부 발표) · 간병비는 2027 시범급여 30%

ICD · CRT · 좌심방이 폐색 · 승모판 클립
조건 밖 내 돈

LAAO 선별급여 80%(환자 약 800만) · 승모판 클립 2026.7.31 급여: 수술불가 5% / 고위험 50% / 심방성 80%

치매 신약 레켐비
내 돈 전부

연 약 3,000만(검사 포함) · 비급여 · DBS는 급여 10%

TIA · 외상 출혈 · 고혈압성
특례 없음

산정특례 대상 아님 → 일반 본인부담

응급실 · 중환자실
비급여 몫 내 돈

상급병실 · 비급여 재료 · 구급차 일부

심장재활 횟수 넘기면
내 돈 전부

급여 횟수 상한 [확인] · 그 뒤 비급여

수술 뒤 외래 약값
30~60%

평생 약 · 산정특례 끝난 뒤는 일반 본인부담

돈 계산 예시 — 숫자는 가정(실제는 병원 견적) [예시]

뇌경색 후 간병인 1년
월 370만 × 12 = **4,440만** 전부 내 돈

회복기 뒤 요양병원
월 150~250만 × 몇 년 = **연 1,800~3,000만**

TAVI 저위험
본인부담 80% = **약 2,700만** (고위험이면 150만)

→ 보험으로 준비 : 간병인 · 재활 · 비급여 치료 · 뇌·심 진단비

현대해상 심뇌혈관질환 — 담보별 보장 범위 심장질환 분류표 · 질병코드 기준

어느 담보가 어느 병을 받는가 — 같은 심장병이라도 담보마다 범위가 다르다. 담보명이 아니라 **질병코드(I00~I52)**로 확인한다. ○ = 해당 담보 지급 범위.

구분	질병명	코드	주요치료비/생활비	특정 I (I49제외)	특정2대	특정 II	심장염증	허혈심장	산정특례
급성류마티스열	심장침범에 대한 언급이 없는 류마티스 열	I00	○						
	심장 침범이 있는 류마티스 열	I01	○						○
	류마티스무도병	I02	○						
만성 류마티스심장질환	류마티스성 승모판질환	I05	○						○
	류마티스성 대동맥판질환	I06	○						○
	류마티스성 삼첨판질환	I07	○						○
	다발판막질환	I08	○						○
	기타 류마티스심장질환	I09	○						○
허혈성 심장질환	협심증	I20	○	○				○	○
	급성심근경색증	I21	○			○		○	○
	후속심근경색증	I22	○			○		○	○
	급성심근경색증 후 특정 현존 합병증	I23	○			○		○	○
	기타 급성 허혈심장질환	I24	○	○				○	○
	만성 허혈심장병	I25	○	○				○	○
폐성 심장병 및 폐순환의 질환	폐색전증	I26	○						○
	기타 폐성 심장질환	I27	○						○
	폐혈관의 기타 질환	I28	○						○
기타 형태의 심장병	급성 심장막염	I30	○				○		○
	심장막의 기타질환	I31	○				○		○
	달리 분류된 질환에서의 심장막염	I32	○				○		○
	급성 및 아급성 심내막염	I33	○				○		○
	비류마티스성 승모판장애	I34	○						○
	비류마티스성 대동맥판장애	I35	○						○
	비류마티스성 삼첨판장애	I36	○						○
	폐동맥판 장애	I37	○						○
	상세불명 판막의 심내막염	I38	○				○		○
	달리분류된 질환에서의 심내막염 및 심장 판막장애	I39	○						○
	급성 심근염	I40	○				○		○
	달리 분류된 질환에서의 심근염	I41	○				○		○
	심근병증	I42	○						○
	달리 분류된 질환에서의 심근병증	I43	○						○
	방실차단 및 좌각차단	I44	○		I44.1~3				○
	기타 전도장애	I45	○		I45.2~3				○
	인공소생에 성공한 심장정지	I46	○			I46.0			○
	발작성 빈맥	I47	○	○					○
	심방세동 및 조동	I48	○	○					○
	기타 심장부정맥	I49	○		I49				○
	심부전	I50	○	○					○
	심장병의 불명확한 기록 및 합병증	I51	○						○
	달리분류된 질환에서의 기타 심장장애	I52	○						○
칸디다심내막염	칸디다심내막염	B37.6	○						
기타 세균성 질환	수막알균성 심장병	A39.5	○						
동맥,세동맥 및 모세혈관의 질환	대동맥의 죽상경화증	I70.0							○
	대동맥동맥류 및 박리	I71							○
	동맥, 세동맥 및 모세혈관의 장애	I79.0·I79.1							○
기타 괴사성 혈관병증	대동맥궁증후군[다까야수]	M31.4							○
순환계통의 선천기형	순환계통의 선천기형	Q20~Q25							○
	대정맥혈관의 선천기형	Q26.0·.4·.8·.9							○
양성신생물	심장의 양성 신생물	D15.1							○
흉부의 손상	흉곽 혈관의 손상, 심장의 손상	S25~S26							○

특정 I (I49제외) = 협심증 I20 · 기타 급성 허혈 I24 · 만성 허혈 I25 · 발작성 빈맥 I47 · 심방세동 I48 · 심부전 I50 — **급성심근경색은 들어가지 않는다.**

특정 II = 급성심근경색 I21·I22·I23 + 인공소생에 성공한 심장정지 I46.0. **허혈심장** = I20~I25 전부(협심증+급성심근 둘 다).

특정2대 = 전도장애 I44.1~3 · I45.2~3 + **기타 심장부정맥 I49. 심장염증** = I30~I33 · I38 · I40 · I41. **주요치료비/생활비**는 I00~I52 전체(혈관·선천기형 제외).

※ 현대해상 판매자 교육자료(AM2603-5 · 2026.3.19~2027.3.18)의 분류표를 MAKEONE이 글자 표로 다시 그린 것 · 세부 보장 내용과 지급 조건은 약관이 정한다 · 심근병증(I42·I43)은 현대해상 별도 담보 없음 — 주요치료비·산정특례로만 본다.

순환계 한눈에 정리

혈액은 온몸을 돌며 생명을 연결한다 — 심장 · 혈관 · 혈액 구조와 순환 경로

순환계 한눈에 정리!

혈액은 온몸을 돌며 생명을 연결한다!

순환계란?

심장, 혈관, 혈액으로 구성되어
산소, 영양소, 노폐물 등을
온몸으로 운반하는 기관계

심장 → 혈관 → 혈액

심장의 구조

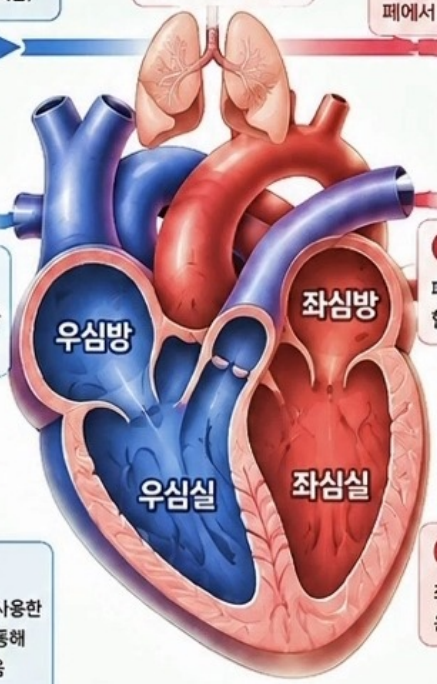
심장은 4개의 방으로 이루어져
혈액을 순환시킨다!

- **우심방** — 온몸에서 온 혈액을 받음
- **좌심방** — 폐에서 온 혈액을 받음
- **우심실** — 폐로 혈액을 보냄
- **좌심실** — 온몸으로 혈액을 보냄

★ 좌심실의 근육이 가장 두껍다!
→ 온몸으로 혈액을 보내야 하기 때문에!

혈액의 이동 경로

폐순환 (심장 → 폐 → 심장) / **체순환** (심장 → 온몸 → 심장)



1. **온몸** — 온몸의 조직에서 사용한 혈액이 대정맥을 통해 우심방으로 돌아옴 (산소 적음)
2. **우심실** — 우심방에서 온 혈액을 폐로 보냄
3. **폐동맥** — 우심실에서 나온 혈액이 폐로 이동 (산소 적음)
4. **폐** — 폐에서 산소를 얻고 이산화탄소를 배출!
5. **폐정맥** — 산소가 많아진 혈액이 폐에서 심장으로 이동
6. **좌심방** — 폐정맥을 통해 들어온 혈액을 받음
7. **좌심실** — 좌심방에서 온 혈액을 온몸으로 보냄
8. **대동맥** — 산소와 영양소를 공급하고 이산화탄소와 노폐물
9. **온몸의 조직** — 산소와 영양소를 공급하고 온몸으로 이동

동맥 vs 정맥

동맥과 정맥의 기준은
'산소량'이 아니라
'심장을 기준으로 이동 방향!'

동맥 (심장에서 나가는 혈관)



- 대부분 산소가 많은 혈액
- 폐동맥은 예외!
  (산소가 적지만 동맥)

정맥 (심장으로 들어오는 혈관)



- 대부분 산소가 적은 혈액
- 폐정맥은 예외!
  (산소가 많지만 정맥)

모세혈관

동맥과 정맥 사이에 있는
아주 가느다란 혈관!
혈액과 조직 사이에서
물질 교환이 일어난다.



- 산소, 영양소 → 세포
- 이산화탄소, 노폐물 → 혈액

혈액의 구성



혈액 = 혈장 + 혈구

혈장 (약 55%)	적혈구 (약 45%)	백혈구 (소수)	혈소판 (소수)
혈액의 액체 성분	산소 운반	면역 작용	혈액 응고
• 영양소, 이산화탄소, 노폐물, 호르몬 등 여러 물질을 운반	• 헤모글로빈이 산소와 결합하여 온몸으로 운반	• 식균 작용 등으로 세균, 이물질을 제거하여 우리 몸을 보호	• 상처가 났을 때 피가 계속 흐르지 않도록 도와줌

핵심 정리 10가지!

1. 순환계 = 심장 + 혈관 + 혈액
2. 심장은 혈액을 순환시키는 펌프
3. 심장은 심방 2개 + 심실 2개
4. 오른쪽 심실 → 폐
5. 왼쪽 심실 → 온몸
6. 폐순환 = 심장 → 폐 → 심장
7. 체순환 = 심장 → 온몸 → 심장
8. 동맥 = 심장에서 나가는 혈관
9. 정맥 = 심장으로 들어오는 [illegible]
10. 모세혈관 = 물질 교환이 일[illegible]

혈액은 생명의 택배! 우리 몸의 모든 곳을 연결한다!

보험사별 심혈관 담보 분류

보험사별 심혈관 담보 분류

상담용 · BARUM 실제 판매담보 기준 ① 손해보험 (1/4)

★ **"특정 Ⅰ·Ⅱ"는 회사마다 뜻이 다릅니다 — 라벨 말고 질병코드로 확인.** 롯데 특정 Ⅰ =급성심근경색 / 흥국 특정심혈관=협심증·허혈·빈맥·심부전(급성심근아님) / 한화·NH 특정 Ⅰ =협심증·허혈·빈맥·부정맥·심부전 / DB 특정 Ⅰ =협심증·허혈·염증 / KB 특정 Ⅰ =협심증·허혈·빈맥·심부전·염증(심장판막은 별도 가입 담보) / 현대 특정 Ⅰ =협심증·빈맥·심부전(허혈 I24·25는 별도 허혈성 담보). 빈맥(I47·48)과 부정맥(I49)은 별개.

한화손해보험 4가지

심혈관 Ⅰ	심혈관 Ⅱ	심근병증	심혈관특정질환
협심증 I20	급성 심근경색증 I21	심근병증 I42	협심증 I20
기타 급성 허혈심장질환 I24	후속 심근경색증 I22	확장성 심근병증 I42.0	기타 급성 허혈심장질환 I24
만성 허혈성심장병 I25	급성 심근경색 후 특정 현존 합병증 I23	비후성 심근병증 I42.1	만성 허혈성심장병 I25
발작성 빈맥 I47	인공소생에 성공한 심장정지 I46.0	제한성 심근병증 I42.2	발작성 빈맥 I47
심방세동 및 조동 I48		기타 심근병증 I42.8	심방세동 및 조동 I48
기타 심장부정맥 I49		상세불명의 심근병증 I42.9	심부전 I50
심부전 I50			※ 기타 심장부정맥(I49) 제외

DB손해보험 4가지

특정 Ⅰ	특정 Ⅱ	특정Ⅲ	순환계 3대질환
협심증 I20	급성 심근경색증 I21	판막질환 —	인공소생에 성공한 심장정지 I46.0
기타 급성 허혈심장질환 I24	후속 심근경색증 I22	발작성 빈맥 I47	부정맥 I47~I49
만성 허혈성심장병 I25	급성 심근경색 후 특정 현존 합병증 I23	심방세동 및 조동 I48	심부전 I50
급성 심장막염 I30	인공소생에 성공한 심장정지 I46.0	심부전 I50	※ 세부 범위는 약관 참조
심장막의 기타질환 I31			
달리 분류된 질환의 심장막염 I32			
급성·아급성 심내막염 I33			
상세불명 판막 심내막염 I38.9			
급성 심근염 I40			
달리 분류된 질환의 심근염 I41			

보험사별 심혈관 담보 분류 상담용 · BARUM 실제 판매담보 기준 ② 손해보험 (2/4)

★ 색: 허혈·협심 / 급성심근 / 심근병 / 염증 / 부정맥·전도 / 판막. 빈맥(I47·48)과 부정맥(I49)은 별개.

KB손해보험 5가지

특정 I	특정 II	심근병증	심장판막질환
협심증 I20	급성 심근경색증 I21	심근병증 I42	판막질환 —
기타 급성 허혈심장질환 I24	후속 심근경색증 I22	확장성 심근병증 I42.0	상세불명의 판막질환 I38
만성 허혈성심장병 I25	급성 심근경색 후 특정 현존 합병증 I23	비후성 심근병증 I42.1	※ KB 별도 가입 담보
발작성 빈맥 I47	인공소생에 성공한 심장정지 I46.0	제한성 심근병증 I42.2	※ 세부 범위는 약관 참조
심방세동 및 조동 I48		기타 심근병증 I42.8	
심부전 I50		상세불명의 심근병증 I42.9	
심장막염 I30~I32			
심내막염 I33·I38.9			
심근염 I40·I41			

기타심장부정맥(I49)
기타 심장부정맥 I49
※ I47·I48은 해당 담보 대상 아님

현대해상 6가지 ※심근병증 담보 없음

허혈성 심장질환	특정허혈 심장질환	특정 I	특정 II
협심증 I20	급성 심근경색증 I21	협심증 I20	급성 심근경색증 I21
기타 급성 허혈심장질환 I24	후속 심근경색증 I22	발작성 빈맥 I47	후속 심근경색증 I22
만성 허혈성심장병 I25	급성 심근경색 후 특정 현존 합병증 I23	심방세동 및 조동 I48	급성 심근경색 후 특정 현존 합병증 I23
		심부전 I50	인공소생에 성공한 심장정지 I46.0

주요 심장염증	특정 2대 + 기타심장부정맥(I49)
급성 심장막염 I30	방실차단 2도 I44.1
심장막의 기타질환 I31	완전방실차단 I44.2
달리 분류된 질환의 심장막염 I32	기타·상세불명 심방실차단 I44.3
급성·아급성 심내막염 I33	이중섬유속차단 I45.2
상세불명 판막 심내막염 I38.9	삼중섬유속차단 I45.3
급성 심근염 I40	기타 심장부정맥 I49
달리 분류된 질환의 심근염 I41	※ I47·I48은 대상 아님

보험사별 심혈관 담보 분류

보험사별 심혈관 담보 분류 상담용 · BARUM 실제 판매담보 기준 ③ 손해보험 (3/4)

★ 삼성·메리츠는 허혈성심장질환을 6가지로 세분(급성기·후속·합병증·협심증·기타급성·만성). 롯데 특정심장 I =급성심근경색 / 흥국은 특정심혈관질환(기타부정맥제외)=협심·허혈·빈맥·심부전(급성심근 아님). 색: 허혈·협심 / 급성심근 / 심근병 / 염증 / 부정맥·전도 / 판막.

NH농협손해보험 5가지

심혈관질환특정 I	특정 I (기타부정맥 제외)	심근병증	주요 심장염증질환
협심증 I20	협심증 I20	심근병증 I42	급성 심낭염 I30
기타 급성 허혈심장질환 I24	기타 급성 허혈심장질환 I24	달리 분류된 질환의 심근병증 I43	기타 심장막염 I31
만성 허혈성심장병 I25	만성 허혈성심장병 I25		달리 분류된 질환의 심장막염 I32
발작성 빈맥 I47	발작성 빈맥 I47		급성·아급성 심내막염 I33
심방세동 및 조동 I48	심방세동 및 조동 I48		상세불명의 심내막염 I38
기타 심장부정맥 I49	심부전 I50		급성 심근염 I40
심부전 I50	※ I49 제외		달리 분류된 질환의 심근염 I41

기타 심장부정맥
기타 심장부정맥 I49

삼성화재 (허혈성심장질환) 6가지

허혈성 심장질환
급성기: 급성 심근경색증(STEMI/NSTEMI) I21
후속기: 후속 심근경색증 I22
합병증: 급성 심근경색 후 합병증 I23
협심증 I20
기타급성: 기타 급성 허혈성심장질환 I24
만성: 만성 허혈성심장병 I25

메리츠화재 (허혈성심장질환) 6가지

허혈성 심장질환	+ 기존 심장진단
급성기: 급성 심근경색증(STEMI/NSTEMI) I21	심장질환진단 I → 허혈성
후속기: 후속 심근경색증 I22	심장질환진단 II → 급성심근
합병증: 급성 심근경색 후 합병증 I23	(별도 상품 병존)
협심증 I20	
기타급성: 기타 급성 허혈성심장질환 I24	
만성: 만성 허혈성심장병 I25	

보험사별 심혈관 담보 분류

보험사별 심혈관 담보 분류 상담용 · BARUM 실제 판매담보 기준 ④ 손해보험 (4/4)

★ 색: 허혈·협심 / 급성심근 / 심근병 / 염증 / 부정맥·전도 / 판막. 빈맥(I47·48)과 부정맥(I49)은 별개.

흥국화재 실제 약관

특정심혈관질환(기타부정맥 제외)

- 협심증 I20
- 기타 급성 허혈심장질환 I24
- 만성 허혈성심장병 I25
- 발작성 빈맥 I47
- 심방세동 및 조동 I48
- 심부전 I50

특정심혈관질환(기타부정맥)

- 기타 심장부정맥 I49

심근병증(허혈성제외)

- 심근병증 I42
- 달리 분류된 질환의 심근병증 I43

주요심장염증질환

- 급성 심장막염 I30
- 심장막의 기타질환 I31
- 달리 분류된 질환의 심장막염 I32
- 급성·아급성 심내막염 I33
- 상세불명 판막의 심내막염 I38
- 급성 심근염 I40
- 달리 분류된 질환의 심근염 I41

허혈성심질환진단비

- 협심증 I20
- 기타 급성 허혈심장질환 I24
- 만성 허혈성심장병 I25

롯데손해보험 5가지

특정심장질환 I

- 급성 심근경색증 I21
- 후속 심근경색증 I22
- 급성 심근경색 후 특정 현존 합병증 I23
- 인공소생에 성공한 심장정지 I46.0

특정심장질환 II

- 협심증 I20
- 기타 급성 허혈성심장질환 I24
- 만성 허혈성심장병 I25
- 주요 심장염증 I30~I41

특정 15대 심장질환

- 판막질환 I05~I09·I34~I39
- 심근병증 I42~I43
- 발작성 빈맥 I47
- 심방세동 및 조동 I48
- 심부전 I50

기타 심장부정맥

- 기타 심장부정맥 I49

방실차단 및 전도장애

- 방실차단 2도 I44.1
- 방실차단 3도 I44.2
- 기타·상세불명 방실차단 I44.3
- 이중섬유속차단 I45.2
- 삼중섬유속차단 I45.3

국민건강보험공단 지원제도

① 중증질환 산정특례제도 — 치료비 줄이고 ▶ ② 본인부담금 상한제 — 초과분 돌려받고 ▶ ③ 재난적 의료비 지원제도 — 그래도 부담 크면 추가지원

① 중증질환 산정특례제도

구분	암	뇌혈관 질환	심장 질환	중증 화상	중증 외상	중증 치매	희귀 질환	결핵
본인부담률	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	0%
적용기간	5년	최대30일 (입원)	최대30일	1년	최대30일 (입원)	5년	5년	치료 기간

제도 설명

중증질환으로 **확진**되면 그 질환 치료의 **건강보험 급여** 본인부담률을 원래 20~30%에서 **5~10%로 낮춰**준다. 병원비를 깎는 게 아니라 **내가 낼 몫의 비율**을 줄이는 제도다. 의사가 확진하면 **병원이 공단에 등록 신청을 대행**한다. 해당 질환과 관련된 **외래 · 입원 · 수술 · 검사 · 약제**가 모두 포함된다.

제외사항 (여기는 안 깎인다)

비급여 · 선별급여 · 급여 전액본인부담금 · 2 · 3인실 입원료 · 식대 등 · 해당 질환과 무관한 진료

★ 산정특례는 급여만 깎아준다. 표적항암 · 로봇수술 · 상급병실 같은 비급여는 그대로 100% 내 돈이다.

■ 상담 화법 "산정특례 되면 병원비 5%만 낸다고 아시죠? 그건 급여만입니다. 표적항암 한 달 수백만 원은 비급여라 5%가 아니라 100% 내십니다."

② 본인부담금 상한제

분위	연간상한액	직장보험료	지역보험료
1	89만원	52,850원 이하	11,430원 이하
2~3	110만원	52,850~75,080	11,430~18,530
4~5	170만원	75,080~107,400	18,530~39,280
6~7	320만원	107,400~154,000	39,280~104,000
8	437만원	154,000~195,000	104,000~143,000
9	525만원	195,000~266,000	143,000~224,000
10	826만원	266,000 초과	224,000 초과

제도 설명

한 해 동안 낸 **급여 본인부담금**을 모두 합쳐 소득분위별 상한액을 넘으면 **초과분을 공단이 환급**한다. 병원별이 아니라 **1년 총액** 기준이고, 분위는 **월 보험료**로 정해진다 — 고객 보험료를 보면 상한액이 바로 나온다. (표는 2025년 기준 · 2026년은 1분위 90만 · 10분위 843만)

제외사항 (상한액 계산에 안 들어간다)

비급여 · 선별급여 · 전액본인부담금 · 임플란트 · 2 · 3인실 입원료 · 추나요법 · 상급종합병원 경증질환 외래 본인부담금 · 요양병원 **120일 초과** 입원은 별도 상한 적용

★ 상한제로 돌려받은 돈은 실손에서 못 받는다.

■ 상담 화법 "연말에 공단에서 환급금이 나오면 좋은 일이죠. 그런데 그 금액만큼 실손에서는 빠집니다. 두 번 받는 건 안 됩니다."

본인부담상한제 × 실손의료비

구분	판단 기준	실무
상한제 초과 환급액	공단 부담분	실손 지급 대상 아님
보험금 계산	내가 최종 부담한 금액만 보상	청구액 − 환급금 = 최종 실손보험금
이미 받은 경우	이득금지 원칙	과다 지급분 반환 의무
적용 범위	대법원 2023다283913 (2024.1.25)	1세대 ~ 4세대 공통

재난적 의료비 · 실손 관계

3 재난적 의료비 지원제도

가구원	1인	2인	3인	4인	5인	6인
중위소득(월)	2,392,013	3,932,658	5,025,353	6,097,773	7,108,192	8,064,805

중위소득	연간의료비 부담액		지원비율
	1인 가구	2인 이상	
기초수급자 · 차상위	80만원		80%
50% 이하	120만원	160만원	70%
50~70% 이하	180만원	210만원	60%
70~85% 이하	220만원	310만원	
85~100% 이하	260만원	440만원	
100~200% 이하	개별심사 대상		50%

제도 설명

요건 — 가구기준 **재산세 과세표준 7억 이하, 연간소득 100% 이하**, 연간소득의 **10% 초과** 의료비 발생 시 5,000만원 한도로 지원.

지원금액 계산 = 지원대상항목 − (지원제외 + **실비보상금액** + 지자체지원금액) × 지원비율

지원 대상 항목 / 제외사항

대상 급여 전액본인부담금 · 비급여 · 선별급여 · 2·3인실 입원료
제외 미용 · 성형 · 비만치료 · 간병비 · 생활비 · 건강관리 목적

★ 재난적 의료비는 비급여도 본다. 단 미용 · 성형 · 간병비는 빠진다.

■ **상담 화법** "이건 소득 대비로 봅니다. 재산 7억 넘거나 소득이 높으면 대상이 아닙니다. 되더라도 간병비 · 생활비는 안 나옵니다."

건강검진 병을 미리 찾는다

질병 **조기 발견** 목적. 연령 · 직장/지역 가입 유형에 따라 **주기**가 다르다 [공단 안내 확인]

★ 확진이 나오면 그때부터 가입이 어려워진다. 가입은 검진 전에.

상병수당 시범사업

아파서 못 버는 기간의 소득 보전. 직전 3개월 **평균임금의 60%**, 지급액 **49,540~68,100원** [단위·최신액 확인]. 지역가입자는 정액.

★ 거주지 · 병원이 시범사업 대상이어야 받는다.

면책 — 나라 제도와 보험의 결정적 차이

구분	공단 지원제도	보험(진단비·치료비)
면책기간	없다 — 확진 즉시 적용	있다 — 가입 후 90일 등
감액기간	없다	유병자 1년 미만 50% 건강체·어린이는 즉시보장
가입 조건	건강보험 가입자면 자동	건강할 때만 가입 가능
비급여	거의 안 본다	정액 담보로 커버

■ **상담 화법** "나라 제도는 면책이 없습니다. 아프면 그날부터 적용됩니다. 그런데 보험은 면책 90일 · 감액 1년이 있고, 아프고 나면 가입 자체가 안 됩니다. 나라가 안 봐주는 비급여를 메우려면 건강할 때 미리 넣어두셔야 합니다."

외래 300회 초과 → 병원비 90% 본인부담

① 외래진료 300회 초과 시 90% 적용 핵심 2027.01.01 전면 시행

1 **시행일자**
2027년 1월 1일부터 전면 시행

2 **누적 기간**
매년 1월 1일 ~ 12월 31일 · 1년간 **전국 병의원 외래 횟수 합산**

3 **적용 시점**
300회까지는 정상 본인부담률 · **301회째 진료부터 90% 적용**

₩ **체감 병원비 변화**
평소 3,000~5,000원 내던 진료비가 **1만~2만원 이상**으로 증가할 수 있습니다.

300회 vs 301회 이후

300회까지	301회부터
(기존과 동일) 건강보험 지원 정상 본인부담률	건강보험 지원 10% 본인부담 90%
평소와 같은 진료비	병원비 4배 이상 증가 가능

② 90% 적용 예외 대상은?

아동 및 임산부 (전면 제외)
18세 미만 소아·청소년, 임신·출산 진료 임산부 — 횟수 제한 없이 90% 적용 제외

중증·희귀·난치질환자 (산정특례)
암, 뇌혈관, 심장질환, 중증난치질환 등 산정특례 등록 환자 (해당 질환 외래 진료 시)

중증장애인
등록 장애인 중 산정특례 등 법적 요건 충족 시 예외 인정
단순 장애 등록만으로는 자동 제외 안 됨

의학적 필요 환자
불가피하게 진료 횟수가 늘어난 경우 건강보험공단 심의를 거쳐 예외 인정

③ 외래진료 횟수, 이렇게 계산됩니다

모든 병의원 합산
의원, 병원, 종합병원, 치과, 한의원 등 **전국 모든 의료기관** 외래 통원 횟수 합산

하루 여러 과 진료는 각각 1회
오전 내과·오후 정형외과 = **2회** · 같은 병원이라도 과를 달리하면 각각 1회 · 진료 청구 건별로 개별 카운트

입원 치료는 제외
며칠씩 병실에 있는 '입원'은 외래진료 300회에 포함되지 않습니다.

내 진료 횟수 확인법
국민건강보험공단 홈페이지 또는 스마트폰 **'The건강보험'** 앱에서 올해 외래진료 횟수를 실시간 조회

④ 실비보험 있으면 90% 다 돌려받을 수 있을까? 실손보험과 건강보험은 별개 제도입니다

구분	300회 이내	301회 이후
급여 본인부담	건보 본인부담률 (의원 30% 안팎)	90%
5세대 급여 통원 공제	Max[의원1만 / 상급·종합2만, 20%, **건보 본인부담률**]	본인부담률 90%가 그대로 공제로 잡힌다 → 사실상 거의 못 받는다
통원 1회 한도	급여 통원 회당 **20만원**(5천만 가입 기준) · 비중증 비급여 통원 1일 20만원 — **초과분은 본인 부담**	
본인부담상한제	연말 정산에 합산	301회 이후 90% 진료비는 합산에서 제외될 가능성
4세대와 차이	4세대는 급여 통원 공제가 **20% 고정**이라 90% 적용의 타격이 작다 — **5세대가 더 불리**	
산정특례 고객	해당 질환 외래는 300회 계산에서 제외 · 5세대에서도 중증(특약1)으로 보장 — 두 제도 모두 유리	

■ 상담 화법 "2027년부터 1년에 외래 300번을 넘기면 301번째부터 병원비의 90%를 본인이 냅니다. 5세대 실손은 그 90%를 공제로 그대로 빼기 때문에 사실상 못 받습니다. 산정특례 등록 질환 진료는 횟수에서 빠지니 그건 안심하셔도 됩니다."

※ 출처: 국민건강보험 과다 의료이용 관리방안(2027.01.01 시행). 제도 세부는 시행 전 변경될 수 있습니다.

급여 통원 자기부담금 — 기준은 '건강보험 본인부담률'

4세대 2가지 → 5세대 3가지 건강보험 본인부담률 연동





★ 4세대는 ① 병원별 공제금액(최소 1만원) ② 보장대상 의료비의 20% — 둘 중 큰 금액. 5세대는 여기에 ③ 의료비 × 건강보험 본인부담률이 붙어 셋 중 큰 금액이 된다. 새로 붙은 것은 ③ 하나뿐이고, 이것 때문에 큰 병원 영수증일수록 돌려받는 돈이 줄어든다.

약관 원문 자기부담금 조항 · 건강보험 본인부담률 산출식

구 분	담보명		자기부담금
기본형 (급여)	상해 급여	입원	급여 본인부담금의 20% (연간 상해급여와 질병급여 합산하여 부당상한 200만원)
		통원	병원별 공제금액(1~2만원), 보장대상 의료비의 20%, 보장대상 의료비에 건강보험 본인부담률을 곱한 금액 중 큰 금액
	질병 급여	입원	급여 본인부담금의 20% (연간 상해급여와 질병급여 합산하여 부당상한 200만원)
		통원	병원별 공제금액(1~2만원), 보장대상 의료비의 20%, 보장대상 의료비에 건강보험 본인부담률을 곱한 금액 중 큰 금액

) 건강보험 본인부담률은 진료비 및 약제비 계산서 · 영수증 상 '급여 일부 본인부담 항목의 급여 본인부담금' 을 '급여 일부 본인부담 항목의 급여 본인부담금' 과 '급여 공단부담금' 의 합계액으로 나누어 산출한 값을 말합니다.

건강보험 본인부담률 =

$$\frac{\text{급여 일부 본인부담 항목의 본인부담금 합계 금액}}{(\text{급여 일부 본인부담 항목의 본인부담금 합계 금액} + \text{급여 공단부담금 합계 금액})}$$

다만, 「국민건강보험법 시행규칙」 제16조 및 별표6에 따라 요양급여비용의 본인부담률이 100분의100 및 「의료급여법 시행령」 제13조 및 별표1에 따라 의료급여비용의 본인부담률이 100분의100(전액본인부담)인 경우, 해당 금액은 상기 계산식에 포함되지 않으며 보상하는 대상에서 제외됩니다.

계산식 제외 요양급여비용 본인부담률이 100분의100(전액본인부담)인 금액은 산출식에 포함되지 않으며 보상 대상에서도 제외된다. ★ 병원 등급표가 아니라 그 영수증의 두 숫자로 매번 계산된다.

실제 영수증 2건 · 보험금 계산 같은 급여인데 부담률이 4배 넘게 벌어진다

영수증 (진찰료)	본인부담금	공단부담금	일부 본인부담 총액	본인부담률
상급종합병원	20,978	3,252	24,230	86.5%
일반 병 · 의원	3,434	13,736	17,170	20.0%

통원 급여 의료비 100,420원 · 부담률 30% · 의원급	공제 후보	5세대	4세대
① 병원별 공제금액 (의원급)	10,000	공제 30,126 보험금 70,294원	공제 20,084 보험금 80,336원
② 보장대상 의료비의 20%	20,084		
③ 의료비 × 건강보험 본인부담률 30%	30,126 ← 최대		
차액 — 같은 진료 · 같은 영수증	5세대가 10,042원 덜 받는다		

■ 상담 화법 "5세대는 영수증에 찍힌 본인부담률만큼 공제합니다. 동네 의원은 20% 안팎이라 그대로인데, 상급종합병원 영수증은 80%가 넘게 찍히기도 합니다. 그러면 통원 급여는 거의 안 나옵니다."

5세대 실손 — 쉽게 딱 3가지만

1 병원비는 두 종류다

급여
건강보험이 도와주는 치료
감기 · 수술 · 입원 등 대부분

비급여
건강보험이 안 도와주는 치료
도수치료 · MRI · 영양주사 등

5세대는 이 둘을 따로따로 계산한다. 예전엔 뭉뚱그렸다.

2 급여 통원 — 큰 병원 갈수록 내 돈이 커진다

30% 의원 동네병원 → 40% 병원 → 50% 종합병원 → 60% 대학병원 → 90% 권역응급 경증

통원(외래)만 해당. 입원은 어느 병원이든 20%로 똑같다.
※ 4세대는 병원 상관없이 20%였다 → 5세대는 대학병원 가면 60%를 내가 낸다.

■ 내가 낸 급여 본인부담금 10만원 기준 — 직접 계산해보면

동네 의원	병원	종합병원	대학병원	권역응급 (경증 KTAS4·5)
건보 부담률 30%	건보 부담률 40%	건보 부담률 50%	건보 부담률 60%	건보 부담률 90%
내 부담 3만원	내 부담 4만원	내 부담 5만원	내 부담 6만원	내 부담 9만원
돌려받는 돈 7만원	돌려받는 돈 6만원	돌려받는 돈 5만원	돌려받는 돈 4만원	돌려받는 돈 1만원
√ 가장 유리	√ 무난	※ 절반만	※ 주의	× 거의 없음

4세대였다면? 어느 병원이든 내 부담 2만원 → 돌려받는 돈 8만원 | × 권역응급 경증: 청구해도 1만원만!

※ 90%는 응급실 아무 데나가 아니다. 권역응급의료센터급 대형병원 응급실(권역응급·전문응급·권역외상센터)에 경증(KTAS 4)·비응급(KTAS 5)으로 갔을 때만. 지역응급의료센터는 비응급(KTAS 5)만. 중증(KTAS 1~3)이면 90% 아님 — 그 병원 등급 요율(종합 50·상급종합 60) 적용. 동네 병·의원 응급실은 해당 없음.

★ 한 줄로 외우세요

"급여는 큰 병원 갈수록 내 돈이 커진다. 비급여는 큰 병이냐 아니냐로 갈린다."

급여(건보 적용) = 병원 규모로 갈린다 — 동네의원 30%, 대학병원 60%, 권역응급의료센터급 대형병원 응급실 경증 90%.
비급여 = 중증(30%) vs 비중증(50%)으로 갈린다 → 다음 장에서 상세히 본다.

★ 5세대가 좋아진 것 — 신규 보장 3가지 (1~4세대에는 없던 것)
① 임신·출산 급여의료비 = 신규 보장 (1~4세대 전부 미보장) · ② 발달장애 급여의료비 = 신규 보장 (18세까지) · ③ 중증 입원 자기부담 상한 연 500만원 신설 (암·뇌·심장 산정특례, 상급종합·종합 입원 시 500만 초과분 전액 보장 — 4세대는 상한 없이 30% 무한 부담)
※ 습관성유산·불임·인공수정 합병증 = 1~3세대 면책 → 4세대부터 급여 보상(가입 2년 이후) → 5세대 급여 보상. 난임 상담 시 세대 확인 필수.

MRI · 도수 · 비급여주사 — 셋이 전부 다르다

① 한 장 요약 5세대 · 비중증(특약2) 기준

MRI 자기공명영상진단	도수·체외·증식 근골격계 이학요법	비급여 주사제 영양주사 등
연 200만 비중증도 **보장된다** · 별도 담보	**보장 제외** 비중증이면 실손에서 **안 나온다**	**0원** 비중증이면 한 푼도 안 나온다
비중증 → 보장 ○	**비중증 → 보장 ×**	**비중증 → 보장 ×**
공제 **Max[5만, 50%]**	**도수만** 2026.07.01 **관리급여** 전환 1회 **43,850원** · 건보 본인부담률 **95%**	**급여 전환 없음** — 여전히 비급여라 급여 경로도 없다
한도 **연 200만** (가입금액 2백만)	**→ 급여 통원** 규칙으로 계산 Max[건보율 95%, 20%, 병원공제 1~2만] 공제	입원해도 안 나온다
통원 회당 20만 한도 없음 — 별도 담보라 안 걸린다	체외충격파·증식치료는 비급여 그대로 0원	금융위 2026.5.6 개편 — 비급여 주사제·미등재 신의료기술 보장 제외
중증(산정특례) → 3대비급여 안	**중증(산정특례) → 3대비급여 안**	**중증(산정특례) → 3대비급여 안**
공제 Max[3만, 30%] · **연 300만**	공제 Max[3만, 30%] · **연 350만** · **50회** (최초 10회 후 10회 단위)	공제 Max[3만, 30%] · **연 250만** · **50회**

② 4세대와 비교 같은 치료, 세대가 바뀌면

항목	4세대	5세대 비중증	5세대 중증
MRI	연 300만 · Max[3만,30%]	연 200만 · Max[5만,50%]	연 300만 · Max[3만,30%]
도수·체외·증식	연 350만 · 50회	보장 제외 (도수는 급여 통원)	연 350만 · 50회
비급여 주사	연 250만 · 50회	보장 제외 · 0원	연 250만 · 50회
비급여 자기부담	30% · 최소 3만	50% · 최소 5만	30% · 최소 3만

MRI 50만원을 받았다면
중증 50 − Max[15만, 3만] = **35만**
비중증 50 − Max[25만, 5만] = **25만**
입원·통원 값이 같다 — MRI엔 통원 20만 한도가 없다.

2부위·2회 규칙
1회 통원(또는 1회 입원)에 **2개 이상 부위**이거나 같은 부위 **2회 이상**이면 각 진단행위를 **각각 1회**로 보아 회당 공제·한도를 각각 적용한다.

주의 95%는 실손 공제율이 아니다
도수 **95%**는 **건강보험 본인부담률**이다(관리급여). 실손 자기부담률(50%)과 혼동 금지 — 둘은 별개 제도이고 5세대는 그 95%가 **공제로 잡힌다**.

③ 전 세대 비교 1 → 5세대 · 3대비급여만

세대	MRI	도수·체외·증식	비급여 주사	비급여 자기부담
1세대~2009.09	입원·통원 의료비에 포함	포함	포함	자기부담 거의 없음 (공제 5천원)
2세대 2009.10~2017.03	입원·통원 의료비에 포함	포함	포함	10~20%
3세대 2017.04~2021.06	**별도특약** 연 300만	별도특약 연 350만·50회	별도특약 연 250만·50회	3대비급여 30%·최소 2만
4세대 2021.07~2026.05	**별도특약** 연 300만	별도특약 연 350만·50회	별도특약 연 250만·50회	3대비급여 30%·최소 3만
5세대2026.05.06~	중증 300만 비중증 200만(별도 담보)	중증 350만·50회 비중증 제외(도수는 급여 통원)	중증 250만·50회 비중증 제외 · 0원	중증 30%·3만 / 비중증 50%·5만

■ 상담 화법 "5세대도 MRI는 나옵니다 — 비중증이면 절반 떼고 연 200만까지요. 그런데 도수와 영양주사는 산정특례가 아니면 한 푼도 안 나옵니다. 셋을 같이 묶어 설명하면 안 됩니다."

※ 근거: KB 5세대 실손 제안서 약관 원문 · 금융위원회 5세대 실손 개편(2026.5.6) · 보건복지부 도수치료 관리급여 시행(2026.7.1).

중증 vs 비중증 — 기준은 '산정특례'다

■ 중증의 기준 = 건강보험 산정특례 대상자

보험사가 정하는 게 아니다. 국민건강보험공단에 산정특례로 등록된 질환이면 '중증(특약1)', 아니면 전부 '비중증(특약2)'이다.
산정특례 = 암·뇌혈관·심장·희귀난치질환 등 큰 병에 대해 건보 본인부담을 5~10%로 낮춰주는 제도. 진단 후 공단에 등록하면 산정특례 등록증이 나온다.
※ 같은 도수치료라도 — 암 치료 목적이면 중증(보장), 허리 통증이면 비중증(0원). 병명이 아니라 산정특례 등록 여부가 갈림길이다.

특약1 · 중증 비급여

산정특례 등록 질환 + 인과관계 분명한 합병증

내 돈 **30%** 입원 기준

암 | 뇌혈관 | 심장 | 희귀·중증난치 | 중증화상 | 중증외상 | 결핵 | 중증치매

자기부담	입원 30% / 통원 Max[30%, 3만]
한도	연 5,000만 · 통원 회당 20만 입원 한도 없음
상한	★ 상급종합·종합 입원 시 연 자기부담 500만 초과분 전액 보장
도수·체외 비급여주사	모두 보장 √ 면책 없음
보험료 할증	없음 아무리 써도 그대로

특약2 · 비중증 비급여

그 외 전부 — 허리·어깨·감기·미용 아닌 일반 비급여

내 돈 **50%** 입원 기준

디스크·요통 | 어깨·관절 | 일반 수술 | 비중증 MRI | 영양·주사 | 도수·체외

자기부담	입원 50% / 통원 Max[50%, 5만]
한도	연 1,000만 · 입원 회당 300만 통원 1일 20만
상한	없음 초과분은 전부 본인 부담
도수·체외 비급여주사	보장 제외 × + 미등재 신의료기술
보험료 할증	최대 +300% 비급여 보험료 4배

■ 비급여 100만원 냈다면

중증 → 70만원 환급
비중증 → 50만원 환급

같은 100만원인데 20만원 차이. 비중증은 소액일수록 더 불리하다(4만원 청구 = 0원).

■ 도수치료 100만원

중증(암 치료) → 70만원
비중증(요통) → 0원

2026.07.01부터 도수는 관리급여(1회 43,850원·본인 95%). 체외충격파·비급여주사는 비중증이면 그대로 0원.

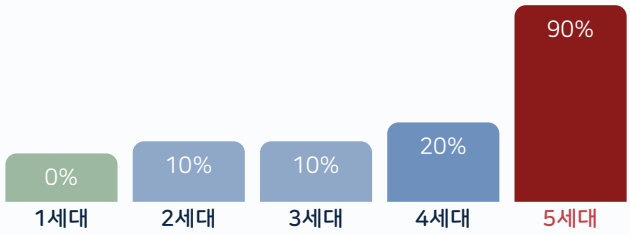
★ 상담 한 줄

"산정특례 등록증이 나오는 병이면 5세대도 괜찮습니다. 아니면 절반만 나옵니다."

암·뇌·심장은 오히려 500만원 상한이 생겨 강화됐다. 문제는 도수·체외충격파·영양주사 — 비중증이면 한 푼도 안 나온다. 이 치료를 정기적으로 받는 분은 5세대 전환 금지.

5세대는 얼마나 불리해지나 — 한눈에

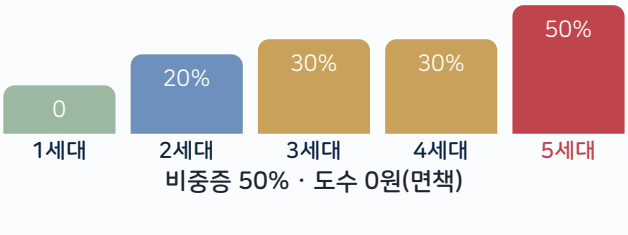
① 급여 통원 자기부담률



4세대까지 20% → 5세대 최대 90%

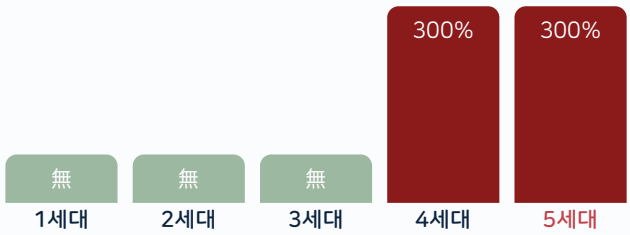
(권역응급의료센터급 응급실 · 경증)

② 비급여 자기부담률



비중증 50% · 도수 0원(면책)

③ 할증 제도 비급여 보험료



1~3세대 할증 없음 → 4·5세대 최대 +300%

④ 보장 한도 비급여 연간



비중증 한도 5천만 → 1천만 (1/5)

■ 비급여 보험료 할증 — 직전 1년 청구액에 따라 5단계

1등급	2등급	3등급	4등급	5등급
보험금 0원	100만 미만	150만 미만	300만 미만	300만 이상
-5% 할인	유지	+100%	+200%	+300% (4배)

※ 할증은 비중증(특약2) 비급여 보험료에만 붙는다. 급여·중증(특약1)은 아무리 써도 할증 없음. 직전 2년 특약2 보험금 미수령 시 전체보험료 10% 추가 할인.

★ 놓치기 쉬운 보장 — 세대별로 갈린다

항목	1·2·3세대	4세대	5세대
습관성유산·불임·인공수정 합병증	면책	급여 보상 (가입 2년 이후)	급여 보상
임신·출산 급여의료비	미보장	미보장	신규 보장
발달장애 급여의료비	미보장	미보장	신규 보장 (18세까지)
비만(E66) · 선천성 뇌질환	면책	급여 보상 (뇌질환=태아 가입분)	급여 보상

※ 난임 치료 계획이 있으면 4세대 이상이어야 급여 본인부담금이 보상됩니다(4세대는 가입 2년 이후). 1~3세대는 면책. 납입중지는 3세대 단체실손 / 4세대는 해외 장기체류자까지 확대.

도수치료 · 체외충격파 — 2026년 7월부터 달라집니다

■ 도수치료 1회 43,850원 기준(예시)

실손 세대	예상 본인부담	보험 적용
1세대	0원	보장 가능
2세대	약 4천원	보장 가능
3세대	약 4천~8천원	보장 가능
4세대	약 8천원	보장 가능
5세대	약 4만 2천원	본인부담 95%

■ 체외충격파 1회 10만원 기준(예시)

실손 세대	예상 본인부담	보험 적용
1세대	0원	보장 가능
2세대	약 2만원	보장 가능
3세대	약 3만원	보장 가능
4세대	약 3만원	보장 가능
5세대	10만원 전액	보장 제외

※ 위 금액은 예시이며, 실제 지급액은 보험사·약관·질환·치료기록 등에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 5세대는 중증(특약1)이면 보장 — 위 표는 비중증(특약2) 기준.

■ 도수치료 — 이용 제한

√ 정부 관리급여 전환 (2026.07 시행)

√ 연 15회 제한 (주 2회 이내)

√ 전국 동일 수가 적용 (1회 43,850원)

√ 수술·골절 후 재활 시 최대 연 24회 인정

√ 선행 물리치료 2주·4회 후 호전 없어야 인정

■ 체외충격파 — 이용 제한

√ 비급여 유지 (자율 가이드라인)

√ 연 12회 제한 · 부위당 최대 6회

√ 주 1회 권장, 1회 2,000타 이상 권장

√ 동일 회차 다부위 치료 제한

√ 5세대 실손(비중증) = 보장 대상 제외

■ 체외충격파 인정 부위 (7개)

- 어깨 석회성건염·회전근개
- 팔꿈치 테니스엘보·골프엘보
- 고관절 대전자통증증후군
- 무릎 슬개건염
- 발목 아킬레스건염
- 발바닥 족저근막염
- 척추 경추·요추 근막통증증후군

도수치료 1회 43,850원

중증 → 보장 (30%·최소3만)

비중증 → 관리급여 95% · 내 돈 약 4만 2천원

2026.07.01 시행 · 연 15회 · 주 2회

체외충격파 1회 10만원

중증 → 보장 (30%·최소3만)

비중증 → 보장 제외 · 0원

전액 본인부담 (10만원 그대로)

비급여 주사 영양주사 등

중증 → 보장 (30%·최소3만)

비중증 → 보장 제외 · 0원

입원해도 안 나온다

★ 위 표는 비중증(특약2) 기준이다. 중증 = 암·뇌혈관·심장·희귀난치(산정특례) 질환 치료 목적일 때만. 허리·어깨 통증 도수치료는 비중증 → 0원이다. MRI는 이 셋과 다르다 — 별도 담보라 비중증도 보장된다(자세한 비교는 「MRI·도수·비급여주사」 전용 페이지 참조).

보상 피부만 꿰맨 경우. 창상봉합술 담보에서만 나온다(상해수술비 ×)

주의 더마본드·스테이플러는 회사별 인정 상이 [확인]

위고비 · 마운자로 — 실손 청구 기준



요즘 많이 묻는 비만 주사, 실손보험으로 받을 수 있을까?

결론 — **비만 치료 목적이면 실손 보상 안 됨** · 비만(E66)은 실손 약관 「보상하지 않는 사항」

1 무엇인가

- **위고비** — GLP-1 계열 · 식욕 억제 · 주 1회
- **마운자로** — GIP/GLP-1 계열 · 혈당 조절 + 식욕 억제 · 주 1회
- 의사 처방이 필요한 전문의약품

2 누가 처방받나

- BMI 30 이상(비만)
- BMI 27 이상 + 고혈압·당뇨·고지혈증 등 동반질환
- 의사가 치료가 필요하다고 판단한 경우

3 실손 청구 되나

비만 치료 목적 = ×

- **비만(E66)**은 실손 표준약관 **보상하지 않는 사항**(2009.10 이후 공통)
- 금감원 2025.7 분쟁사례: 비만 진단 위고비·위소매절제술 → **지급 거절**
- BMI가 높아도·동반질환이 있어도 **비만 목적 비급여 처방**은 어렵다

4 먼저 확인할 것

- 진료비 영수증·세부내역서의 **급여 / 비급여**
- 처방 목적과 질병코드(진단서·처방전)
- 내 실손 세대·약관의 보상하지 않는 사항
- 병원·보험사에 미리 문의

5 코드를 바꾸면?

절대 안 됨

- 질병코드를 바꾸거나 다른 치료로 청구 = **보험사기**
- 설계사가 권유해도 처벌 대상
- 정확한 진단과 실제 치료 목적이 기준

6 가입·고지 영향

- 30일 이상 투약이면 다음 보험 가입 때 **투약 고지 대상**이 될 수 있다
- 간편보험도 질문 기간 안이면 해당
- 처방전·진단서·영수증 보관

✔ 핵심 정리

위고비·마운자로는 **의사 처방** 비만치료 주사	비만(E66) 목적 = **실손 보상 안 됨**	청구 전 **급여/비급여·코드** 먼저 확인	코드 변경 청구 = **보험사기** · 투약은 고지 대상

근거: 실손의료보험 표준약관 「보상하지 않는 사항 — 비만(E66)」 · 금융감독원 실손보험 주요 분쟁사례(2025.7) · 처방 기준은 의약품 허가사항 요약 · 실제 지급은 회사 심사

1~5종 수술분류표 · 한 눈에 보는 1~5종

1~5종 수술분류표

1~5종 한 눈에 · 약관 원문 캡처 카드 5장 + 종별 수술 72개 · 상담용 참고자료

1종

비교적 간단한 외래 수술

- 백내장
- 편도·아데노이드
- 치핵·치루
- 탈장
- 제왕절개

2종

흔히 하는 다빈도 수술

- 대장 용종 제거
- 맹장(충수)수술
- 자궁·난소 관혈
- 골 이식
- 고막 성형

3종

내시경보다 난이도 높은 수술

- 유방절단술
- 담낭·담도 관혈
- 갑상선 관혈
- 녹내장
- 척추·추간판

4종

생명과 직결된 주요 장기 수술

- 위 절제술
- 폐·기관지(개흉)
- 간·췌장(개복)
- 신장·방광(개복)
- 심막 관혈

5종

고난도·고비용 대수술

- 뇌수술(개두)
- 심장수술(개흉)
- 장기이식
- 대동맥·관동맥
- 암 근치수술

종별 전체 목록

1종 비교적 간단한 수술 — 대부분 외래·당일 (21개)

- 백내장·수정체 관혈수술
- 편도·아데노이드 절제
- 만성부비강염(축농증) 근본수술
- 비골(코뼈) 수술 — 비중격만곡증
- 탈장 근본수술
- 치루·치열·치핵 근본수술
- 직장탈 근본수술
- 하지정맥류 근본수술
- 손가락·발가락 절단수술 / 그 골·관절 관혈수술
- 근·건·인대·연골 관혈수술
- 피부이식 25㎠ 미만
- 기타 유방수술(농양 절개·배액 제외)
- 방광류·요실금 교정수술
- 음낭 관혈수술
- 경질적 자궁·난소·난관 수술
- 제왕절개만출술
- 질탈 근본수술
- 안검하수증·눈물소관형성·각막 봉합
- 레이저 안구수술 / 관혈적 안와내 이물제거 / 안근
- 중이내 튜브유치술
- 내시경·카테터 — 비뇨·생식기·손가락·발가락(88-3)

2종 흔히 하는 다빈도 수술 (15개)

- 골 이식수술
- 상악골·하악골·악관절 관혈수술
- 쇄골·견갑골·늑골·흉골 관혈수술
- 기타 사지골·사지관절 관혈수술
- 요도 관혈수술
- 고환·부고환·정관·정색·정낭·전립선 관혈수술
- 자궁·난소·난관 관혈수술
- 각막·공막 이식 / 전방·홍채·유리체 관혈 / 망막박리 / 냉동응고 안구
- 관혈적 고막 성형술 / 유양동 절제술 / 중이 관혈수술
- 체내용 인공심박조율기 매입술
- 전신성 복막염 수술
- 충수(맹장)절제술
- 상기 이외의 개복술(86항)
- 체외충격파쇄석술
- 내시경·카테터 — 후두·흉부·복부장기·척추·사지관절(88-2)

3종 내시경보다 난이도 높은 수술 (20개)

- 유방절단술(Mastectomy)
- 피부이식 25㎠ 이상·피판수술
- 두개골 관혈수술
- 척추골·골반골·추간판 관혈수술
- 기타 사지 절단수술 / 절단된 사지 재접합수술
- 후두 관혈적 절제수술
- 흉곽 형성수술
- 혈관 관혈수술(하지정맥류 제외)
- 비장 절제수술
- 이하선 절제수술
- 기타 위·식도 관혈수술
- 담낭·담도 관혈수술
- 음경 절단수술
- 갑상선·부갑상선 관혈수술
- 척수경막내외 관혈수술
- 안구적출술·안와내종양절제
- 내이 관혈수술
- 상기 이외의 개두술(84)·개흉술(85)
- 내시경·카테터 — 뇌·심장(88-1)
- 악성신생물 내시경 수술 / 기타 / 방사선 조사

4종 생명과 직결된 주요 장기 수술 (10개)

- 기관·기관지·폐·흉막 관혈수술(개흉)
- 종격종양·흉선 절제수술(개흉)
- 심막 관혈수술(개흉)
- 식도 이단술(개흉·개복)
- 위 절제수술(개복)
- 간장·췌장 관혈수술(개복)
- 소장·결장·직장·장간막 관혈수술(개복) — 대장 용종을 개복해서 떼면 여기다
- 신장·방광·신우·요관 관혈수술(개복)
- 부신 절제수술
- 관혈적 척수종양 절제수술

5종 고난도·고비용 대수술 (6개)

- 두개내 관혈수술(개두)
- 심장내 관혈수술(개흉)
- 대동맥·대정맥·폐동맥·관동맥 관혈수술
- 폐장 이식 / 심장 이식 / 간장 이식 / 췌장 이식 / 신장 이식
- 뇌하수체종양 절제수술
- 관혈적 악성신생물 근치수술(기타피부암 C44 제외)

1~5종 수술분류표 · 회사별 차이 · 보상 비교

1~5종 수술분류표

회사별 차이 · 약관 원문 캡처 분류표·지급방식 + 갈리는 것 4개 + 6사 종수 · 상담용 참고자료

① 회사별 분류표 · 지급방식

회사	제왕절개만출술(항·종)	분류표 구성	지급방식	근거
DB손보	53항 · 1종 (질병1~5종수술비 II 전용)	1일반 + 2악성신생물 + 3방사선조사 (88항)	매회지급 — 질병1~5종수술비 II (매회지급)	원본 실측
현대해상	54항 · 1종	III 분류표 / IV 분류표(중복) 2종	[확인]	원본 실측 / 지급방식은 제안서 미보유
삼성화재	54항 · 1종	—	[확인]	원본 실측 / 지급방식은 제안서 미보유
KB손보	54항 · 1종	1~5종수술 II · III 분류표	매회지급 — 상해1~5종·질병1~5종 II (매회지급)	원본 실측 / 이화미 KB 제안서
한화손보	55항 · 1종	수술종류(종) 표기	[확인]	원본 실측 / 지급방식은 제안서 미보유
흥국화재	54항 · 1종	1~5종수술 분류표IV	[확인]	원본 실측 / 조헌일 제안서엔 1~5종 담보 없음

② 회사마다 갈리는 것 — 이것만 외우면 된다

수술	유리한 쪽	나머지
대장 용종 — 내시경으로 뗄 때	KB·흥국 = 1종	DB·현대·삼성·한화 = 2종
충수(맹장)절제술	DB손보 = 1종	나머지 5곳 = 2종
체외충격파쇄석술	한화손보 = 1종	나머지 5곳 = 2종
유방의 비대(N62) 유방절단술	한화·흥국 = 1종 별항	나머지 4곳 = 별항 없음(유방절단술 3종)

③ 같은 수술 · 6사 종수 (★는 다른 값)

수술	항	DB손보	현대해상	삼성화재	KB손보	한화손보	흥국화재
백내장·수정체 관혈수술	71항	1	1	1	1	1	1
대장 용종 내시경 절제	88-2	2	2	2	★1	2	★1
충수(맹장)절제술	41항	★1	2	2	2	2	2
치핵·치루·탈항 근본수술	44항	1	1	1	1	1	1
탈장 근본수술	39항	1	1	1	1	1	1
제왕절개만출술	53~55항	1	1	1	1	1	1
체외충격파쇄석술	87항	2	2	2	2	★1	2
요실금 수술(급여)	47~48항	1	1	1	1	★1 별항 (남성 제외)	1
유방의 비대(N62) 유방절단술	3-1	—	—	—	—	★1	★1
갑상선·부갑상선 관혈수술	57항	3	3	3	3	3	3
위 절제수술(개복)	33항	4	4	4	4	4	4
담낭·담도 관혈수술(개복)	36항	3	3	3	3	3	3
소장·결장·직장 관혈수술(개복)	43항	4	4	4	4	4	4
심장내 관혈수술(개흉)	26항	5	5	5	5	5	5
두개내 관혈수술(개두)	59~60항	5	5	5	5	5	5
신장 이식수술	48항	5	5	5	5	5	5
내시경·카테터 — 뇌·심장	88-1	3	3	3	3	3	3
내시경·카테터 — 비뇨·생식기·손발가락	88-3	1	1	1	1	1	1

★는 다른 회사와 다른 값, —는 그 회사 표에 그 항목이 없다는 뜻이다.
약관 계열 — 분류표에 제왕절개만출술이 있으면 생보약관이다. 6사 모두 해당한다(DB는 첫 항목이 「상해」여도 생보약관).
지급방식은 담보명에 적힌다 — 「(매회지급)」·「(매회)」는 수술 1회당, 「동일질병 1회」·「1회한」은 같은 질병이면 한 번뿐. 제안서 원본을 본 DB·KB만 적었다.
항 번호는 회사마다 1~2항씩 밀린다(제왕절개 DB 53 · 대부분 54 · 한화 55) → 번호가 아니라 수술명으로 찾는다. 담보명 끝 II · III · IV가 어느 분류표인지 알려준다(현대 III · IV 88항은 둘 다 2종).
한화는 치핵·요실금·제왕절개를 질병1~5종수술비III · IV(수술 1회당)에서만 준다 — 상해 담보에서는 안 나온다.

1~5종 수술분류표 DB손보 · 약관 원문 캡처 약관 원문 전사(글자 표) · 상담용 참고자료

	수술명	종류
피부, 유방의 수술	1. 피부이식수술(25㎠이상인 경우), 피판수술(피판분리수술, Z flap, W flap 제외)	3
	2. 피부이식수술(25㎠미만인 경우)	1
	3. 유방절단술(切斷術, Mastectomy)	3
	4. 기타 유방수술(농양(고름집)의 절개 및 배액은 제외) [단, 치료목적의 유방절제술(Mammotomy)은 60일 이내 2회 이상은 1회로 간주·반복지급]	1
근골( )의 수술 [발정술( ) 등 내고정물 제거술은 제외함] [치( )·치은·치근( )·치조골( )의 처치, 임플란트(Implant) 등 치과 처치 및 수술에 수반하는 것은 제외함]	5. 골(骨) 이식수술	2
	6. 두개골(頭蓋骨, cranium) 관혈수술 [비골(鼻骨)·비중격(鼻中隔)·상악골(上顎骨)·하악골(下顎骨)·악관절(顎關節)은 제외]	3
	7. 비골(鼻骨) 수술 [비중격 만곡증(彎曲症)수술]	1
	8. 상악골(上顎骨), 하악골(下顎骨), 악관절(顎關節) 관혈수술	2
	9. 척추골(脊椎骨), 골반골(骨盤骨), 추간판 관혈수술	3
	10. 쇄골(鎖骨), 견갑골(肩胛骨), 늑골(肋骨), 흉골(胸骨) 관혈수술	2
	11. 사지(四肢) 절단수술 [다지증에 대한 절단수술은 제외]	-
	11-1. 손가락, 발가락 절단수술 [골, 관절의 이단(離斷)에 수반하는 것]	1
	11-2. 기타 사지(四肢)절단수술	3
	12. 절단(切斷)된 사지(四肢)재접합수술(再接合手術) [골, 관절의 이단(離斷)에 수반하는 것]	3
	13. 사지골(四肢骨), 사지관절(四肢關節) 관혈수술	-
	13-1. 손가락, 발가락의 골 및 관절 관혈수술	1
	13-2. 기타 사지골(四肢骨), 사지관절(四肢關節) 관혈수술	2
	14. 근(筋), 건(腱), 인대(靭帶), 연골(軟骨) 관혈수술	1
호흡기계, 흉부( )의 수술	15. 만성부비강염(慢性副鼻腔炎) 근본수술(根本手術)	1
	16. 후두(喉頭) 관혈적 절제수술	3
	17. 편도, 아데노이드 절제수술	1
	18. 기관(氣管), 기관지(氣管支), 폐(肺), 흉막(胸膜) 관혈수술 [개흉술(開胸術, Thoracotomy)을 수반하는 것]	4
	19. 폐장(肺臟) 이식수술[수용자(受容者)에 한함]	5
	20. 흉곽(胸廓) 형성수술(形成手術)	3
	21. 종격종양(縱隔腫瘍), 흉선 절제수술 [개흉술을 수반하는 것]	4
순환기계, 비장( )의 수술	22. 혈관관혈수술(하지정맥류 및 손가락·발가락은 제외)	3
	23. 하지 정맥류(靜脈瘤) 근본수술 및 손가락·발가락 혈관관혈수술	1
	24. 대동맥(大動脈), 대정맥(大靜脈), 폐동맥(肺動脈), 관동맥(冠動脈) 관혈수술[개흉술, 개복술을 수반하는 것]	5
	25. 심막(心膜) 관혈수술 [개흉술을 수반하는 것]	4
	26. 심장내(心臟內) 관혈수술 [개흉술을 수반하는 것]	5
	27. 심장 이식수술 [수용자에 한함]	5
	28. 체내용(體內用) 인공심박조율기(人工心搏調律機, Artificial pacemaker) 매입술(埋入術)	2
	29. 비장(脾臟) 절제수술	3
소화기계의 수술	30. 이하선 절제수술	3
	31-1. 악하선, 설하선 절제수술	2
	31-2. 기타 타액선 절제수술(타석제거는 제외)	1
	32. 식도(食道) 이단술(離斷術) [개흉술, 개복술(開腹術, Laparotomy)을 수반하는 것]	4
	33. 위 절제수술(胃 切除手術, Gastrectomy) [개복술을 수반하는 것]	4
	34. 기타의 위·식도 관혈수술 [개흉술, 개복술을 수반하는 것]	3
	35. 간장(肝臟), 췌장(膵臟) 관혈수술 [개복술을 수반하는 것]	4
	36. 담낭(膽囊), 담도(膽道) 관혈수술 [개복술을 수반하는 것]	3
	37. 간장 이식수술 [수용자에 한함, 개복술을 수반하는 것]	5
	38. 췌장 이식수술 [개복술을 수반해야 하며 수용자에 한함] (단, 랑게르한스 소도(Islet of Langerhans)세포 이식수술은 제외)	5
	39. 탈장(脫腸) 근본수술	1

1~5종 수술분류표 · 현대해상 (1/3)

1~5종 수술분류표 현대해상 · 약관 원문 캡처 20장 중 1~8 · 상담용 참고자료

구분	수술명	수술종류
피부, 유방의 수술	1. 피부이식수술(25㎠이상인 경우), 피판수술(피판분리수술, Z flap, W flap 제외)	3
	2. 피부이식수술(25㎠미만인 경우)	1
	3. 유방절단수술(切斷術, Mastectomy)	-
	3-1. 유방절단수술(切斷術, Mastectomy)(제자리암, 경계성종양)	3
	3-2. 기타 유방절단수술(切斷術, Mastectomy)	2
	4. 기타 유방수술(농양의 절개 및 배액은 제외) [단, 질병치료목적의 유방절제술(Mammotomy)는 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	1

구분	수술명	수술종류
근골(筋骨)의 수술 [발정술(拔釘術) 등 내고정물 제거술은 제외함] [치(齒)·치은·치근(齒根)·치조골(齒槽骨)의 처치, 임플란트(Implant) 등 치과 처치 및 수술에 수반하는 것은 제외함]	5. 골(骨) 이식수술	2
	6. 두개골(頭蓋骨, cranium) 관혈수술 [비골(코뼈)·비중격(鼻中隔)·상악골(위턱뼈)·하악골(아래턱뼈)·악관절(顎關節)은 제외함]	3
	7. 비골(코뼈) 수술 [비중격 만곡증(彎曲症)수술 제외]	1
	8. 상악골(위턱뼈), 하악골(아래턱뼈), 악관절(顎關節) 관혈수술	2
	9. 척추골(脊椎骨), 골반골(骨盤骨), 추간판 관혈수술	3
	10. 쇄골(빗장뼈), 견갑골(어깨뼈), 늑골(갈비뼈), 흉골(胸骨) 관혈수술	2
	11. 사지(四肢) 절단수술 (다지증에 대한 절단수술은 제외함)	-
	11-1. 손가락, 발가락 절단수술[골, 관절의 이단(離斷)에 수반하는 것]	1
	11-2. 기타 사지(四肢)절단수술	3
	12. 절단(切斷)된 사지(四肢)재접합수술(再接合手術) [골, 관절의 이단(離斷)에 수반하는것]	3
	13. 사지골(四肢骨), 사지관절(四肢關節) 관혈수술	-
	13-1. 손가락, 발가락의 골 및 관절 관혈수술	1
	13-2. 기타 사지골(四肢骨), 사지관절(四肢關節) 관혈수술	2
	14. 근(筋), 건(腱), 인대(靭帶), 연골(軟骨) 관혈수술	1

구분	수술명	수술종류
호흡기계, 흉부(胸部)의 수술	15. 만성부비강염(慢性副鼻腔炎) 근본수술(根本手術)	1
	16. 후두(喉頭) 관혈적 절제수술	3
	17. 편도, 아데노이드 절제수술	1
	18. 기관(氣管), 기관지(氣管支), 폐(肺), 흉막(胸膜) 관혈수술 [개흉술(開胸術, Thoracotomy)을 수반하는 것]	4
	19. 폐장(肺臟) 이식수술 [수용자(受容者)에 한함]	5
	20. 흉곽(胸廓) 형성수술(形成手術)	3
	21. 종격종양(縱隔腫瘍), 흉선 절제수술[개흉술을 수반하는 것]	4
순환기계, 비장(脾臟)의 수술	22. 혈관관혈수술(하지정맥류 및 손가락·발가락은 제외)	3
	23. 하지 정맥류(靜脈瘤) 근본수술 및 손가락·발가락 혈관관혈수술	1
	24. 대동맥(大動脈), 대정맥(大靜脈),폐동맥(肺動脈), 관동맥(冠動脈) 관혈수술[개흉술, 개복술을 수반하는 것]	5
	25. 심막(心膜) 관혈수술 [개흉술을 수반하는 것]	4
	26. 심장내(心臟內) 관혈수술 [개흉술을 수반하는 것]	5
	27. 심장 이식수술 [수용자에 한함]	5
	28. 체내용(體內用) 인공심박조율기(人工心搏調律機, Artificial pacemaker) 매입술(埋入術)	3
	29. 비장(脾臟) 절제수술	3

구분	수술명	수술종류
소화기계의 수술	30. 이하선 절제수술	3
	31-1. 악하선, 설하선 절제수술	2
	31-2. 기타 타액선 절제수술(타석제거는 제외)	1
	32. 식도(食道) 이단술(離斷術) [개흉술, 개복술(開腹術, Laparotomy)을 수반하는 것]	4
	33. 위 절제수술(胃 切除手術, Gastrectomy) [개복술을 수반하는 것]	4
	34. 기타의 위·식도 관혈수술 [개흉술, 개복술을 수반하는 것]	3
	35. 간장(肝臟), 췌장(膵臟) 관혈수술 [개복술을 수반하는 것]	4
	36. 담낭(膽囊), 담도(膽道) 관혈수술 [개복술을 수반하는 것]	3
	37. 간장 이식수술 [수용자에 한함, 개복술을 수반하는 것]	5
	38. 췌장 이식수술 [개복술을 수반해야 하며 수용자에 한함] (단, 랑게르한스 소도(Islet of Langerhans)세포 이식수술은 제외함)	5
	39. 탈장(脫腸) 근본수술	1
	40. 전신성 복막염(全身性 腹膜炎, Generalized peritonitis) 수술	2
	41. 충수(蟲垂)절제술(충수염관련 충수주위 농양수술, 국한성 복막염 수술 포함), 맹장봉축술(盲腸縫縮術)	2
	42. 직장탈(直腸脫) 근본수술	1
	43. 소장(小腸), 결장(結腸), 직장(直腸), 장간막(腸間膜) 관혈수술[개복술을 수반하는 것] (단, 직장탈근본수술은 제외)	4
	44. 치루(痔瘻), 탈항(脫肛), 치핵(痔核) 근본수술 [근치를 목적으로 하지 않은 수술은 제외함]	1

구분	수술명	수술종류
비뇨기계·생식기계의 수술 (인공임신중절수술은 제외함)	45. 신장(腎臟), 방광(膀胱), 신우(腎盂), 요관(尿管)관혈수술 [개복술을 수반하는 것, 경요도적 조작 및 방광류·요실금 교정수술은 제외]	4
	46. 요도 관혈수술 [경요도적 조작은 제외함]	2
	47. 방광류·요실금 교정수술	1
	48. 신장(腎臟) 이식수술(移植手術) [수용자에 한함]	5
	49. 음경(陰莖) 절단수술 (포경수술 및 음경이물제거수술은 제외)	3
	50. 고환(睾丸), 부고환(副睾丸), 정관(精管), 정색(精索), 정낭(精囊)관혈수술, 전립선(前立腺)관혈수술	2
	51. 음낭관혈수술	1
	52. 자궁, 난소, 난관 관혈수술 (단, 제왕절개만출술 및 경질적인 조작은 제외)	2
	53. 경질적 자궁, 난소, 난관 수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	1
	54. 제왕절개만출술(帝王切開娩出術)	1
	55. 질탈(膣脫)근본수술	1
내분비기계의 수술	56. 뇌하수체종양(腦下垂體腫瘍) 절제수술	5
	57. 갑상선(甲狀腺)·부갑상선(副甲狀腺) 관혈수술	3
	58. 부신(副腎) 절제수술	4

구분	수술명	수술종류
신경계의 수술	59. 두개내(頭蓋內) 관혈수술 [개두술(開頭術, Craniotomy)을 수반하는 것]	5
	60. 신경(神經) 관혈수술	2
	61. 관혈적 척수종양(脊髓腫瘍) 절제수술	4
	62. 척수경막내외(脊髓硬膜內外) 관혈수술	3
시각기의 수술 [약물주입술은 제외]	61. 안검하수증(눈꺼풀처짐증)수술(안검내반증 포함)	1
	64. 누소관(淚小管)형성수술(누관튜브삽입술 포함)	1
	65. 누낭비강(淚囊鼻腔) 관혈수술	2
	66. 결막낭(結膜囊) 형성수술	2
	67. 각막, 결막, 공막 봉합수술	1
	68. 각막, 공막 이식수술	2
	69. 전방(前房), 홍채(虹彩), 유리체(琉璃體) 관혈수술	2
	70. 녹내장(綠內障) 관혈수술	3
	71 백내장(白內障), 수정체(水晶體) 관혈수술	1
	72. 망막박리(網膜剝離) 수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	2
	73. 레이저(Laser)에 의한 안구(眼球) 수술 [시력회복 및 시력개선 목적의 수술은 제외] [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	1

구분	수술명	수술종류
시각기의 수술 [약물주입술은 제외]	74. 냉동응고(冷凍凝固)에 의한 안구(眼球) 수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	2
	75. 안구적출술, 조직충전술(組織充塡術)	3
	76. 안와내양절제수술	3
	77. 관혈적 안와내(眼窩內) 이물제거수술(異物除去手術)	1
	78. 안근(眼筋)관혈수술	1
청각기(聽覺器)의 수술	79. 관혈적 고막(鼓膜) 성형술 [고막 패치술은 제외]	2
	80. 유양동 절제술(乳樣洞切除術, mastoidectomy)	2
	81. 중이(中耳) 관혈수술 [중이내 튜브유치술 제외]	2
	82. 중이내(中耳內) 튜브유치술 [고막 패치술은 제외, 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	1
	83. 내이(內耳) 관혈수술	3

1~5종 수술분류표 · 현대해상 (2/3)

1~5종 수술분류표 현대해상 · 약관 원문 캡처 20장 중 9~18 · 상담용 참고자료

II. 악성신생물 치료 목적의 수술

수술명	수술종류
1. 관혈적 악성신생물(惡性新生物) 근치수술(根治手術, Radical curative surgery)(단, 기타피부암(C44) 제외) [내시경 수술, 카테터 · 고주파 전극 등의 경피(피부를 통한)적 수술 등은 제외함]	5
1-1. 기타피부암(C44)	3
2. 내시경 수술, 카테터 · 고주파 전극 등에 의한 악성신생물 수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	3
3. 상기 이외의 기타 악성신생물수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	3

㈜ 1. 제자리암·경계성종양에 대한 수술은 'I. 일반 질병 및 상해치료 목적의 수술' 항목의 적용을 받습니다.
2. 카테터(Catheter)를 이용한 흡인·천자·약물주입요법은 포함하지 않습니다.
3. 비고형암에 대한 비관혈적 근치수술은 관혈적 악성신생물 근치수술에 준하여 5종 수술로 인정합니다.
- 비고형암에 대한 비관혈적 근치술 중 조혈모세포 이식술은 일련의 과정(추출, 필터링, 배양, 제거, 주입)을 모두 포함하여 1회의 수술로 인정합니다.
- 다만 약물 등을 투여하기 위한 시술(예. 중심정맥삽관술)만 시행할 경우에는 5종으로 인정하지 않습니다.

III. 악성신생물 근치·두개내신생물 근치 방사선 조사 분류표

수술명	수술종류
1. 악성신생물 근치 방사선 조사 [5,000Rad 이상의 조사(照射)를 하는 경우로 한정하며, 악성신생물 근치 사이버 나이프(Cyberknife) 정위적 방사선치료(定位的 放射線 治療, Stereotactic radiotherapy)를 포함함]	3
2. 두개내 신생물 근치 감마 나이프(Gammaknife) 정위적 방사선치료	3

㈜ 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.

(1-5종 수술III 분류표 사용 지침)

1. '수술'이라 함은 병원 또는 의원의 의사, 치과의사의 면허를 가진 자(이하 '의사'라 합니다)에 의하여 치료가 필요하다고 인정된 경우로서 의사의 관리 하에 치료를 직접적인 목적으로 <1-5종수술III분류표>에서 정한 행위(기구를 사용하여 생체(生體)에 절단(切斷, 특정부위를 잘라 내는 것), 절제(切除, 특정부위를 잘라 없애는 것) 등의 조작(操作)을 가하는 것)을 말합니다.
또한, 보건복지부 산하 신의료기술평가위원회(향후 제도변경시에는 동 위원회와 동일한 기능을 수행하는 기관)로부터 안전성과 치료효과를 인정받은 최신 수술기법도 포함됩니다.
2. '관혈(觀血)' 수술이라 함은 병변 부위를 육안으로 직접 보면서 수술적 조작을 하기 위해 피부에 절개를 가하고 병변부위를 노출시켜서 수술하는 것을 말합니다.
3. '근본(根本)' 혹은 '근치(根治)' 수술이라 함은 일회의 수술로 해당 질병을 완전히 치유할 수 있는 수술을 말합니다.
4. '관혈적 악성신생물 근치수술'이라 함은 관혈적 방법을 통해 악성신생물의 원발 병소를 완전히 절제, 적제, 적출하고 혹은 곽청술을 함께 실시한 경우입니다.

5. <1-5종수술III분류표> 상에 열거되지 않은 선진의료적 첨단 수술에 대한 인정 및 적용 기준
<1-5종수술III분류표>에서의 선진의료적 첨단 수술은 상기 "수술"의 정의에 해당하여야 하고 약물투여치료, 방사선조사치료 또는 기타의 보존적 치료로 분류될 수 없는 경우이어야 합니다.
1) <1-5종수술III분류표>상의 수술 이외에 보건복지부 산하 신의료기술평가위원회(향후 제도 변경시에는 동 위원회와 동일한 기능을 수행하는 기관)로부터 안전성과 치료효과를 인정받은 최신 수술기법으로 치료한 경우 <1-5종수술III분류표>상의 동일부위 수술로 봅니다. 이 때에 해당 최신수술기법은 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.
2) 단, 이 선진의료적 첨단 수술이 본질적으로 내시경(Fiberscope)에 의한 내시경 수술 또는 카테터(Catheter) 등에 의한 경피(피부를 통한)적 수술인 경우에는 <1-5종수술III분류표> 중 '일반질병 및 상해치료 목적의 수술' 88항 (악성신생물의 경우는 '악성신생물 치료목적의 수술' 2항)을 우선 적용합니다.
6. '악성 신생물 근치 사이버 나이프(Cyberknife) 정위적 방사선 치료'라 함은 선형가속기(LINAC)에서 발생되는 가는 방사선(Pencil beam)들을 다양한 각도에서 악성 신생물을 향해 집중적으로 조사하면서 동시에 악성신생물의 움직임을 병변 추적 장치를 이용하여 실시간으로 추적하면서 치료하는 방법입니다.
7. '두개내 신생물 근치 감마나이프 (Gammaknife)정위적 방사선 치료'라 함은 정위 좌표계를 이용하여 코발트 60 방사성 동위원소 (Co-60) 에서 나오는 감마선을 두개강 내의 신생물을 향해 집중 조사함으로 두개(頭蓋)를 열지 않고도 수술적 제거와 같은 효과를 내는 치료를 말합니다.
8. 다음과 같은 수술은 수술급여금 지급대상에서 보장을 제외합니다.
① 흡인(吸引, 주사기 등으로 빨아들이는 것)
② 천자(穿刺, 바늘 또는 관을 꽂아 체액·조직을 뽑아내거나 약물을 주입하는 것)등의 조치
③ 신경(神經) 차단(NERVE BLOCK)
④ 미용성형 목적의 수술
⑤ 피임(避妊) 목적의 수술

⑥ 피임 및 불임술 후 가임목적의 수술
⑦ 검사 및 진단을 위한 수술(생검(生檢), 복강경검사(腹腔鏡檢査) 등)

구분	수술명	수술종류
피부, 유방의 수술	1. 피부이식수술(25㎠이상인 경우), 피판수술(피판분리수술, Z flap, W flap 제외)	3
	2. 피부이식수술(25㎠미만인 경우)	1
	3. 유방절단수술(切斷術, Mastectomy)	-
	3-1. 유방절단수술(切斷術, Mastectomy)(제자리암, 경계성종양)	3
	3-2. 기타 유방절단수술(切斷術, Mastectomy)	2
	4. 기타 유방수술(농양의 절개 및 배액은 제외) [단, 질병치료목적의 유방절제술(Mammotomy)는 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	1

구분	수술명	수술종류
근골(筋骨)의 수술 [발정술(拔釘術) 등 내고정물 제거술은 제외함] [치(齒)·치은·치근(齒根)·치조골(齒槽骨)의 처치, 임플란트(Implant) 등 치과 처치 및 수술에 수반하는 것은 제외함]	5. 골(骨) 이식수술	2
	6. 두개골(頭蓋骨, cranium) 관혈수술 [비골(코뼈)·비중격(鼻中隔)·상악골(위턱뼈)·하악골(아래턱뼈)·악관절(顎關節)은 제외함]	3
	7. 비골(코뼈) 수술 [비중격 만곡증(彎曲症)수술 제외]	1
	8. 상악골(위턱뼈), 하악골(아래턱뼈), 악관절(顎關節) 관혈수술	2
	9. 척추골(脊椎骨), 골반골(骨盤骨), 추간판 관혈수술	3
	10. 쇄골(빗장뼈), 견갑골(어깨뼈), 늑골(갈비뼈), 흉골(胸骨) 관혈수술	2
	11. 사지(四肢) 절단수술 (다지증에 대한 절단수술은 제외함)	-
	11-1. 손가락, 발가락 절단수술[골, 관절의 이단(離斷)에 수반하는 것]	1
	11-2. 기타 사지(四肢)절단수술	3
	12. 절단(切斷)된 사지(四肢)재접합수술(再接合手術) [골, 관절의 이단(離斷)에 수반하는것]	3
	13. 사지골(四肢骨), 사지관절(四肢關節) 관혈수술	-
	13-1. 손가락, 발가락의 골 및 관절 관혈수술	1
	13-2. 기타 사지골(四肢骨), 사지관절(四肢關節) 관혈수술	2
	14. 근(筋), 건(腱), 인대(靭帶), 연골(軟骨) 관혈수술	1

구분	수술명	수술종류
비뇨기계·생식기계의 수술 (인공임신중절수술은 제외함)	45. 신장(腎臟), 방광(膀胱), 신우(腎盂), 요관(尿管)관혈수술 [개복술을 수반하는 것, 경요도적 조작 및 방광류·요실금 교정수술은 제외]	4
	46. 요도 관혈수술 [경요도적 조작은 제외함]	2
	47. 방광류·요실금 교정수술	1
	48. 신장(腎臟) 이식수술(移植手術) [수용자에 한함]	5
	49. 음경(陰莖) 절단수술 (포경수술 및 음경이물제거수술은 제외)	3
	50. 고환(睾丸), 부고환(副睾丸), 정관(精管), 정색(精索), 정낭(精囊)관혈수술, 전립선(前立腺)관혈수술	2
	51. 음낭관혈수술	1
	52. 자궁, 난소, 난관 관혈수술 (단, 제왕절개만출술 및 경질적인 조작은 제외)	2
	53. 경질적 자궁, 난소, 난관 수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	1
	54. 제왕절개만출술(帝王切開娩出術)	1
	55. 질탈(膣脫)근본수술	1
내분비기계의 수술	56. 뇌하수체종양(腦下垂體腫瘍) 절제수술	5
	57. 갑상선(甲狀腺)·부갑상선(副甲狀腺) 관혈수술	3
	58. 부신(副腎) 절제수술	4

구분	수술명	수술종류
신경계의 수술	59. 두개내(頭蓋內) 관혈수술 [개두술(開頭術, Craniotomy)을 수반하는 것]	5
	60. 신경(神經) 관혈수술	2
	61. 관혈적 척수종양(脊髓腫瘍) 절제수술	4
	62. 척수경막내외(脊髓硬膜內外) 관혈수술	3
시각기의 수술 [약물주입술은 제외]	61. 안검하수증(눈꺼풀처짐증)수술(안검내반증 포함)	1
	64. 누소관(淚小管)형성수술(누관튜브삽입술 포함)	1
	65. 누낭비강(淚囊鼻腔) 관혈수술	2
	66. 결막낭(結膜囊) 형성수술	2
	67. 각막, 결막, 공막 봉합수술	1
	68. 각막, 공막 이식수술	2
	69. 전방(前房), 홍채(虹彩), 유리체(琉璃體) 관혈수술	2
	70. 녹내장(綠內障) 관혈수술	3
	71 백내장(白內障), 수정체(水晶體) 관혈수술	1
	72. 망막박리(網膜剝離) 수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	2
	73. 레이저(Laser)에 의한 안구(眼球) 수술 [시력회복 및 시력개선 목적의 수술은 제외] [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	1

1~5종 수술분류표 · 현대해상 (3/3)

1~5종 수술분류표 현대해상 · 약관 원문 캡처 20장 중 19~20 · 상담용 참고자료

구분	수술명	수술 종류
호흡기계, 흉부(胸部)의 수술	15. 만성부비강염(慢性副鼻腔炎) 근본수술(根本手術)	1
	16. 후두(喉頭) 관혈적 절제수술	3
	17. 편도, 아데노이드 절제수술	1
	18. 기관(氣管), 기관지(氣管支), 폐(肺), 흉막(胸膜) 관혈수술 [개흉술(開胸術, Thoracotomy)을 수반하는 것]	4
	19. 폐장(肺臟) 이식수술 [수용자(受容者)에 한함]	5
	20. 흉곽(胸郭) 형성수술(形成手術)	3
	21. 종격종양(縱隔腫瘍), 흉선 절제수술[개흉술을 수반하는 것]	4
순환기계, 비장(脾腸)의 수술	22. 혈관관혈수술(하지정맥류 및 손가락·발가락은 제외)	3
	23. 하지 정맥류(靜脈瘤) 근본수술 및 손가락·발가락 혈관관혈수술	1
	24. 대동맥(大動脈), 대정맥(大靜脈),폐동맥(肺動脈), 관동맥(冠動脈) 관혈수술[개흉술, 개복술을 수반하는 것]	5
	25. 심막(心膜) 관혈수술 [개흉술을 수반하는 것]	4
	26. 심장내(心藏內) 관혈수술 [개흉술을 수반하는 것]	5
	27. 심장 이식수술 [수용자에 한함]	5
	28. 체내용(體內用) 인공심박조율기(人工心搏調律機, Artificial pacemaker) 매입술(埋入術)	3
	29. 비장(脾腸) 절제수술	3

구분	수술명	수술 종류
소화기계의 수술	30. 이하선 절제수술	3
	31-1. 악하선, 설하선 절제수술	2
	31-2. 기타 타액선 절제수술(타석제거는 제외)	1
	32. 식도(食道) 이단술(離斷術) [개흉술, 개복술(開腹術, Laparotomy)을 수반하는 것]	4
	33. 위 절제수술(胃 切除手術, Gastrectomy) [개복술을 수반하는 것]	4
	34. 기타의 위·식도 관혈수술 [개흉술, 개복술을 수반하는 것]	3
	35. 간장(肝臟), 췌장(膵臟) 관혈수술 [개복술을 수반하는 것]	4
	36. 담낭(膽囊), 담도(膽道) 관혈수술 [개복술을 수반하는 것]	3
	37. 간장 이식수술 [수용자에 한함, 개복술을 수반하는 것]	5
	38. 췌장 이식수술 [개복술을 수반해야 하며 수용자에 한함] (단, 랑게르한스 소도(Islet of Langerhans)세포 이식수술은 제외함)	5
	39. 탈장(脫腸) 근본수술	1
	40. 전신성 복막염(全身性 腹膜炎, Generalized peritonitis) 수술	2
	41. 충수(蟲垂)절제술(충수염관련 충수주위 농양수술, 국한성 복막염 수술 포함), 맹장봉축술(盲腸縫縮術)	2
	42. 직장탈(直腸脫) 근본수술	1
	43. 소장(小腸), 결장(結腸), 직장(直腸), 장간막(腸間膜) 관혈수술[개복술을 수반하는 것] (단, 직장탈근본수술은 제외)	4
	44. 치루(痔瘻), 탈항(脫肛), 치핵(痔核) 근본수술 [근치를 목적으로 하지 않은 수술은 제외함]	1

1~5종 수술분류표 · 삼성화재

1~5종 수술분류표 삼성화재 · 약관 원문 캡처 8장 · 상담용 참고자료

Ⅰ. 일반 상해 및 질병 치료목적의 수술

구분	수술명	수술종류
피부, 유방의수술	1. 피부이식수술(25㎠이상인 경우), 피판수술(피판분리수술, Z flap, W flap 제외)	3
	2. 피부이식수술(25㎠미만인 경우)	1
	3. 유방절단수술(切斷術, Mastectomy)	3
	4. 기타 유방수술(농양의 절개 및 배액은 제외) [단, 치료목적의 Mammotomy는 60일이내 2회이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능함]	1
근골(筋骨)의 수술 [발정술(拔釘術) 등 내고정물 제거술은 제외함] [치(齒)·치은 ·치근(齒根) ·치조골(齒槽骨)의 처치, 임플란트(Implant) 등 치과 처치 및 수술에 수반하는 것은 제외함]	5. 골(骨) 이식수술	2
	6. 두개골(頭蓋骨, cranium) 관혈수술[비골(鼻骨)·비중격(鼻中隔)·상악골(上顎骨)·하악골(下顎骨)·악관절(顎關節)은 제외함]	3
	7. 비골(鼻骨) 수술[비중격 만곡증(彎曲症)수술, 수면중 무호흡 수술은 제외함]	1
	8. 상악골(上顎骨), 하악골(下顎骨), 악관절(顎關節) 관혈수술	2
	9. 척추골(脊椎骨), 골반골(骨盤骨), 추간판 관혈수술	3
	10. 쇄골(鎖骨), 견갑골(肩胛骨), 늑골(肋骨), 흉골(胸骨) 관혈수술	2
	11. 사지(四肢) 절단수술(다지 증에 대한 절단수술은 제외함)	
	11-1. 손가락, 발가락 절단수술[골, 관절의 이단(離斷)에 수반하는 것]	1
	11-2. 기타 사지(四肢)절단수술	3
	12. 절단(切斷)된 사지(四肢)재접합수술(再接合手術) [골, 관절의 이단(離斷)에 수반하는것]	3
	13. 사지골(四肢骨), 사지관절(四肢關節) 관혈수술	
	13-1. 손가락, 발가락의 골 및 관절 관혈수술	1
	13-2. 기타 사지골(四肢骨), 사지관절(四肢關節) 관혈수술	2
	14. 근(筋), 건(腱), 인대(靭帶), 연골(軟骨) 관혈수술	1

구분	수술명	수술종류
소화기계의 수술	36. 담낭(膽囊), 담도(膽道) 관혈수술[개복술을 수반하는 것]	3
	37. 간장 이식수술[수용자에 한함, 개복술을 수반하는 것]	5
	38. 췌장 이식수술 [개복술을 수반해야 하며 수용자에 한함] (단, 랑게르한스 소도(Islet of Langerhans)세포 이식수술은 제외함)	5
	39. 탈장(脫腸) 근본수술	1
	40. 전신성 복막염(全身性 腹膜炎, Generalized peritonitis) 수술	2
	41. 충수(盲垂)절제 술(충수염 관련 충수주위 농양수술, 국한성 복막염 수술 포함), 맹장봉축술(盲腸縫縮術)	2
	42. 직장탈(直腸脫) 근본수술	1
	43. 소장(小腸), 결장(結腸), 직장(直腸), 장간막(腸間膜) 관혈수술 [개복술을 수반하는 것] (단, 직장탈근본수술은 제외)	4
	44. 치루(痔瘻), 탈항(脫肛), 치핵(痔核) 근본수술 [근치를 목적으로 하지 않은 수술은 제외함]	1
비뇨기계 생식기계의 수술 (인공임신중절수술은 제외함)	45. 신장(腎臟), 방광(膀胱), 신우(腎盂),요관(尿管) 관혈수술 [개복술을 수반하는 것, 경요도적 조작 및 방광류 요실금 교정수술은 제외]	4
	46. 요도 관혈수술 [경요도적 조작은 제외함]	2
	47. 방광류 요실금 교정수술	1
	48. 신장(腎臟) 이식수술(移植手術) [수용자에 한함]	5
	49. 음경(陰莖) 절단수술(포경수술 및 음경이물제거수술은 제외)	3
	50. 고환(睾丸), 부고환(副睾丸), 정관(精管), 정색(精索), 정낭(精囊) 관혈수술, 전립선(前立腺) 관혈수술	2
	51. 음낭관혈수술	1
	52. 자궁, 난소, 난관 관혈수술 (단, 제왕절개만출술 및 경질적인 조작은 제외)	2

구분	수술명	수술종류
시각기의 수술 [안물주입술은 제외]	73. 레이저(Laser)에 의한 안구(眼球) 수술 (수술개시일 부터 60일이내 2회이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능함) [시력회복 및 시력개선 목적의 수술은 제외]	1
	74. 냉동응고(冷凍凝固)에 의한 안구(眼球) 수술 (수술개시일 부터 60일이내 2회이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능함)	2
	75. 안구적출술, 조직충전술(組織充塡術)	3
	76. 안와내종양절제수술	3
	77. 관혈적 안와내(眼窩內) 이물제거수술(異物除去手術)	1
	78. 안근(眼筋) 관혈 수술	1
청각기(聽覺器)의 수술	79. 관혈적 고막(鼓膜) 성형술 [고막 패치술은 제외]	2
	80. 유양동 절제술(乳様洞切除術, mastoidectomy)	2
	81. 중이(中耳) 관혈수술 [중이내 튜브유치술 제외]	2
	82. 중이내(中耳內) 튜브유치술 [고막 패치술은 제외, 수술개시일부터 60일이내 2회이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능함]	1
	83. 내이(內耳) 관혈수술	3
상기 이외의 수술 [검사, 처치, 약물주입요법은 포함하지 않음]	84. 상기 이외의 개두술(開頭術)	3
	85. 상기 이외의 개흉술(開胸術)	3
	86. 상기 이외의 개복술(開腹術)	2
	87. 체외충격파쇄석술(體外衝擊破碎石術, E.S.W.L) (수술개시일 부터 60일이내 2회이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능함) * 체외충격파치료술(E.S.W.T)은 제외	2

구분	수술명	수술종류
호흡기계 흉부(胸部)의 수술	15. 만성부비강염(慢性副鼻腔炎) 근본수술(根本手術)	1
	16. 후두(喉頭) 관혈적 절제수술	3
	17. 편도, 아데노이드 절제수술	1
	18. 기관(氣管), 기관지(氣管支), 폐(肺), 흉막(胸膜) 관혈수술 [개흉술(開胸術, Thoracotomy)을 수반하는 것]	4
	19. 폐쇄(肺臟) 이식수술 [수용자(受容者)에 한함]	5
	20. 흉곽(胸郭) 형성수술(形成手術)	3
	21. 종격종양(縱隔腫瘍), 흉선 절제수술[개흉술을 수반하는 것]	4
순환기계, 비장(脾臟)의수술	22. 혈관관혈수술(하지정맥류 및 손가락·발가락은 제외)	3
	23. 하지 정맥류(靜脈瘤) 근본수술 및 손가락·발가락 혈관관혈수술	1
	24. 대동맥(大動脈), 대정맥(大靜脈), 폐동맥(肺動脈), 관동맥(冠動脈) 관혈수술[개흉술, 개복술을 수반하는 것]	5
	25. 심막(心膜) 관혈수술 [개흉술을 수반하는 것]	4
	26. 심장내(心臟內) 관혈수술 [개흉술을 수반하는 것]	5
	27. 심장 이식수술 [수용자에 한함]	5
	28. 체내용(體內用) 인공심박조율기(人工心搏調律機, Artificial pacem aker) 매입술(埋入術)	3
	29. 비장(脾腸) 절제수술	3
소화기계의 수술	30. 이하선 절제수술	3
	31-1. 악하선, 설하선 절제수술	2
	31-2. 기타 타액선 절제수술(타석제거는 제외)	1
	32. 식도(食道) 이단술(離斷術) [개흉술, 개복술(開腹術, Laparotomy)을 수반하는 것]	4
	33. 위 절제수술(胃 切除手術, Gastrectomy) [개복술을 수반하는 것]	4
	34. 기타의 위식도 관혈수술[개흉술, 개복술을 수반하는 것]	3
	35. 간장(肝臟), 췌장(膵臟) 관혈수술[개복술을 수반하는 것]	4

구분	수술명	수술종류
	53. 경질적 자궁, 난소, 난관 수술 (수술개시일 부터 60일이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능함)	1
	54. 제왕절개만출술(帝王切開娩出術)	1
	55. 절단(腟腔) 근본수술	1
내분비기계의 수술	56. 뇌하수체종양(腦下垂體腫瘍) 절제수술	5
	57. 갑상선(甲狀腺)·부갑상선(副甲狀腺) 관혈수술	3
	58. 부신(副腎) 절제수술	4
신경계의 수술	59. 두개내(頭蓋內) 관혈수술 [개두술(開頭術, Cranitomy)을 수반하는 것]	5
	60. 신경(神經) 관혈수술	2
	61. 관혈적 척수종양(脊髓腫瘍) 절제수술	4
	62. 척수경막내외(脊髓硬膜內外) 관혈수술	3
시각기의 수술 [안물주입 술은 제외]	63. 안검하수증(眼檢下垂症) 수술[안검내반증 제외]	1
	64. 누소관(淚小管) 형성수술(누관류브삽입술 포함)	1
	65. 누낭비강(淚囊鼻腔) 관혈수술	2
	66. 결막낭(結膜囊) 형성수술	2
	67. 각막, 결막, 공막 봉합수술	1
	68. 각막, 공막 이식수술	2
	69. 전방(前房), 홍채(虹彩), 유리체(琉璃體) 관혈수술	2
	70. 녹내장(緑內障) 관혈수술	3
	71. 백내장(白內障), 수정체(水晶體) 관혈수술	1
	72. 망막박리(網膜剝離) 수술 (수술개시일 부터 60일이내 2회이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능함)	2

구분	수술명	수술종류
상기 이외의 수술 [검사, 처치, 약물주입요법은 포함하지 않음]	88. 내시경(Fiberscope)에 의한 내시경 수술 또는 카테터(Catheter), 고주파 전극 등에 의한 경피적 수술 (수술개시일 부터 60일이내 2회이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능함)	
	88-1. 뇌, 심장	3
	88-2. 후두, 흉부장기(심장 제외), 복부장기(비뇨, 생식기 제외), 척추, 사지관절(손가락, 발가락은 제외)	2
	88-3. 비뇨, 생식기 및 손가락, 발가락	1

주) 1. 근골(筋骨)의 수술에서 발정술(拔釘術) 등 내고정물 제거술은 제외하며, 치(齒)·치은 ·치근(齒根)·치조골(齒槽骨)의 처치, 임플란트(Implant) 등 치과 처치 및 수술에 수반하는 것도 제외합니다.
2. 상기 1~87항의 수술 중 내시경(Fiberscope)을 이용한 내시경 수술 또는 카테터(Catheter) 등에 의한 경피적(經皮的, Percutaneous) 수술은 88항을 적용합니다. 다만, 복강경·흉강경에 의한 수술은 해당부위(1~87항)의 수술로 적용합니다.

Ⅱ. 악성신생물 치료 목적의 수술

수술명	수술종류
1. 관혈적 악성 신생물(惡性新生物) 근치수술(根治手術, Radical curative surgery) 단, 기타피부암(C44) 제외 [내시경 수술, 카테터·고주파 전극 등의 경피적 수술 등은 제외함]	5
1-1. 기타피부암(C44)	3
2. 내시경 수술, 카테터·고주파 전극 등에 의한 악성 신생물 수술 (수술개시일부터 60일이내 2회이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능함)	3
3. 상기 이외의 기타 악성 신생물 수술 (수술개시일부터 60일이내 2회이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능함)	3

주) 1. 제자리암·경계성종양에 대한 수술은 'Ⅰ. 일반 상해 및 질병치료 목적의 수술' 항목의 적용을 받습니다.
2. 카테터(Catheter)를 이용한 흡인·천자·약물주입요법은 포함하지 않습니다.
3. 비고형양에 대한 비관혈적 근치술은 관혈적 악성신생물 근치수술에 준하여 5종 수술로 인정

1~5종 수술분류표 · KB손보 (1/2)

1~5종 수술분류표 KB손보 · 약관 원문 캡처 18장 중 1~10 · 상담용 참고자료

1. 일반 질병 및 상해 치료목적의 수술

구분	수술명	수술종류
피부, 유방의 수술	1. 피부이식수술(25㎠이상인 경우), 피판수술(피판분리수술, Z flap, W flap 제외)	3
	2. 피부이식수술(25㎠미만인 경우)	1
	3. 유방절단수술(切斷術, Mastectomy)	3
	4. 기타 유방수술(농양의 절개 및 배액은 제외) [단, 치료목적의 Mammotomy는 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	1
근골(筋骨)의 수술 [발정술(拔釘術) 등 내고정물 제거술은 제외함] [치(齒)·치은·치근(齒根)·치조골(齒槽骨)의 처치, 임플란트(Implant) 등 치과처치 및 수술에 수반하는 것은 제외함]	5. 골(骨) 이식수술	2
	6. 두개골(頭蓋骨, cranium) 관혈수술 [비골(鼻骨) · 비중격(鼻中隔) · 상악골(上顎骨) · 하악골(下顎骨) · 악관절(顎關節)은 제외함]	3
	7. 비골(鼻骨) 수술 [비중격 만곡증(彎曲症)수술, 수면중 무호흡 수술은 제외]	1
	8. 상악골(上顎骨), 하악골(下顎骨), 악관절(顎關節) 관혈수술	2
	9. 척추골(脊椎骨), 골반골(骨盤骨), 추간판 관혈수술	3
	10. 쇄골(鎖骨), 견갑골(肩胛骨), 늑골(肋骨), 흉골(胸骨) 관혈수술	2
	11. 사지(四肢) 절단수술(다지증에 대한 절단수술은 제외함)	
	11-1. 손가락, 발가락 절단수술 [골, 관절의 이단(離斷)에 수반하는것]	1
	11-2. 기타 사지(四肢)절단수술	3
	12. 절단(切斷)된 사지(四肢)재접합수술(再接合手術) [골, 관절의 이단(離斷)에 수반하는것]	3
	13. 사지골(四肢骨), 사지관절(四肢關節) 관혈수술	
	13-1. 손가락, 발가락의 골 및 관절 관혈수술	1
	13-2. 기타 사지골(四肢骨), 사지관절(四肢關節) 관혈수술	2
	14. 근(筋), 건(腱), 인대(靭帶), 연골(軟骨) 관혈수술	1

구분	수술명	수술종류
호흡기계, 흉부(胸部)의 수술	15. 만성부비강염(慢性副鼻腔炎) 근본수술(根本手術)	1
	16. 후두(喉頭) 관혈적 절제수술	3
	17. 편도, 아데노이드 절제수술	1
	18. 기관(氣管), 기관지(氣管支), 폐(肺), 흉막(胸膜) 관혈수술 [개흉술(開胸術, Thoracotomy)을 수반하는 것]	4
	19. 폐장(肺臟) 이식수술 [수용자(受容者)에 한함]	5
	20. 흉곽(胸郭) 형성수술(形成手術)	3
	21. 종격종양(縱隔腫瘍), 흉선 절제수술 [개흉술을 수반하는 것]	4
순환기계, 비장(脾臟)의 수술	22. 혈관관혈수술(하지정맥류 및 손가락 · 발가락은 제외)	3
	23. 하지 정맥류(靜脈瘤) 근본수술 및 손가락 · 발가락 혈관관혈수술	1
	24. 대동맥(大動脈), 대정맥(大靜脈),폐동맥(肺動脈), 관동맥(冠動脈) 관혈수술 [개흉술, 개복술을 수반하는 것]	5
	25. 심막(心膜) 관혈수술 [개흉술을 수반하는 것]	4
	26. 심장내(心藏內) 관혈수술 [개흉술을 수반하는 것]	5
	27. 심장 이식수술 [수용자에 한함]	5
	28. 체내용(體內用) 인공심박조율기(人工心搏調律機, Artificial pacemaker) 매입술(埋入術)	3
	29. 비장(脾臟) 절제수술	3

구분	수술명	수술종류
소화기계의 수술	30. 이하선 절제수술	3
	31-1. 악하선, 설하선 절제수술	2
	31-2. 기타 타액선 절제수술(타석제거는 제외)	1
	32. 식도(食道) 이단술(離斷術) [개흉술, 개복술(開腹術, Laparotomy)을 수반하는 것]	4
	33. 위 절제수술(胃 切除手術, Gastrectomy) [개복술을 수반하는 것]	4
	34. 기타의 위 · 식도 관혈수술 [개흉술, 개복술을 수반하는 것]	3
	35. 간장(肝臟), 췌장(膵臟) 관혈수술 [개복술을 수반하는 것]	4
	36. 담낭(膽囊), 담도(膽道) 관혈수술 [개복술을 수반하는 것]	3
	37. 간장 이식수술 [수용자에 한함, 개복술을 수반하는 것]	5
	38. 췌장 이식수술 [개복술을 수반해야 하며 수용자에 한함] (단, 랑게르한스 소도(Islet of Langerhans)세포 이식수술은 제외)	5
	39. 탈장(脫腸) 근본수술	1
	40. 전신성 복막염(全身性 腹膜炎, Generalized peritonitis) 수술	2
	41. 충수(蟲垂)절제술(충수염관련 충수주위 농양수술, 국한성 복막염 수술 포함), 맹장봉축술(盲腸縫縮術)	2
	42. 직장탈(直腸脫) 근본수술	1
	43. 소장(小腸), 결장(結腸), 직장(直腸), 장간막(腸間膜) 관혈수술 [개복술을 수반하는 것] (단, 직장탈근본수술은 제외)	4
	44. 치루(痔瘻), 탈항(脫肛), 치핵(痔核) 근본수술 [근치를 목적으로 하지 않은 수술은 제외함]	1

구분	수술명	수술종류
비뇨기계 · 생식기계의 수술 (인공임신중절수술은 제외함)	45. 신장(腎臟), 방광(膀胱), 신우(腎盂), 요관(尿管)관혈수술 [개복술을 수반하는 것, 경요도적 조작 및 방광류 · 요실금 교정수술은 제외]	4
	46. 요도 관혈수술 [경요도적 조작은 제외함]	2
	47. 방광류 · 요실금 교정수술	1
	48. 신장(腎臟) 이식수술(移植手術) [수용자에 한함]	5
	49. 음경(陰莖) 절단수술 (포경수술 및 음경이물제거수술은 제외)	3
	50. 고환(睾丸), 부고환(副睾丸), 정관(精管), 정색(精索), 정낭(精囊)관혈수술, 전립선(前立腺)관혈수술	2
	51. 음낭관혈수술	1
	52. 자궁, 난소, 난관 관혈수술 (단, 제왕절개만출술 및 경질적인 조작은 제외)	2
	53. 경질적 자궁, 난소, 난관 수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	1
내분비기계의 수술	54. 제왕절개만출술(帝王切開娩出術)	1
	55. 질탈(膣脫)근본수술	1
	56. 뇌하수체종양(腦下垂體腫瘍) 절제수술	5
	57. 갑상선(甲狀腺) · 부갑상선(副甲狀腺) 관혈수술	3
	58. 부신(副腎) 절제수술	4
신경계의 수술	59. 두개내(頭蓋內) 관혈수술 [개두술(開頭術, Craniotomy)을 수반하는 것]	5
	60. 신경(神經) 관혈수술	2
	61. 관혈적 척수종양(脊髓腫瘍) 절제수술	4
	62. 척수경막내외(脊髓硬膜內外) 관혈수술	3

구분	수술명	수술종류
시각기의 수술 [약물주입술은 제외]	63. 안검하수증(眼檢下垂症)수술(안검내반증 제외)	1
	64. 누소관(淚小管)형성수술(누관튜브삽입술 포함)	1
	65. 누낭비강(淚囊鼻腔) 관혈수술	2
	66. 결막낭(結膜囊) 형성수술	2
	67. 각막, 결막, 공막 봉합수술	1
	68. 각막, 공막 이식수술	2
	69. 전방(前房), 홍채(虹彩), 유리체(琉璃體) 관혈수술	2
	70. 녹내장(綠內障) 관혈수술	3
	71. 백내장(白內障), 수정체(水晶體) 관혈수술	1
	72. 망막박리(網膜剝離) 수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	2
시각기의 수술 [약물주입술은 제외]	73. 레이저(Laser)에 의한 안구(眼球) 수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.] [시력회복 및 시력개선목적의 수술은 제외]	1
	74. 냉동응고(冷凍凝固)에 의한 안구(眼球) 수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	2
	75. 안구적출술, 조직충전술(組織充塡術)	3
	76. 안와내종양절제수술	3
	77. 관혈적 안와내(眼窩內) 이물제거수술(異物除去手術)	1
	78. 안근(眼筋)관혈수술	1

구분	수술명	수술종류
청각기(聽覺器)의 수술	79. 관혈적 고막(鼓膜) 성형술 [고막 패치술은 제외]	2
	80. 유양동 절제술(乳樣洞切除術, mastoidectomy)	2
	81. 중이(中耳) 관혈수술 [중이내 튜브유치술 제외]	2
	82. 중이내(中耳內) 튜브유치술 [고막 패치술은 제외, 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	1
	83. 내이(內耳) 관혈수술	3
상기 이외의 수술 [검사, 처치, 약물주입요법은 포함하지 않음]	84. 상기 이외의 개두술(開頭術)	3
	85. 상기 이외의 개흉술(開胸術)	3
	86. 상기 이외의 개복술(開腹術)	2
	87. 체외충격파쇄석술(體外衝擊破碎石術, E.S.W.L) [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.] * 체외충격파치료술(E.S.W.T)은 제외	2
	88. 내시경(Fiberscope)에 의한 내시경 수술 또는 카테터(Catheter)·고주파 전극 등에 의한 경피적 수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	
	88-1. 뇌, 심장	3
	88-2. 후두, 흉부장기(심장 제외), 복부장기(비뇨, 생식기 제외), 척추, 사지관절(손가락, 발가락은 제외)	2
	88-3. 비뇨, 생식기 및 손가락, 발가락	1

주) 상기 1-87항의 수술 중 내시경(Fiberscope)을 이용한 내시경 수술 또는 카테터(Catheter) 등에 의한 경피적(經皮的,Percutaneous) 수술은 88항을 적용합니다. 다만, 복강경 · 흉강경에 의한 수술은 해당부위(1-87항)의 수술로 적용합니다.

2. 악성신생물 치료 목적의 수술

수술명	수술종류
1. 관혈적 악성신생물(惡性新生物) 근치수술(根治手術, Radical curative surgery) 단, 기타피부암(C44) 제외 [내시경 수술, 카테터 · 고주파 전극 등의 경피적 수술 등은 제외함]	5
1-1. 기타피부암(C44)	3
2. 내시경 수술, 카테터 · 고주파 전극 등에 의한 악성신생물 수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	3
3. 상기 이외의 기타 악성신생물수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	3

주) 1. 제자리암 · 경계성종양에 대한 수술은 "1. 일반 질병 및 상해치료 목적의 수술" 항목의 적용을 받습니다.
2. 카테터(Catheter)를 이용한 흡인 · 천자 · 약물주입요법은 포함하지 않습니다.
3. 비고형암에 대한 비관혈적 근치술은 관혈적 악성신생물 근치수술에 준하여 5종 수술로 인정합니다.
- 비고형암에 대한 비관혈적 근치술 중 조혈모세포 이식술은 일련의 과정(추출, 필터링, 배양, 제거, 주입)을 모두 포함하여 1회의 수술로 인정합니다.
- 다만 약물 등을 투여하기 위한 시술(예. 중심정맥삽관술)만 시행할 경우에는 5종으로 인정하지 않습니다.

3. 악성신생물 근치 · 두개내신생물 근치 방사선 조사 분류표

수술명	수술종류
1. 악성신생물 근치 방사선 조사 [5,000Rad 이상의 조사(照射)를 하는 경우로 한정하며, 악성신생물 근치 사이버 나이프(Cyberknife) 정위적 방사선 치료(定位的 放射線 治療, Stereotactic radiotherapy)를 포함함]	3
2. 두개내 신생물 근치 감마 나이프(Gammaknife) 정위적 방사선 치료	3

주) 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.

[1-5종수술II 분류표 사용 지침]

1. "수술"이라 함은 의료법 제5조(의사, 치과의사 및 한의사 면허)에 규정한 의사, 치과의사 면허를 가진 자가 피보험자의 질병 또는 상해로 인한 치료를 직접목적으로 필요하다고 인정한 경우로서 자택 등에서 치료가 곤란하여 의료법 제63조(의료기관)의 규정에서 정한 국내의 병원이나 의원 또는 국외의 의료관련법에서 정한 의료기관에서 의사의 관리하에 "1-5종수술II 분류표"에 정한 행위를 받는 경우를 말합니다. "수술"은 의료기구를 사용해서 생체(生體)에 절단(切斷, 특정부위를 잘라 내는 것), 절제(切除, 특정부위를 잘라 없애는 것) 등의 조작(操作)을 가하는 것(보건복지부 산하 신의료기술평가위원회(향후 제도변경시에는 동 위원회와 동일한 기능을 수행하는 기관)로부터 안전성과 치료효과를 인정받은 최신 수술기법도 포함됩니다)을 말합니다. 다만, 흡인(吸引, 주사기 등으로 빨아 들이는 것), 천자(穿刺, 바늘 또는 관을 꽂아 체액 · 조직을 뽑아내거나 약물을 주입하는 것) 등의 조치 및 신경차단(神經遮斷, NerveBlock)은 "수술"에서 제외합니다.

2. "관혈(觀血)" 수술이라 함은 병변 부위를 육안으로 직접 보면서 수술적 조작을 하기 위해 피부에 절개를 가하고 병변부위를 노출시켜서 수술하는 것을 말합니다.

3. "근본(根本)" 혹은 "근치(根治)" 수술이라 함은 일회의 수술로 해당 질병을 완전히 치유할 수 있는 수술을 말합니다.

4. "관혈적 악성신생물 근치수술"이라 함은 관혈적 방법을 통해 악성신생물의 원발병소를 완전히 절제, 적출, 적출하고 혹은 곽청술을 함께 실시한 경우입니다.

5. "1-5종수술II 분류표" 상에 열거되지 않은 선진의료적 첨단 수술에 대한 인정 및 적용 기준
: "1-5종수술II 분류표"에서의 선진의료적 첨단 수술은 상기 "수술"의 정의에 해당하여야 하고 약물투여치료, 방사선조사치료 또는 기타의 보존적 치료로 분류될 수 없는 경우이어야 합니다.

1) "1-5종수술II 분류표" 상의 수술 이외에 보건복지부 산하 신의료기술평가위원회(향후 제도 변경시에는 동 위원회와 동일한 기능을 수행하는 기관)로부터 안전성과 치료효과를 인정받은 최신 수술기법으로 치료한 경우 "1-5종수술II 분류표" 상의 동일부위 수술로 봅니다. 이 때에 해당 최신수술기법은 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.

2) 단, 이 선진의료적 첨단 수술이 본질적으로 내시경(Fiberscope)에 의한 내시경 수술 또는 카테터(Catheter) 등에 의한 경피적 수술인 경우에는 "1-5종 수술II 분류표" 중 "1. 일반 질병 및 상해 치료 목적의 수술" 88항 (악성신생물의 경우는 "2. 악성신생물 치료 목적의 수술" 2항)을 우선 적용합니다.

6. "악성 신생물 근치 사이버 나이프(Cyberknife) 정위적 방사선 치료"라 함은 선형가속기(LINAC)에서 발생되는 가는 방사선(Pencil beam)들을 다양한 각도에서 악성신생물을 향해 집중적으로 조사하면서 동시에 악성신생물의 움직임을 병변 추적장치를 이용하여 실시간으로 추적하면서 치료하는 방법입니다.

7. "두개내 신생물 근치 감마나이프 (Gammaknife)정위적 방사선 치료"라 함은 정위좌표계를 이용하여 코발트 60 방사성 동위원소 (Co-60) 에서 나오는 감마선을 두개강 내의 신생물을 향해 집중 조사함으로 두개(頭蓋)를 열지 않고도 수술적 제거와 같은 효과를 내는 치료를 말합니다.

8. 다음과 같은 수술은 수술보험금 지급대상에서 보장을 제외합니다.
1) 미용 성형상의 수술
2) 피임(避妊) 목적의 수술
3) 피임 및 불임술 후 가임목적의 수술
4) 검사 및 진단을 위한 수술[생검(生檢), 복강경 검사(腹腔鏡檢査) 등]

1~5종 수술분류표 · KB손보 (2/2)

1~5종 수술분류표 KB손보 · 약관 원문 캡처 18장 중 11~18 · 상담용 참고자료

구분	수술명	수술종류
호흡기계, 흉부(胸部)의 수술	15. 만성부비강염(慢性副鼻腔炎) 근본수술(根本手術)	1
	16. 후두(喉頭) 관혈적 절제수술	3
	17. 편도, 아데노이드 절제수술	1
	18. 기관(氣管), 기관지(氣管支), 폐(肺), 흉막(胸膜) 관혈수술 [개흉술(開胸術, Thoracotomy)을 수반하는 것]	4
	19. 폐장(肺臟) 이식수술 [수용자(受容者)에 한함]	5
	20. 흉곽(胸郭) 형성수술(形成手術)	3
	21. 종격종양(縱隔腫瘍), 흉선 절제수술 [개흉술을 수반하는 것]	4
순환기계, 비장(脾腸)의 수술	22. 혈관관혈수술(하지정맥류 및 손가락 · 발가락은 제외)	3
	23. 하지 정맥류(靜脈瘤) 근본수술 및 손가락 · 발가락 혈관관혈수술	1
	24. 대동맥(大動脈), 대정맥(大靜脈),폐동맥(肺動脈), 관동맥(冠動脈) 관혈수술 [개흉술, 개복술을 수반하는 것]	5
	25. 심막(心膜) 관혈수술 [개흉술을 수반하는 것]	4
	26. 심장내(心藏內) 관혈수술 [개흉술을 수반하는 것]	5
	27. 심장 이식수술 [수용자에 한함]	5
	28. 체내용(體內用) 인공심박조율기(人工心搏調律機, Artificial pacemaker) 매입술(埋入術)	3
	29. 비장(脾腸) 절제수술	3

구분	수술명	수술종류
소화기계의 수술	30. 이하선 절제수술	3
	31-1. 악하선, 설하선 절제수술	2
	31-2. 기타 타액선 절제수술(타석제거는 제외)	1
	32. 식도(食道) 이단술(離斷術) [개흉술, 개복술(開腹術, Laparotomy)을 수반하는 것]	4
	33. 위 절제수술(胃 切除手術, Gastrectomy) [개복술을 수반하는 것]	4
	34. 간담의 위 · 식도 관혈수술 [개흉술, 개복술을 수반하는 것]	3
	35. 간장(肝臟), 췌장(膵臟) 관혈수술 [개복술을 수반하는 것]	4
	36. 담낭(膽囊), 담도(膽道) 관혈수술 [개복술을 수반하는 것]	3
	37. 간장 이식수술 [수용자에 한함, 개복술을 수반하는 것]	5
	38. 췌장 이식수술 [개복술을 수반해야 하며 수용자에 한함] (단, 랑게르한스 소도(Islet of Langerhans)세포 이식수술은 제외)	5
	39. 탈장(脫腸) 근본수술	1
	40. 전신성 복막염(全身性 腹膜炎, Generalized peritonitis) 수술	2
	41. 충수(蟲垂)절제술(충수염관련 충수주위 농양수술, 국한성 복막염 수술 포함), 맹장봉축술(盲腸縫縮術)	2
	42. 직장탈(直腸脫) 근본수술	1
	43. 소장(小腸), 결장(結腸), 직장(直腸), 장간막(腸間膜) 관혈수술 [개복술을 수반하는 것] (단, 직장탈근본수술은 제외)	4
	44. 치루(痔瘻), 탈항(脫肛), 치핵(痔核) 근본수술 [근치를 목적으로 하지 않은 수술은 제외함]	1

구분	수술명	수술종류
비뇨기계 · 생식기계의 수술 (인공임신중절수술은 제외함)	45. 신장(腎臟), 방광(膀胱), 신우(腎盂), 요관(尿管)관혈수술 [개복술을 수반하는 것, 경요도적 조작 및 방광류 · 요실금 교정수술은 제외]	4
	46. 요도 관혈수술 [경요도적 조작은 제외함]	2
	47. 방광류 · 요실금 교정수술	1
	48. 신장(腎臟) 이식수술(移植手術) [수용자에 한함]	5
	49. 음경(陰莖) 절단수술 (포경수술 및 음경이물제거수술은 제외)	3
	50. 고환(睾丸), 부고환(副睾丸), 정관(精管), 정색(精索), 정낭(精囊)관혈수술, 전립선(前立腺)관혈수술	2
	51. 음낭관혈수술	1
	52. 자궁, 난소, 난관 관혈수술 (단, 제왕절개만출술 및 경질적인 조작은 제외)	2
	53. 경질적 자궁, 난소, 난관 수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	1
	54. 제왕절개만출술(帝王切開娩出術)	1
	55. 질탈(膣脫)근본수술	1
내분비기계의 수술	56. 뇌하수체종양(腦下垂體腫瘍) 절제수술	5
	57. 갑상선(甲狀腺) · 부갑상선(副甲狀腺) 관혈수술	3
	58. 부신(副腎) 절제수술	4
신경계의 수술	59. 두개내(頭蓋內) 관혈수술 [개두술(開頭術, Craniotomy)을 수반하는 것]	5
	60. 신경(神經) 관혈수술	2
	61. 관혈적 척수종양(脊髓腫瘍) 절제수술	4
	62. 척수경막내외(脊髓硬膜內外) 관혈수술	3

구분	수술명	수술종류
시각기의 수술 [약물주입술은 제외]	63. 안검하수증(眼檢下垂症)수술(안검내반증 제외)	1
	64. 누소관(淚小管)형성수술(누관튜브삽입술 포함)	1
	65. 누낭비강(淚囊鼻腔) 관혈수술	2
	66. 결막낭(結膜囊) 형성수술	2
	67. 각막, 결막, 공막 봉합수술	1
	68. 각막, 공막 이식수술	2
	69. 전방(前房), 홍채(虹彩), 유리체(琉璃體) 관혈수술	2
	70. 녹내장(綠內障) 관혈수술	3
	71. 백내장(白內障), 수정체(水晶體) 관혈수술	1
	72. 망막박리(網膜剝離) 수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	2
시각기의 수술 [약물주입술은 제외]	73. 레이저(Laser)에 의한 안구(眼球) 수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.] [시력회복 및 시력개선목적의 수술은 제외]	1
	74. 냉동응고(冷凍凝固)에 의한 안구(眼球) 수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	2
	75. 안구적출술, 조직충전술(組織充塡術)	3
	76. 안와내종양절제수술	3
	77. 관혈적 안와내(眼窩內) 이물제거수술(異物除去手術)	1
	78. 안근(眼筋)관혈수술	1

구분	수술명	수술종류
청각기(聽覺器)의 수술	79. 관혈적 고막(鼓膜) 성형술 [고막 패치술은 제외]	2
	80. 유양동 절제술(乳樣洞切除術, mastoidectomy)	2
	81. 중이(中耳) 관혈수술 [중이내 튜브유치술 제외]	2
	82. 중이내(中耳內) 튜브유치술 [고막 패치술은 제외, 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	1
	83. 내이(內耳) 관혈수술	3
상기 이외의 수술 [검사, 처치, 약물주입요법은 포함하지 않음]	84. 상기 이외의 개두술(開頭術)	3
	85. 상기 이외의 개흉술(開胸術)	3
	86. 상기 이외의 개복술(開腹術)	2
	87. 체외충격파쇄석술(體外衝擊破碎石術, E.S.W.L) [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.] * 체외충격파치료술(E.S.W.T)은 제외	2
	88. 내시경(Fiberscope)에 의한 내시경 수술 또는 카테터(Catheter)·고주파 전극 등에 의한 경피적 수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	
	88-1. 뇌, 심장	3
	88-2. 후두, 흉부장기(심장 제외), 복부장기(비뇨, 생식기 제외), 척추, 사지관절(손가락, 발가락은 제외) * 단, 대장의 용종 또는 대장의 양성신생물의 내시경적 절제술은 1종으로 분류합니다.	2
	88-3. 비뇨, 생식기 및 손가락, 발가락	1

주) 상기 1-87항의 수술 중 내시경(Fiberscope)을 이용한 내시경 수술 또는 카테터(Catheter) 등에 의한 경피적(經皮的,Percutaneous) 수술은 88항을 적용합니다. 다만, 복강경 · 흉강경에 의한 수술은 해당부위(1-87항)의 수술로 적용합니다.

2. 악성신생물 치료 목적의 수술

수술명	수술종류
1. 관혈적 악성신생물(惡性新生物) 근치수술(根治手術, Radical curative surgery) 단, 기타피부암(C44) 제외 [내시경 수술, 카테터 · 고주파 전극 등의 경피적 수술 등은 제외함]	5
1-1. 기타피부암(C44)	3
2. 내시경 수술, 카테터 · 고주파 전극 등에 의한 악성신생물 수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	3
3. 상기 이외의 기타 악성신생물수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	3

주) 1. 제자리암 · 경계성종양에 대한 수술은 "1. 일반 질병 및 상해치료 목적의 수술" 항목의 적용을 받습니다.
2. 카테터(Catheter)를 이용한 흡인 · 천자 · 약물주입요법은 포함하지 않습니다.
3. 비고형암에 대한 비관혈적 근치술은 관혈적 악성신생물 근치수술에 준하여 5종 수술로 인정합니다.
- 비고형암에 대한 비관혈적 근치술 중 조혈모세포 이식술은 일련의 과정(추출, 필터링, 배양, 제거, 주입)을 모두 포함하여 1회의 수술로 인정합니다.
- 다만 약물 등을 투여하기 위한 시술(예. 중심정맥삽관술)만 시행할 경우에는 5종으로 인정하지 않습니다.

3. 악성신생물 근치 · 두개내신생물 근치 방사선 조사 분류표

수술명	수술종류
1. 악성신생물 근치 방사선 조사 [5,000Rad 이상의 조사(照射)를 하는 경우로 한정하며, 악성신생물 근치 사이버 나이프(Cyberknife) 정위적 방사선 치료(定位的 放射線 治療, Stereotactic radiotherapy)를 포함함]	3
2. 두개내 신생물 근치 감마 나이프(Gammaknife) 정위적 방사선 치료	3

주) 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.

[1-5종수술III 분류표 사용 지침]

1. "수술"이라 함은 의료법 제5조(의사, 치과의사 및 한의사 면허)에 규정한 의사, 치과의사 면허를 가진 자가 피보험자의 질병 또는 상해로 인한 치료를 직접목적으로 필요하다고 인정한 경우로서 자격 등에서 치료가 근관하여 의료법 제3조(의료기관)의 규정에서 정한 국내의 병원이나 의원 또는 국외의 의료관련법에서 정한 의료기관에서 의사의 관리하에 "1-5종수술III 분류표"에 정한 행위를 받는 경우를 말합니다. "수술"은 의료기구를 사용해서 생체(生體)에 절단(切斷, 특정부위를 잘라 내는 것), 절제(切除, 특정부위를 잘라 없애는 것) 등의 조작(操作)을 가하는 것(보건복지부 산하 신의료기술평가위원회(향후 제도변경시에는 동 위원회와 동일한 기능을 수행하는 기관)로부터 안전성과 치료효과를 인정받은 최신 수술기법도 포함됩니다)을 말합니다. 다만, 흡인(吸引, 주사기 등으로 빨아 들이는 것), 천자(穿刺, 바늘 또는 관을 꽂아 체액 · 조직을 뽑아내거나 약물을 주입하는 것) 등의 조치 및 신경차단(神經遮斷, NerveBlock)은 "수술"에서 제외합니다.

2. "관혈(觀血)" 수술이라 함은 병변 부위를 육안으로 직접 보면서 수술적 조작을 하기 위해 피부에 절개를 가하고 병변부위를 노출시켜서 수술하는 것을 말합니다.

3. "근본(根本)" 혹은 "근치(根治)" 수술이라 함은 일회의 수술로 해당 질병을 완전히 치유할 수 있는 수술을 말합니다.

4. "관혈적 악성신생물 근치수술"이라 함은 관혈적 방법을 통해 악성신생물의 원발병소를 완전히 절제, 적제, 적출하고 혹은 광청술을 함께 실시한 경우입니다.

5. "1-5종수술III 분류표" 상에 열거되지 않은 선진의료적 첨단 수술에 대한 인정 및 적용 기준
: "1-5종수술III 분류표"에서의 선진의료적 첨단 수술은 상기 "수술"의 정의에 해당하여야 하고 약물투여치료, 방사선조사치료 또는 기타의 보존적 치료로 분류될 수 없는 경우이어야 합니다.

1) "1-5종수술III 분류표" 상의 수술 이외에 보건복지부 산하 신의료기술평가위원회(향후 제도 변경시에는 동 위원회와 동일한 기능을 수행하는 기관)로부터 안전성과 치료효과를 인정받은 최신 수술기법으로 치료한 경우 "1-5종수술III 분류표" 상의 동일부위 수술로 봅니다. 이 때에 해당 최신수술기법은 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.

2) 단, 이 선진의료적 첨단 수술이 본질적으로 내시경(Fiberscope)에 의한 내시경 수술 또는 카테터(Catheter) 등에 의한 경피적 수술인 경우에는 "1-5종수술III 분류표" 중 "1. 일반 질병 및 상해 치료 목적의 수술" 88항 (악성신생물의 경우는 "2. 악성신생물 치료 목적의 수술" 2항)을 우선 적용합니다.

6. "악성 신생물 근치 사이버 나이프(Cyberknife) 정위적 방사선 치료"라 함은 선형가속기(LINAC)에서 발생되는 가는 방사선(Pencil beam)들을 다양한 각도에서 악성신생물을 향해 집중적으로 조사하면서 동시에 악성신생물의 움직임을 병변 추적장치를 이용하여 실시간으로 추적하면서 치료하는 방법입니다.

7. "두개내 신생물 근치 감마나이프 (Gammaknife)정위적 방사선 치료"라 함은 정위좌표계를 이용하여 코발트 60 방사성 동위원소 (Co-60) 에서 나오는 감마선을 두개강 내의 신생물을 향해 집중 조사함으로 두개(頭蓋)를 열지 않고도 수술적 제거와 같은 효과를 내는 치료를 말합니다.

8. 다음과 같은 수술은 수술보험금 지급대상에서 보장을 제외합니다.
1) 미용 성형상의 수술
2) 피임(避妊) 목적의 수술
3) 피임 및 불임술 후 가임목적의 수술
4) 검사 및 진단을 위한 수술[생검(生檢), 복강경 검사(腹腔鏡檢査) 등]

1~5종 수술분류표 · 한화손보

1~5종 수술분류표 한화손보 · 약관 원문 캡처 5장 · 상담용 참고자료

Ⅰ. 일반적인 상해 및 질병 치료목적의 수술

구분	수술명	수술종류(종)
피부, 유방의 수술	1. 피부이식수술(25㎠이상인 경우), 피판수술(피판분리수술, Z flap, W flap 제외)	3
	2. 피부이식수술(25㎠미만인 경우)	1
	3. 유방절단수술(切斷術, Mastectomy) 단, 유방의 비대(N62)로 인한 유방절단수술 제외	3
	3-1. 유방의 비대(N62)로 인한 유방절단수술	1
	4. 기타 유방수술(농양의 절개 및 배액은 제외)	1
근골(筋骨)의 수술 [발정술(拔釘術) 등 내고정물 제거술은 제외함] [치(齒)·치은·치근(齒根)·치조골(齒槽骨)의 처치, 임플란트(Implant) 등 치과 처치 및 수술에 수반하는 것은 제외함]	5. 골(骨) 이식수술	2
	6. 두개골(頭蓋骨, cranium) 관혈수술 [비골(鼻骨) · 비중격(鼻中隔) · 상악골(上顎骨) · 하악골(下顎骨) · 악관절(顎關節)은 제외함]	3
	7. 비골(鼻骨) 수술 [비중격 만곡증(彎曲症)수술 제외]	1
	8. 상악골(上顎骨), 하악골(下顎骨), 악관절(顎關節) 관혈수술	2
	9. 척추골(脊椎骨), 골반골(骨盤骨), 추간판 관혈수술	3
	10. 쇄골(鎖骨), 견갑골(肩胛骨), 늑골(肋骨), 흉골(胸骨) 관혈수술	2
	11. 사지(四肢) 절단수술(다지증에 대한 절단수술은 제외함) 11-1. 손가락, 발가락 절단수술 [골, 관절의 이단(離斷)에 수반하는 것] 11-2. 기타 사지(四肢)절단수술	1 3
	12. 절단(切斷)된 사지(四肢)재접합수술(再接合手術) [골, 관절의 이단(離斷)에 수반하는 것]	3
	13. 사지골(四肢骨), 사지관절(四肢關節) 관혈수술 13-1. 손가락, 발가락의 골 및 관절 관혈수술 13-2. 기타 사지골(四肢骨), 사지관절(四肢關節) 관혈수술	1 2
	14. 근(筋), 건(腱), 인대(靭帶), 연골(軟骨) 관혈수술	1
호흡기계, 흉부(胸部)의 수술	15. 만성부비강염(慢性副鼻腔炎) 근본수술(根本手術)	1
	16. 후두(喉頭) 관혈적 절제수술	3
	17. 편도, 아데노이드 절제수술	1
	18. 기관(氣管), 기관지(氣管支), 폐(肺), 흉막(胸膜) 관혈수술 [개흉술(開胸術, Thoracotomy)을 수반하는 것]	4
	19. 폐절(肺瘸) 이식수술[수용자(受容者)에 한함]	5
	20. 흉곽(胸郭) 형성수술(形成手術)	3
	21. 종격종양(縱隔腫瘍), 흉선 절제수술 [개흉술을 수반하는 것]	4

구분	수술명	수술종류(종)
순환기계, 비장(脾腸)의 수술	22. 혈관관혈수술(하지정맥류 및 손가락·발가락은 제외)	3
	23. 하지 정맥류(靜脈瘤) 근본수술 및 손가락·발가락 혈관관혈수술	1
	24. 대동맥(大動脈), 대정맥(大靜脈), 폐동맥(肺動脈), 관동맥(冠動脈) 관혈수술[개흉술, 개복술을 수반하는 것]	5
	25. 심막(心膜) 관혈수술 [개흉술을 수반하는 것]	4
	26. 심장(心臟)의 관혈수술 [개흉술을 수반하는 것]	5
	27. 심장 이식수술 [수용자에 한함]	5
	28. 체내용(體內用) 인공심박조율기(人工心搏調律機, Artificial pacemaker) 매입술(埋入術)	3
	29. 비장(脾腸) 절제수술	3
소화기계의 수술	30. 이하선 절제수술	3
	31-1. 악하선, 설하선 절제수술	2
	31-2. 기타 타액선 절제수술(타석제거는 제외)	1
	32. 식도(食道) 이단술(離斷術) [개흉술, 개복술(開腹術, Laparotomy)을 수반하는 것]	4
	33. 위 절제수술(胃 切除手術, Gastrectomy) [개복술을 수반하는 것]	4
	34. 기타의 위·식도 관혈수술 [개흉술, 개복술을 수반하는 것]	3
	35. 간장(肝臟), 췌장(膵臟) 관혈수술 [개복술을 수반하는 것]	4
	36. 담낭(膽囊), 담도(膽道) 관혈수술 [개복술을 수반하는 것]	3
	37. 간장 이식수술 [수용자에 한함, 개복술을 수반하는 것]	5
	38. 췌장 이식수술 [개복술을 수반해야 하며 수용자에 한함] (단, 랑게르한스 소도(Islet of Langerhans)세포 이식수술은 제외함)	5
	39. 탈장(脫腸) 근본수술	1
	40. 전신성 복막염(全身性腹膜炎, Generalized peritonitis) 수술	2
	41. 충수(蟲垂)절제술(충수염관련 충수주위 농양수술, 국한성 복막염 수술 포함), 맹장봉축술(盲腸縫縮術)	2
	42. 직장탈(直腸脫) 근본수술	1
	43. 소장(小腸), 결장(結腸), 직장(直腸), 장간막(腸間膜) 관혈수술 [개복술을 수반하는 것] 단, 직장탈근본수술은 제외	4
	44. 치루(痔瘻), 탈항(脫肛), 치핵(痔核) 근본수술 [근치를 목적으로 하지 않은 수술은 제외]	1

구분	수술명	수술종류(종)
비뇨기계 생식기계의 수술 [인공임신중절 수술은 제외함]	45. 신장(腎臟), 방광(膀胱), 신우(腎盂), 요관(尿管)관혈수술 [개복술을 수반하는 것, 경요도적 조작 및 방광류·요실금 교정수술은 제외]	4
	46. 요도 관혈수술 [경요도적 조작은 제외함]	2
	47. 방광류 교정수술	1
	48. 요실금수술(금여)	1
	49. 신장(腎臟) 이식수술(移植手術) [수용자에 한함]	5
	50. 음경(陰莖) 절단수술(포경수술 및 음경이물제거수술은 제외)	3
	51. 고환(睾丸), 부고환(副睾丸), 정관(精管), 정색(精索), 정낭(精囊)관혈수술, 전립선(前立腺)관혈수술	2
	52. 음낭관혈수술	1
	53. 자궁, 난소, 난관 관혈수술 (단, 제왕절개만출술 및 경질적인 조작은 제외)	2
	54. 경질적 자궁, 난소, 난관 수술	1
	55. 제왕절개만출술(帝王切開娩出術)	1
	56. 질탈(膣脫)근본수술	1
내분비기계의 수술	57. 뇌하수체종양(腦下垂體腫瘍) 절제수술	5
	58. 갑상선(甲狀腺)·부갑상선(副甲狀腺) 관혈수술	3
	59. 부신(副腎) 절제수술	4
신경계의 수술	60. 두개내(頭蓋內) 관혈수술 [개두술(開頭術, Craniotomy)을 수반하는 것]	5
	61. 신경(神經) 관혈수술	2
	62. 관혈적 척수종양(脊髓腫瘍) 절제수술	4
	63. 척수경막내외(脊髓硬膜內外) 관혈수술	3
시각기의 수술 [약물주입술은 제외]	64. 안검하수술(眼瞼下垂症)수술	1
	65. 누소관(淚小管)형성수술(누관튜브삽입술 포함)	1
	66. 누낭비강(淚囊鼻腔) 관혈수술	2
	67. 결막낭(結膜囊) 형성수술	2
	68. 각막, 결막, 공막 봉합수술	1
	69. 각막, 공막 이식수술	2
	70. 전방(前房), 홍채(虹彩), 유리체(琉璃體) 관혈수술	2
	71. 녹내장(綠內障) 관혈수술	3
	72. 백내장(白內障), 수정체(水晶體) 관혈수술	1
	73. 망막박리(網膜剝離) 수술	2
	74. 레이저(Laser)에 의한 안구(眼球) 수술(시력회복 및 시력개선 목적의 수술은 제외)	1

구분	수술명	수술종류(종)
	75. 냉동응고(冷凍凝固)에 의한 안구(眼球) 수술	2
	76. 안구적출술, 조직충전술(組織充塡術)	3
	77. 안와내용양절제수술	3
	78. 관혈적 안와내(眼窩內) 이물제거수술(異物除去手術)	1
	79. 안근(眼筋)관혈수술	1
청각기(聽覺器)의 수술	80. 관혈적 고막(鼓膜) 성형술 [고막 패치술은 제외]	2
	81. 유양동 절제술(乳樣洞切除術, mastoidectomy)	2
	82. 중이(中耳) 관혈수술 [중이내 튜브유치술 제외]	2
	83. 중이내(中耳內) 튜브유치술 [고막 패치술은 제외]	1
	84. 내이(內耳) 관혈수술	3
상기 이외의 수술 [검사, 처치, 약물주입요법은 포함하지 않음]	85. 상기 이외의 개두술(開頭術)	3
	86. 상기 이외의 개흉술(開胸術)	3
	87. 상기 이외의 개복술(開腹術)	2
	88. 체외충격파쇄석술(體外衝擊破碎石術, E.S.W.L) * 체외충격파치료술(E.S.W.T)은 제외	1
	89. 내시경(Fiberscope)에 의한 내시경 수술 또는 카테터(Catheter)· 고주파 전극 등에 의한 경피적 수술 89-1. 뇌, 심장 89-2. 후두, 흉부장기(심장 제외), 복부장기(비뇨, 생식기 제외), 척추, 사지관절(손가락, 발가락은 제외) 89-3. 비뇨, 생식기 및 손가락, 발가락	3 2 1

주1) 상기 1~88항의 수술 중 내시경(Fiberscope)을 이용한 내시경 수술 또는 카테터(Catheter)· 고주파 전극 등에 의한 경피적 수술은 89항을 적용합니다. 다만, 복강경·흉강경에 의한 수술은 해당부위(1~88항)의 수술로 적용합니다.

주2) 상기 44항(치루(痔瘻), 탈항(脫肛), 치핵(痔核) 근본수술), 48항(요실금수술(금여)), 55항(제왕절개만출술(帝王切開娩出術)) 수술은 질병1~5종수술비Ⅲ 및 질병1~5종수술비Ⅳ(수술1회당) 보장에만 적용되며, 상해1~5종수술비Ⅲ 및 상해1~5종수술비Ⅳ(수술1회당) 보장은 보상하지 않습니다. 또한 48항(요실금수술(금여))은 피보험자가 남성인 경우 보상하지 않습니다.

Ⅱ. 악성신생물 치료 목적의 수술

수술명	수술종류(종)
1. 관혈적 악성신생물(惡性新生物) 근치수술(根治手術, Radical curative surgery) 단, 기타피부암(C44) 제외 [내시경 수술, 카테터·고주파 전극 등의 경피적 수술 등은 제외함] 1-1. 기타피부암(C44)	5 3
2. 내시경 수술	3
3. 상기 이외의 기타 악성신생물수술	3

주1) 제자리암·경계성종양에 대한 수술은 'Ⅰ. 일반적인 상해 및 질병치료 목적의 수술' 항목의 적용을 받습니다.

주2) 카테터(Catheter)를 이용한 흡인·천자·약물주입요법은 포함하지 않습니다.

주3) 비고형암에 대한 비관혈적 근치수술은 관혈적 악성신생물 근치수술에 준하여 5종 수술로 인정합니

Ⅲ. 악성신생물 근치·두개내신생물 근치 방사선 조사 분류표

방사선 조사 분류항목	수술종류(종)
1. 악성신생물 근치 방사선 조사 [5,000Rad 이상의 조사(照射)를 하는 경우로 한정하며, 악성신생물 근치 사이버나이프(Cyberknife) 정위적 방사선 치료(定位的 放射線 治療, Stereotactic radiotherapy)를 포함함]	3
2. 두개내 신생물 근치 감마 나이프(Gammaknife) 정위적 방사선 치료	3

(1~5종수술 분류표 사용 지침)

1. '수술'이라 함은 「의료법」 제5조(의사,치과의사 및 한의사 면허)에 규정한 의사, 치과의사의 자격을 가진 자가 피보험자의 질병 또는 상해로 인한 치료를 직접목적으로 필요하다고 인정한 경우로서 「의료법」 제3조(의료기관)에 규정한 국내의 병원이나 의원 또는 국외의 의료관련법에서 정한 의료기관에서 의사의 관리하에 '1~5종수술 분류표'에서 정한 행위를 받는 경우를 말합니다. '수술'은 기구를 사용해서 생체(生體)에 절단(切斷, 특정부위를 잘라 내는 것), 절제(切除, 특정부위를 잘라 없애는 것) 등의 조작(操作)을 가하는 것(보건복지부 산하 신의료기술평가위원회(향후 제도변경시에는 동 위원회와 동일한 기능을 수행하는 기관)로부터 안전성과 치료효과를 인정받은 최신 수술기법도 포함됩니다)을 말합니다. 다만, 흡인(吸引, 주사기 등으로 빨아 들이는 것), 천자(穿刺, 바늘 또는 관을 꽂아 체액·조직을 뽑아내거나 약물을 주입하는 것) 등의 조치 및 신경차단(神經遮斷, Nerve Block)은 '수술'에서 제외합니다.
2. '관혈(觀血)' 수술이라 함은 병변 부위를 육안으로 직접 보면서 수술적 조작을 하기 위해 피부에 절개를 가하고 병변부위를 노출시켜서 수술하는 것을 말합니다.
3. '근본(根本)' 혹은 '근치(根治)' 수술이라 함은 일회의 수술로 해당 질병을 완전히 치유할 수 있는 수술을 말합니다.
4. '관혈적 악성신생물 근치수술'이라 함은 관혈적 방법을 통해 악성신생물의 원발 병소를 완전히 절제, 적제, 적출하고 혹은 괴절술을 함께 실시한 경우입니다.
5. '1~5종수술 분류표' 상에 열거되지 않은 선진의료적 첨단 수술에 대한 인정 및 적용 기준:
   '1~5종수술 분류표'에서의 선진의료적 첨단 수술은 상기 '수술'의 정의에 해당하여야 하고 약물투여 치료, 방사선조사치료 또는 기타의 보존적 치료로 분류될 수 없는 경우이어야 합니다.
   1) '1~5종수술 분류표' 상의 수술 이외에 보건복지부 산하 신의료기술평가위원회(향후 제도 변경시에는 동 위원회와 동일한 기능을 수행하는 기관)로부터 안전성과 치료효과를 인정받은 최신 수술기법으로 치료한 경우 '1~5종수술 분류표' 상의 동일부위 수술로 봅니다.
   2) 단, 이 선진의료적 첨단 수술이 본질적으로 내시경(Fiberscope)에 의한 내시경 수술인 경우에는 '1~5종수술 분류표' 중 'Ⅰ. 일반적인 상해 및 질병치료 목적의 수술' 89항(악성신생물의 경우는 '악성신생물 치료목적의 수술' 2항)을 우선 적용합니다.
6. '악성 신생물 근치 사이버 나이프(Cyberknife) 정위적 방사선 치료'라 함은 선형가속기(LINAC)에서 발생되는 가는 방사선(Pencil beam)들을 다양한 각도에서 악성 신생물을 향해 집중적으로 조사하면서 동시에 악성신생물의 움직임을 병변 추적 장치를 이용하여 실시간으로 추적하면서 치료하는 방법입니다.
7. '두개내 신생물 근치 감마나이프(Gammaknife) 정위적 방사선 치료'라 함은 정위 좌표계를 이용하여 코발트 60 방사성 동위원소(Co-60)에서 나오는 감마선을 두개강 내의 신생물을 향해 집중 조사함으로 두개(頭蓋)를 열지 않고도 수술적 제거와 같은 효과를 내는 치료를 말합니다.
8. 요실금수술(금여) 대상 수가코드
   1) 1~5종수술 분류표에서 요실금수술(금여)로 분류되는 의료행위는 진단확정된 "요실금"을 원인으로 행해진 것으로 「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 "의료급여법」에서 정한 의료급여에서 "요실금수술(금여)"로 인정하는 기준에 해당하는 경우로서, "건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」에서 정한 아래의 진료행위(이하 "요실금수술(금여) 인정기준"이라 합니다)를 말합니다.

1~5종 수술분류표 · 흥국화재

1~5종 수술분류표 흥국화재 · 약관 원문 캡처 6장 · 상담용 참고자료

Ⅰ. 일반 질병 및 상해 치료목적의 수술

구분	수술명	수술종류
피부, 유방의 수술	1. 피부이식수술(25㎠이상인 경우), 피판수술(피판분리수술, Z flap, W flap 제외)	3
	2. 피부이식수술(25㎠미만인 경우)	1
	3. 유방절단수술(切斷術, Mastectomy) 단, 유방의 비대(N62)로 인한 유방절단수술제외	3
	3-1. 유방의 비대(N62)로 인한 유방절단수술	1
	4. 기타 유방수술(농양의 절개 및 배액은 제외) [단, 치료목적의 Mammotomy는 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	1
근골(筋骨)의 수술 [발정술 (拔釘術) 등 내고정물 제거술은 제외함] [치(齒) · 치은 · 치근(齒根) ·치조골(齒槽骨)의 처치, 임플란트(Implant) 등 치과 처치 및 수술에 수반하는 것은 제외함]>	5. 골(骨) 이식수술	2
	6. 두개골(頭蓋骨, cranium) 관혈수술 [비골(鼻骨) · 비중격(鼻中隔) · 상악골(上顎骨) · 하악골(下顎骨) · 악관절(顎關節)은 제외함]	3
	7. 비골(鼻骨) 수술 [비중격 만곡증(彎曲症)수술 제외, 단, 수면무호흡증(G47.3) 치료를 위한 수술은 보상함]	1
	8. 상악골(上顎骨), 하악골(下顎骨), 악관절(顎關節) 관혈수술	2
	9. 척추골(脊椎骨), 골반골(骨盤骨), 추간판 관혈수술	3
	10. 쇄골(鎖骨), 견갑골(肩胛骨), 늑골(肋骨), 흉골(胸骨) 관혈수술	2
	11. 사지(四肢) 절단수술(다지증에 대한 절단수술은 제외함)	
	11-1. 손가락, 발가락 절단수술 [골, 관절의 이단(離斷)에 수반하는 것]	1
	11-2. 기타 사지(四肢)절단수술	3
	12. 절단(切斷)된 사지(四肢)재접합수술(再接合手術) [골, 관절의 이단(離斷)에 수반하는것]	3
	13. 사지골(四肢骨), 사지관절(四肢關節) 관혈수술	
	13-1. 손가락, 발가락의 골 및 관절 관혈수술	1
	13-2. 기타 사지골(四肢骨), 사지관절(四肢關節) 관혈수술	2
	14. 근(筋), 건(腱), 인대(靭帶), 연골(軟骨) 관혈수술	1
호흡기계·흉부(胸部)의 수술	15. 만성부비강염(慢性副鼻腔炎) 근본수술(根本手術)	1
	16. 후두(喉頭) 관혈적 절제수술	3
	17. 편도, 아데노이드 절제수술	1
	18. 기관(氣管), 기관지(氣管支), 폐(肺), 흉막(胸膜) 관혈수술[개흉술(開胸術, Thoracotomy)을 수반하는 것]	4
비뇨기계·생식기계의 수술 (인공임신 중절수술은 제외함)	45. 신장(腎臟), 방광(膀胱), 신우(腎盂), 요관(尿管)관혈수술[개복술을 수반하는 것, 경요도적 조작 및 방광류 교정수술은 제외]	4
	46. 요도 관혈수술 [경요도적 조작은 제외함]	2
	47. 방광류·요실금 교정수술	1
	48. 신장(腎臟) 이식수술(移植手術) [수용자에 한함]	5
	49. 음경(陰莖) 절단수술(포경수술 및 음경이물제거수술은 제외)	3
	50. 고환(睾丸), 부고환(副睾丸), 정관(精管), 정색(精索), 정낭(精囊)관혈수술, 전립선(前立腺) 관혈수술	2
	51. 음낭관혈수술	1
	52. 자궁, 난소, 난관 관혈수술 (단, 제왕절개만출술 및 경질적인 조작은 제외)	2
	53. 경질적 자궁, 난소, 난관 수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	1
	54. 제왕절개만출술(帝王切開娩出術)	1
	55. 질절(膣脫) 근본수술	1
내분비기계의 수술	56. 뇌하수체종양(腦下垂體腫瘍) 절제수술	5
	57. 갑상선(甲狀腺)·부갑상선(副甲狀腺) 관혈수술	3
	58. 부신(副腎) 절제수술	4
신경계의 수술	59. 두개내(頭蓋內) 관혈수술 [개두술(開頭術, Craniotomy)을 수반하는 것]	5
	60. 신경(神經) 관혈수술	2
	61. 관혈적 척수종양(脊髓腫瘍) 절제수술	4
	62. 척수경막내외(脊髓硬膜內外) 관혈수술	3
시각기의 수술 [악물주입술은 제외]	63. 안공하수증(眼球下垂症)수술(안검내반증 포함)	1
	64. 누소관(淚小管)형성수술(누관류브삽입술 포함)	1
	65. 누낭비강(淚囊鼻腔) 관혈수술	2
	66. 결막낭(結膜囊) 형성수술	2
	67. 각막, 결막, 공막 봉합수술	1
	68. 각막, 공막 이식수술	2
	69. 전방(前房), 홍채(虹彩), 유리체(琉璃體) 관혈수술	2
	70. 녹내장(綠內障) 관혈수술	3
	71. 백내장(白內障), 수정체(水晶體) 관혈수술	1
	72. 망막박리(網膜剝離) 수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	2
청각기(聽覺器)의 수술	73. 레이저(Laser)에 의한 안구(眼球) 수술 [시력회복 및 시력개선 목적의 수술은 제외] [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	1
	74. 냉동응고(冷凍凝固)에 의한 안구(眼球) 수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	2
	75. 안구적출술, 조직충전술(組織充塡術)	3
	76. 안와내종양절제수술	3
	77. 관혈적 안와내(眼窩內) 이물제거수술(異物除去手術)	1
	78. 안근(眼筋)관혈수술	1
	79. 관혈적 고막(鼓膜) 성형술[고막 패치술은 제외]	2
	80. 유양동 절제술(乳樣洞切除術, mastoidectomy)	2
	81. 중이(中耳) 관혈수술[중이내 튜브유치술 제외]	2
	82. 중이내(中耳內) 튜브유치술[고막 패치술은 제외] [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	1
	83. 내이(內耳) 관혈수술	3
상기 이외의 수술 [검사,처치, 악물주입 요법은 포함하지 않음]	84. 상기 이외의 개두술(開頭術)	3
	85. 상기 이외의 개흉술(開胸術)	3
	86. 상기 이외의 개복술(開腹術)	2
	87. 체외충격파쇄석술(體外衝擊破碎石術, E.S.W.L)(체외충격파치료술(E.S.W.T)은 제외) [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	2
	88. 내시경(Fiberscope)에 의한 내시경 수술 또는 카테터(Catheter)·고주파 전극 등에 의한 경피적 수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	
	88-1. 뇌, 심장	3
	88-2. 후두, 흉부장기(심장 제외), 복부장기(비뇨, 생식기 제외), 척추, 사지관절(손가락, 발가락은 제외) * 단, 대장의 용종 또는 대장의 양성신생물의 내시경적 절제술은 1종으로 분류합니다.	2
	88-3. 비뇨, 생식기 및 손가락, 발가락	1
순환기계, 비장(脾臟)의 수술	19. 폐장(肺臟) 이식수술 [수용자(受容者)에 한함]	5
	20. 흉곽(胸郭) 형성수술(形成手術)	3
	21. 종격종양(縱隔腫瘍), 흉선 절제수술[개흉술을 수반하는 것]	4
	22. 혈관관혈수술(하지정맥류 및 손가락·발가락은 제외)	3
	23. 하지 정맥류(靜脈瘤) 근본수술 및 손가락·발가락 혈관관혈수술	1
	24. 대동맥(大動脈), 대정맥(大靜脈), 폐동맥(肺動脈), 관동맥(冠動脈) 관혈수술[개흉술, 개복술을 수반하는 것]	5
	25. 심막(心膜) 관혈수술 [개흉술을 수반하는 것]	4
	26. 심장내(心臟內) 관혈수술 [개흉술을 수반하는 것]	5
	27. 심장 이식수술 [수용자에 한함]	5
	28. 체내용(體內用) 인공심박조율기(人工心搏調律機, Artificial pacem aker) 매입술(埋入術)	3
	29. 비장(脾臟) 절제수술	3
소화기계의 수술	30. 아하선 절제수술	3
	31-1. 악하선, 설하선 절제수술	2
	31-2. 기타 타액선 절제수술(타석제거는 제외)	1
	32. 식도(食道) 이단술(離斷術) [개흉술, 개복술(開腹術, Laparotomy)을 수반하는 것]	4
	33. 위 절제수술(胃 切除手術, Gastrectomy) [개복술을 수반하는 것]	4
	34. 기타의 위·식도 관혈수술 [개흉술, 개복술을 수반하는 것]	3
	35. 간장(肝臟), 췌장(膵臟) 관혈수술 [개복술을 수반하는 것]	4
	36. 담낭(膽囊), 담도(膽道) 관혈수술 [개복술을 수반하는 것]	3
	37. 간장 이식수술 [수용자에 한함, 개복술을 수반하는 것]	5
	38. 췌장 이식수술 [개복술을 수반해야 하며 수용자에 한함](단, 랑게르한스 소도(islet of Langerhans)세포 이식수술은 제외함)	5
	39. 탈장(脫腸) 근본수술	1
	40. 전신성 복막염(全身性 腹膜炎, Generalized peritonitis)수술	2
	41. 충수(盲腸)절제술(충수염관련 충수주위 농양수술, 국한성 복막염 수술 포함), 맹장봉축술(盲腸縫縮術)	2
	42. 직장탈(直腸脫) 근본수술	1
	43. 소장(小腸), 결장(結腸), 직장(直腸), 장간막(腸間膜) 관혈수술 [개복술을 수반하는 것] (단, 직장탈근본수술은 제외)	4
	44. 치루(痔瘻), 탈항(脫肛), 치핵(痔核) 근본수술 [근치를 목적으로 하지 않은 수술은 제외함]	1

(주) 상기 1 ~ 87항의 수술 중 내시경(Fiberscope)을 이용한 내시경 수술 또는 카테터(Catheter) 등에 의한 경피적(經皮的, Percutaneous) 수술은 88항을 적용합니다. 다만, 복강경·흉강 경에 의한 수술은 해당부위(1 ~ 87 항)의 수술로 적용합니다.

Ⅱ. 악성신생물 치료 목적의 수술

수술명	수술종류
1. 관혈적 악성신생물(惡性新生物) 근치수술(根治手術, Radical curative surgery)(단, 기타피부암(C44) 제외) [내시경 수술, 카테터 · 고주파 전극 등의 경피적 수술 등은 제외함]	5
1-1. 기타피부암(C44)	3
2. 내시경 수술, 카테터·고주파 전극 등에 의한 악성신생물 수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	3
3. 상기 이외의 기타 악성신생물 수술 [수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.]	3

(주) 1. 제자리암·경계성종양에 대한 수술은 'Ⅰ. 일반 질병 및 상해치료 목적의 수술' 항목의 적용을 받습니다.
2. 카테터(Catheter)를 이용한 흡인·천자·악물주입요법은 포함하지 않습니다.
3. 비고형암에 대한 비관혈적 근치수술은 관혈적 악성신생물 근치수술에 준하여 5종 수술로 인정합니다.
- 비고형암에 대한 비관혈적 근치술 중 조혈모세포 이식술은 일련의 과정(추출, 필터링, 배양, 제거, 주입)을 모두 포함하여 1회의 수술로 인정합니다.
- 다만 악물 등을 투여하기 위한 시술(예. 중심정맥삽관술)만 시행할 경우에는 5종으로 인정하지 않습니다.

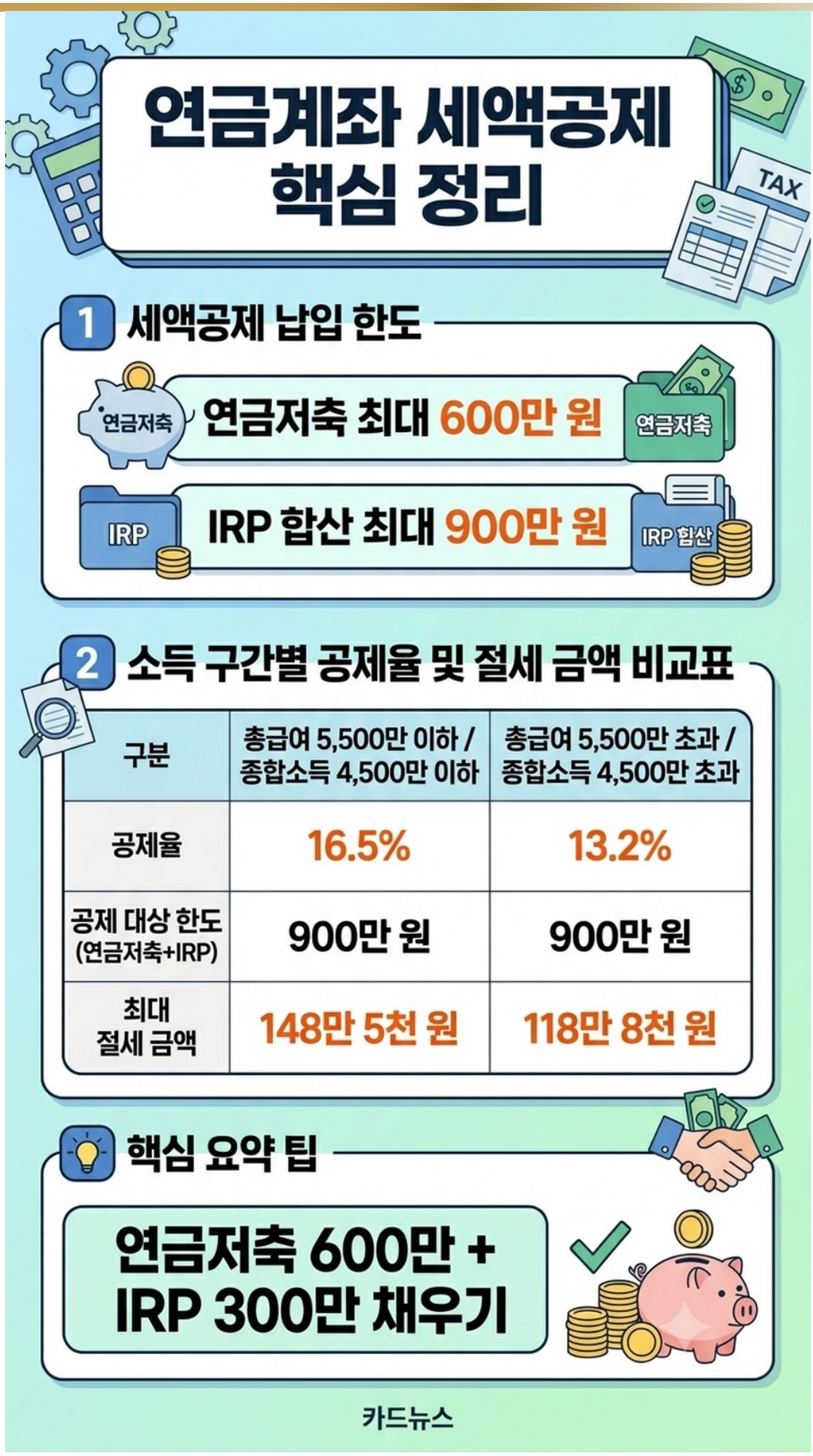
Ⅲ. 악성신생물 근치·두개내신생물 근치 방사선 조사 분류표

방사선 조사 분류항목 수술종류	수술종류
1. 악성신생물 근치 방사선 조사 [5,000Rad 이상의 조사(照射)를 하는 경우로 한정하며, 악성신생물 근치 사이버나이프(Cyberknife) 정위적 방사선 치료(定位的 放射線 治療, Stereotactic radiotherapy)를 포함함]	3
2. 두개내 신생물 근치 감마 나이프(Gammaknife) 정위적 방사선 치료	3

(주) 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.

(1~5종 수술분류표Ⅳ 사용 지침)

1. '수술'이라 함은 의사, 치과의사의 면허를 가진 자(이하 "의사"라 합니다)가 피보험자의 질병 또는 상해로 인한 치료를 직접목적으로 필요하다고 인정한 경우로서 의료법 제3조(의료기관)에 규정한 국내의 병원이나 의원 또는 국외의 의료관련 법에서 정한 의료기관에서 의사의 관리 하에 수술하는 것을 말합니다. 이 때 수술이란 <1~5종 수술분류표Ⅳ>에서 정한 행위[기구를 사용하여 생체(生體)에 절단(切斷, 특정부위를 잘라 내는 것), 절제(切除, 특정부위를 잘라 없애는 것) 등의 조작을 가하는 것]보건복지부 산하 신의료기술평가위원회(향후 제도변경시에는 동 위원회와 동일한 기능을 수행하는 기관)로부터 안전성과 치료효과를 인정받은 최신 수술기법도 포함됩니다]을 말합니다. 단, 흡인(吸引, 주사기 등으로 빨아 들이는 것), 천자(穿刺, 바늘 또는 관을 꽂아 체액·조직을 뽑아내거나 약물을 주입하는 것) 등의 조치 및 신경(神經) BLOCK(신경의 차단) 등은 제외]를 하는 것을 말합니다.
2. '관혈(觀血)'수술이라 함은 병변 부위를 육안으로 직접 보면서 수술적 조작을 하기 위해 피부에 절개를 가하고 병변 부위를 노출시켜서 수술하는 것을 말합니다.
3. '근본(根本)' 혹은 '근치(根治) 수술이라 함은 일회의 수술로 해당 질병을 완전히 치유할 수 있는 수술을 말합니다.
4. '관혈적 악성신생물 근치수술'이라 함은 관혈적 방법을 통해 악성신생물의 원발 병소를 완전히 절제 또는 적출하고 혹은 곽청술을 함께 실시한 경우입니다.
5. <1~5종 수술분류표Ⅳ> 상에 열거되지 않은 선진의료적 첨단 수술에 대한 인정 및 적용 기준: <1~5종 수술분류표Ⅳ>에서의 선진의료적 첨단 수술은 상기 "수술"의 정의에 해당하여야 하고 악물투여치료, 방사선 조사치료 또는 기타의 보존적 치료로 분류될 수 없는 경우이어야 합니다.
   (1) <1~5종 수술분류표Ⅳ> 상의 수술 이외에 보건복지부 산하 신의료기술평가위원회(향후 제도변경시에는 동 위원회와 동일한 기능을 수행하는 기관)로부터 안전성과 치료효과를 인정받은 최신 수술기법으로 치료한 경우 <1~5종 수술분류표Ⅳ> 상의 동일부위 수술로 봅니다. 이 때에 해당 최신수술기법은 수술개시일로부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.
   (2) 단, 이 선진의료적 첨단 수술이 본질적으로 내시경(Fiberscope)에 의한 내시경 수술 또는 카테터(Catheter) 등에 의한 경피적 수술인 경우에는 <1~5종 수술분류표Ⅳ> 중 'Ⅱ. 일반 질병 및 상해치료 목적의 수술' 88항 '악성신생물의 경우는 'Ⅱ. 악성신생물 치료목적의 수술' 2항)을 우선 적용합니다.
6. '악성신생물 근치 사이버 나이프(Cyberknife) 정위적 방사선 치료'라 함은 선형가속기(LINAC)에서 발생되는 가는 방사선(Pencil beam)들을 다양한 각도에서 악성신생물을 향해 집중적으로 조사하면서 동시에 악성신생물의 움직임을 병변 추적 장치를 이용하여 실시간으로 추적하면서 치료하는 방법입니다.
7. '두개내 신생물 근치 감마나이프 (Gammaknife) 정위적 방사선 치료'라 함은 정위 좌표계를 이용하여 코발트 60 방사성 동위원소 (Co-60) 에서 나오는 감마선을 두개강 내의 신생물을 향해 집중 조사함으로 두개(頭蓋)를 열지 않고도 수술적 제거와 같은 효과를 내는 치료를 말합니다.
8. 다음과 같은 수술은 수술보험금 지급대상에서 보장을 제외합니다.
   (1) 미용 성형상의 수술
   (2) 피임(避妊) 목적의 수술
   (3) 피임 및 불임술 후 가임목적의 수술
   (4) 검사 및 진단을 위한 수술 [생검 (生檢), 복강경 검사(腹腔鏡檢査) 등]


연금계좌 세액공제
핵심 정리
TAX
1 세액공제 납입 한도
연금저축
연금저축 최대 600만 원
연금저축
IRP
IRP 합산 최대 900만 원
IRP 합산
2 소득 구간별 공제율 및 절세 금액 비교표
구분
총급여 5,500만 이하 / 종합소득 4,500만 이하
총급여 5,500만 초과 / 종합소득 4,500만 초과
공제율
16.5%
13.2%
공제 대상 한도 (연금저축+IRP)
900만 원
900만 원
최대 절세 금액
148만 5천 원
118만 8천 원
핵심 요약 팁
연금저축 600만 +
IRP 300만 채우기
카드뉴스

맞춤 설계를 위한 첫걸음!

재무상태 설문지

정확한 분석과 맞춤 설계를 위해 현재 재무상태를 확인해 주세요.

작성일 : ____년 ____월 ____일
성 함 : _____
연 락 처 : _____

1 소득 / 지출 현황

월 평균 기준으로 작성해 주세요.

소득 현황

- 월 평균 소득 (세전) _____ 원
- 기타 소득 (연금, 임대 등) _____ 원

지출 현황

- 월 평균 생활비 (고정+변동) _____ 원
- 월 평균 저축 / 투자액 _____ 원
- 월 평균 부채 상환액 _____ 원
- 월 예상 잉여자금 (소득 - 지출 - 상환) _____ 원

2 자산 현황

현재 보유하고 있는 자산을 작성해 주세요.

- 예금 / 적금 _____ 원
- 주식 / 펀드 / ETF _____ 원
- 보험 (해약환급금 기준) _____ 원
- 부동산 (시가 기준) _____ 원
- 기타 자산 (연금, 금, 가상자산 등) _____ 원
- **총 자산 합계** _____ 원

3 부채 현황

현재 보유하고 있는 부채를 작성해 주세요.

- 주택담보대출 _____ 원
- 신용대출 _____ 원
- 자동차 할부 _____ 원
- 카드론 / 현금서비스 _____ 원
- 기타 부채 _____ 원
- **총 부채 합계** _____ 원

부채 상환 계획

- ☐ 1년 이내 상환 예정
- ☐ 1~3년 이내 상환 예정
- ☐ 3년 이상 장기 상환
- ☐ 상환 계획 없음

4 재무 목표

가장 중요하게 생각하는 목표를 선택해 주세요.
(복수 선택 가능)

- ☐ 노후 준비
- ☐ 안정적인 자산 관리
- ☐ 자녀 교육자금
- ☐ 월 소득 / 현금 흐름 개선
- ☐ 주택 마련 / 이사
- ☐ 부채 상환
- ☐ 결혼 자금
- ☐ 기타 (_____)

가장 중요한 목표 3가지를 우선순위대로 적어주세요.

1. _____
2. _____
3. _____

추가 질문

현재 재무적으로 가장 고민되는 부분은 무엇인가요?

어떤 도움을 받으면 가장 도움이 될 것 같나요?

기타 요청사항이 있으신가요?

> "정확한 계획이 안정된 미래를 만듭니다.
> 함께 목표를 이루어 가겠습니다."

작성해 주셔서 감사합니다.

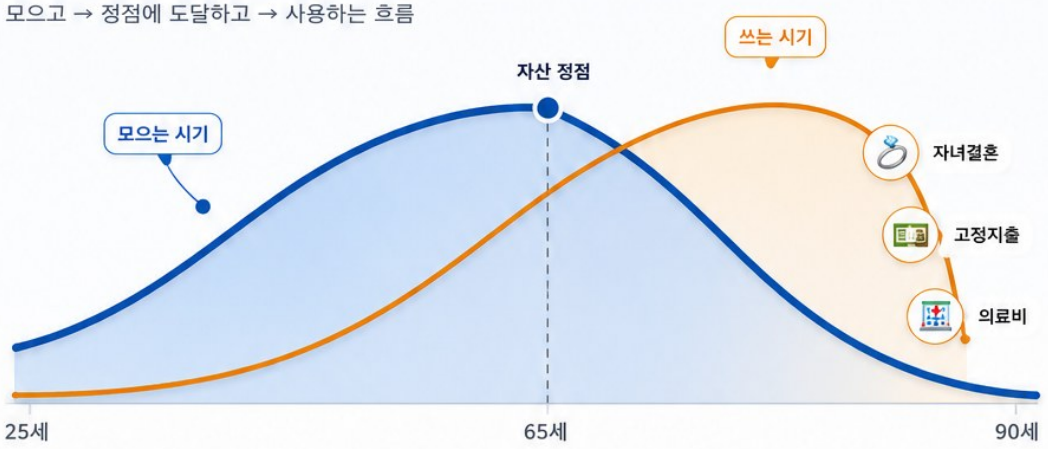
M1

MAKEONE 미래가치
Financial Life Timeline

나의 인생그래프
현재 위치와 앞으로 필요한 돈의 흐름을 한눈에 확인합니다.

25세 65세 90세

인생 자산 흐름 곡선
모으고 → 정점에 도달하고 → 사용하는 흐름



모으는 시기 · 25~65세
소득이 있을 때 자산을 만들고
미래 지출을 준비합니다.

사회생활 · 결혼 · 내 집 마련 · 자녀교육 · 저축 · 투자 · 절세 · 국민연금

쓰는 시기 · 65~90세
은퇴 후 생활비와 주요 목적 자금을
지속적으로 사용합니다.

고정지출 · 의료비 · 자녀결혼 · 여행 · 주택 유지 · 상속

물건 구매력 비교
같은 돈으로 몇 개를 살 수 있을까요?

비교할 물건: 커피 한 잔 · 예시 5,000원 ⌄ | 현재 물건 단가 (원): 5,000

현재	20년 후	30년 후	은퇴시점
예상 단가	예상 단가	예상 단가	예상 단가
5,000원	8,193원	10,488원	13,425원
구매 가능	구매 가능	구매 가능	구매 가능
20,000개	12,205개	9,535개	7,449개

지금 10,000만원으로 커피 한 잔을 약 20,000개 살 수 있지만,
40년 후 같은 돈으로는 약 7,449개만 살 수 있다는 가정입니다.

다른 물건으로 비교하기 ›

달러자산 — 왜 지금 준비해야 할까요?



달러보험 2탄 — 달러 기준 최저임금

월급의 착시

월급 50만원 올랐는데
왜 통장은 그대로일까?

세후 월급 · 5년 비교 (2021 → 2026)

2021년	2026년
250만원	300만원
세후 월급	세후 월급
$2,166	$2,143

원화 기준 +20% | 달러 기준 -23달러

환율 기준 · 2021년 1,154원 → 2026년 1,400원

5년 물가상승률 반영하면

~~300만원~~ ▶ 259만원

2021년 돈의 가치로 환산한 금액
= 5년간 실제로 오른 건 월 9만원 (실질 +4%)

월급이 오른 게 아니라
물가가 먼저 뛴 겁니다.

원화의 착시

최저시급 20% 올랐는데
달러로는 제자리였습니다

최저 시급 달러 환산 · 6년 비교 (2020 → 2026)

2020년	2026년
8,590원	10,320원
최저 시급	최저 시급
$7.28	$7.37
환율 1,180원	환율 1,400원

원화 기준 +20% | 달러 기준 +1%

환율 기준 · 2020년 평균 1,180원 → 2026년 1,400원

같은 1,000달러를 사려면

~~118만원~~ ▶ 140만원

지금은 140만원이 필요합니다

6년 만에 22만원 더 비싸졌습니다

시급이 오른 게 아니라
원화 가치가 내린 겁니다.

보험 가입 전 고지의무 체크리스트

정확한 고지는 고객님의 권리를 지키는 가장 중요한 시작입니다. 해당되는 항목에 체크하고, 반드시 청약서에 직접 기재하세요.

① 최근 3개월 이내

- ☐ 병원(의원·한의원 등)에 다녀온 적이 있다
- ☐ 건강검진에서 이상소견을 들었다
- ☐ 새로운 질병명을 진단받았다
- ☐ 의사에게 질병이 의심된다는 말을 들었다
- ☐ 치료를 받았다 (주사·물리치료 포함)
- ☐ 약을 처방받았다 (약국 조제약 포함)
- ☐ 입원했다
- ☐ 수술했다 (내시경·시술 포함)
- ☐ 추가검사·재검사가 필요하다는 말을 들었다

② 최근 1년 이내

- ☐ 건강검진 후 추가검사를 받았다
- ☐ 초음파·CT·MRI·내시경 등을 추가로 했다
- ☐ 혈액검사 이상으로 재검사를 했다
- ☐ 혹·결절·용종·수치 이상 등으로 재검사를 받았다
- ☐ 검사 결과를 추적관찰하고 있다

※ 단순 정기검진·상태확인 검진은 상품에 따라 고지대상이 아닐 수 있으니 정확한 판단을 위해 반드시 알려주세요.

③ 최근 5년 이내

- ☐ 입원한 적이 있다
- ☐ 수술한 적이 있다
- ☐ 같은 질병·사고로 7일 이상 치료받았다
- ☐ 같은 질병으로 30일 이상 약을 처방받았다
- ☐ 장기간 통원치료를 받은 적이 있다

주요 질병의 진단·치료·입원·수술·투약 여부
☐ 암 ☐ 뇌혈관병 ☐ 고혈압 ☐ 협심증 ☐ 심근경색
☐ 심장판막증 ☐ 간경화 ☐ 뇌졸중증 ☐ 당뇨병 ☐ HIV/AIDS

④ 최근 6~10년 이내

입원 또는 수술을 받은 적이 있나요?
☐ 6년 ☐ 7년 ☐ 8년 ☐ 9년 ☐ 10년 이내 입원·수술

※ 건강고지항(6~10년)은 가입일 기준으로 정확한 입원일·수술일 확인이 필요합니다.

⑤ 현재 복용 중인 약

- ☐ 혈압약 ☐ 당뇨약 ☐ 고지혈증약 ☐ 갑상선약
- ☐ 정신건강의학과 약 (우울증·불안 등)
- ☐ 수면제 ☐ 진통제 ☐ 호르몬제
- ☐ 기타 장기복용약 ( )

⑥ 건강검진 결과

- ☐ 재검 권유를 받은 적이 있다
- ☐ 추가검사 권유를 받은 적이 있다
- ☐ 결과 이상이 발견되었다
- ☐ 간수치·혈당·혈압 등 수치 이상이 있다
- ☐ 혈뇨·단백뇨 등 이상소견이 있다
- ☐ 검진 후 추적관찰 중이다

※ 건강검진 결과도 상품에 따라 고지대상이 될 수 있습니다.

⑦ 기타 확인사항 (청약서 질문 시)

- ☐ 현재 직업 및 직무 (변경 예정 포함)
- ☐ 오토바이·이륜차 운전 여부
- ☐ 위험한 취미·스포츠 활동
- ☐ 장애 또는 신체 상해 관련 사항
- ☐ 다른 보험 가입 및 청약 관련 사항

⑧ 많이 놓치는 수술·시술 예시

- ☐ 제왕절개 ☐ 용종절제(내시경 포함) ☐ 백내장수술
- ☐ 치질수술 ☐ 맹장수술 ☐ 골절수술
- ☐ 자궁·난소 관련 수술 ☐ 피부종양 제거
- ☐ 내시경적 시술·수술 ☐ 기타 마취가 필요한 수술·시술

작은 수술이나 시술도 꼭 함께 알려주세요!

꼭 기억하세요

① 청약서 질문사항에 사실대로 알리는 것이 고객님의 권리를 지키는 가장 중요한 방법입니다. ② 고지내용은 가입 가능여부·보험료를 정하는 심사정보이며, 고지했다고 무조건 거절되지 않습니다. ③ 가입이 어려운 경우 보장 내용을 정확히 확인해 협의할 수 있도록 안내해 드립니다. ④ **보험설계사는 고지의무 수령권이 없습니다.** 반드시 청약서에 직접 기재하거나 정확히 반영되었는지 확인하세요. ⑤ 사실과 다르게 고지한 경우 계약 해지 또는 보험금 지급이 제한될 수 있습니다.

내 진료기록 조회, 2곳 × PC·앱 고지의무 체크 전에 — A 공단 · B 심평원

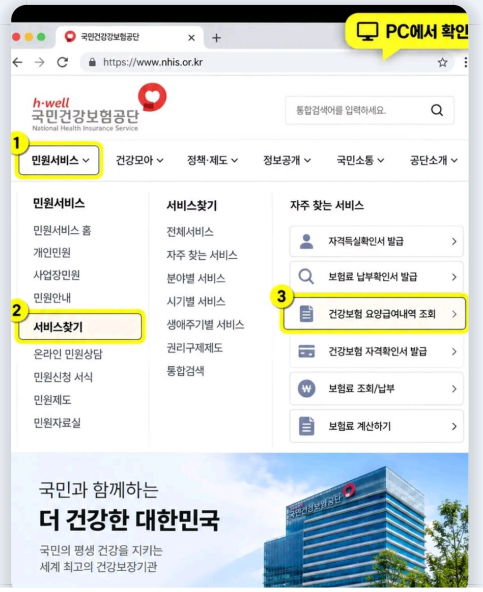
고지는 기억이 아니라 기록으로 합니다 — 청약 전에 고객 본인이 직접 조회합니다(본인인증 · 대리 조회 불가). A 공단 = PC·앱 한 세트(5년 진료·입원) / B 심평원 = PC·앱 한 세트(처방약·검사 상세)

A 국민건강보험공단 · PC

www.nhis.or.kr · 요양급여내역 조회

민원서비스 → 서비스찾기 → **건강보험 요양급여내역 조회**

최근 5년 진료·입원 날짜와 병원명 · 본인인증

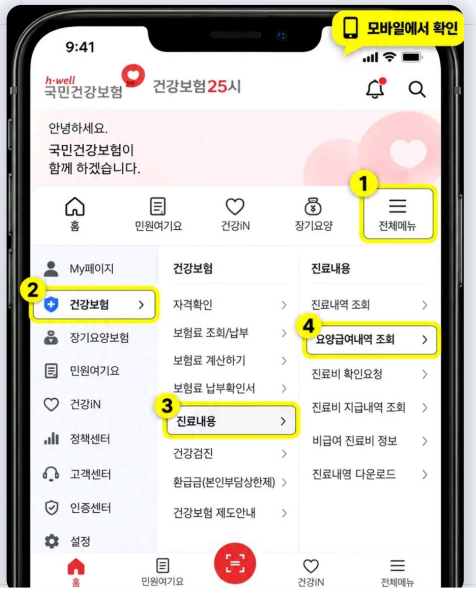


A 건강보험 25시 앱 · 모바일

국민건강보험공단 앱 · 같은 자료를 폰에서

전체메뉴 → 건강보험 → 진료내용 → **요양급여내역 조회**

「진료내역 다운로드」로 PDF 저장



B 건강보험심사평가원 · PC

www.hira.or.kr · 내 진료정보 열람

조회·신청 → **내 진료정보 열람** → 열람하기

진료내역·진료비 · 처방(의약품) · 검사·영상 상세

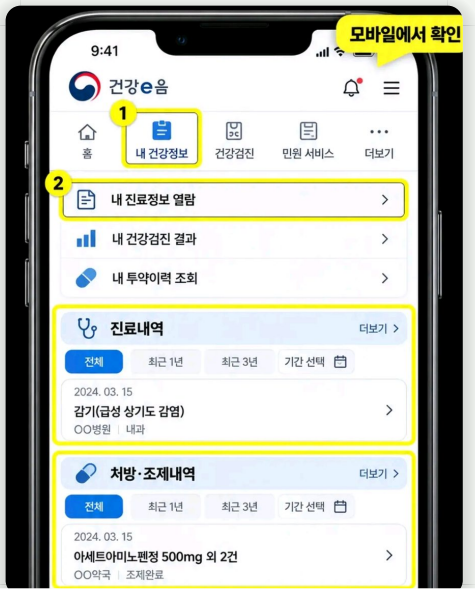


B 건강e음 앱 · 모바일

심평원 앱 · 같은 자료를 폰에서

내 건강정보 → **내 진료정보 열람**

진료내역 · 처방조제내역 · 건강검진 결과 — 최근 1년·3년·기간 선택



조회 순서 : A 공단(PC 또는 25시 앱) 5년 진료·입원 → B 심평원(PC 또는 건강e음 앱) 처방약·검사·검진. 둘이 다르게 나오면 병원 발급 진료확인서가 정본.

대한민국 상급종합병원 47곳

보건복지부 지정 **제5기 (2024.1.1. ~ 2026.12.31.)** · 11개 진료권역 **47곳**
상급종합병원은 중증질환에 대해 난이도가 높은 의료행위를 전문적으로 하는 종합병원 중 보건복지부가 지정한 병원입니다. 진단비·수술비 특약 중 **상급종합병원 조건**이 붙은 담보는 아래 병원에서 받은 진료만 해당됩니다.

서울 14곳
- 가톨릭대 서울성모
- 강북삼성
- 건국대
- 경희대
- 고려대 구로
- 고려대 안암
- 삼성서울
- 서울대
- 서울아산
- 세브란스
- 강남세브란스
- 이대목동
- 중앙대
- 한양대

인천·경기 서북부 4곳
- 가톨릭대 인천성모 (인천)
- 가천대 길 (인천)
- 인하대 (인천)
- 순천향대 부천 (부천)

경기 남부 5곳
- 가톨릭대 성빈센트 (수원)
- 아주대 (수원)
- 분당서울대 (성남)
- 고려대 안산 (안산)
- 한림대 성심 (안양)

강원 2곳
- 강릉아산 (강릉)
- 연세대 원주세브란스기독 (원주)

충북 1곳
- 충북대 (청주)

충남·대전 3곳
- 충남대 (대전)
- 건양대 (대전)
- 단국대 (천안)

전북 2곳
- 전북대 (전주)
- 원광대 (익산)

전남·광주 3곳
- 전남대 (광주)
- 조선대 (광주)
- 화순전남대 (화순)

경북·대구 5곳
- 경북대 (대구)
- 칠곡경북대 (대구)
- 계명대 동산 (대구)
- 대구가톨릭대 (대구)
- 영남대 (대구)

경남 동부 · 부산·울산 6곳
- 고신대복음 (부산)
- 동아대 (부산)
- 부산대 (부산)
- 인제대 부산백 (부산)
- 양산부산대 (양산)
- 울산대 (울산)

경남 서부 2곳
- 경상국립대 (진주)
- 삼성창원 (창원)

※ 제주권은 지정 병원이 없습니다. · 지정 기간이 2026.12.31.에 끝나므로 이후 명단이 바뀔 수 있습니다. 청약·청구 전 최신 고시를 확인하세요.

알츠하이머 신약 레켐비

아밀로이드 베타를 직접 제거하는 **알츠하이머 질환 치료제** — 치료 원리와 **보험 담보**를 한 장으로

레켐비(LEQEMBI) — 치료제

① 개요 및 기전

뇌에 쌓인 **아밀로이드 베타 플라크**를 제거한다.

· 원인 단백질 제거

· 질병 진행 지연 효과

② 투여 대상 및 방법

초기 알츠하이머 · 경도인지장애 환자

· 2주 1회 정맥 주사(IV)

· 지속 관리 필요

③ 효과 및 주의사항

인지 기능 저하 속도 감소(**약 27% 지연**)

· 뇌부종 · 미세출혈(ARIA) 위험

· **정기 MRI 검사 필수**

④ 승인 현황 및 향후 전망

미국 · 일본 승인, 다양한 국가 추진 중

· 더 많은 국가 승인 기대

· 치료 접근성 확대 노력

레켐비 — 보험 담보 핵심

1. 핵심 보장 담보

최경도/경증 알츠하이머 진단 & 레켐비 투약 확정 시

· 보험금 최대 **2,000만~6,000만원**(다중 가입 시)

· 회차별 분할 또는 단계별 일시금 지급

2. 지급 방식 및 조건

· **CDR 0.5~1점** 진단

· 아밀로이드 베타 축적 확인

· 최소 투약 횟수 충족

· 회당 분할 지급형(예: 현대) / 단계별 일시금 지급형(예: KB)

3. 추가 지원 특약

· MRI 검사비 지원(ARIA 모니터링, 회당 최대 50만원)

· 진단 및 검사비 정액 지원(PET-CT, SNSB 등)

· 실손 미보장 대비 **정액 특약 설계 권장**

4. 필수 확인 및 유의사항

· 치매 보장 **면책 기간 1년** 필수 확인(재해 제외)

· 단계별 지급 시 **합산 한도 초과** 주의

· 신규 담보(신계약) 출시로 보장 내용 변동 가능

※ **레켐비 투약 비용은 실손보험 미보장**이다. 정액 담보로 준비하지 않으면 자기부담이 된다.

교통사고 경상환자 처리기준 개정

자배법 시행령 · 자동차보험 표준약관 개정 (금감원 2026.9.2. 보도자료)

① 8주 초과 치료 — 26.09.10 사고일 기준

8주를 넘기면 자배원 심사

대상 12~14급 경상(염좌 · 단순타박상)이 8주를 넘겨 치료받을 때

절차 자배원(자동차손해배상진흥원) **전문의 심사**를 거쳐야 계속 치료

제외 골절 · 장기손상 등 중상(1~11급) · 임산부 · 영유아

불복 불인정 시 **이의제기 가능**

② 서류 — 7주 이내 제출

기한은 사고일로부터 7주

서류 진단서 · 진료기록부 사본 · 영상CD(있을 시) · 개인정보 동의서

비용 발급비는 보험회사가 부담한다

통보 심사 결과는 제출일로부터 **7일 이내**

③ 향후치료비 폐지 — 26.10.25 보험개시 기준

경상은 미리 받는 돈**이 없어진다**

지급 향후치료비는 중상(1~11급)에게만 지급된다

경상 치료가 끝날 때까지 실제 발생한 치료비만 보장

영향 합의 상담 방식이 달라진다 — **목돈 합의금이 사라진다**

④ 보장분석 시사점

정액 담보의 가치가 커진다

자부상 12~14급 경상이 치료 · 보상 제한을 받는다

점검 자동차부상치료비 · 교통상해 담보의 **가입금액과 급수 범위**

준비 초진부터 **진료기록 · 영상자료**를 빠짐없이 남긴다

기억할 숫자 네 개

숫자	무엇인가	놓치면 생기는 일
7주	사고일로부터 서류 제출 기한	심사 자체를 못 받을 수 있다
7일	제출 후 **심사 결과 통보**까지	답변이 없으면 보험사에 확인한다
8주	경상 자배원 심사 기준점	서류 없이는 치료를 이어가기 어렵다
12~14급	**경상** — 이번 개정의 대상	1~11급 중상은 해당 없음

★ **상담 한 줄** "치료는 **8주**, 서류는 7주입니다. 경상은 이제 미리 받는 향후치료비가 없으니, **자동차부상치료비 · 교통상해 정액 담보**가 그 자리를 대신합니다."

※ **배경** 자동차보험 손익 **'25년 7,080억 적자 · '26년 1~5월 1,637억 적자** — 보험금 누수를 막지 않으면 선의의 가입자 보험료가 오른다. 세부 절차는 자배원 · 각 보험사 안내를 따른다.

◆ 중요 날짜와 할 일

언제부터 바뀌나

9월 10일부터

경상 **8주 초과 치료 → 자배원 심사** (사고일 기준)

10월 25일부터

경상 **향후치료비 폐지** (보험개시 기준)

그래서 지금 할 일

운전자보험 「자동차부상위로금」 보유 필수

경상 치료비가 막힐수록 **정액으로 받는 담보**가 대안이 된다

현재 12~14급 30만원까지 가입 가능

지금 보유 금액과 **급수 범위**를 바로 확인한다

질병 후유장해 — 세부 장해와 지급률

① 꼭 알아둘 4가지 보험 표준 장해분류표 기준

무엇인가요?
질병 치료 후에도 신체·정신 기능에 **영구적인 손상**이 남은 상태

언제 보나요?
진단명만이 아니라 **장해가 고정**되었는지, 약관 기준 충족 여부를 함께 판단

얼마나 받나요?
보험금 = **가입금액 × 장해지급률**
(보통 3~100%)

꼭 기억할 점
합산·차액·파상장해는 약관마다 다르므로 가입한 약관 확인이 가장 중요합니다

② 대표 장해 세부 예시 13개 신체부위 장해분류표 · 대표 예시 요약

A 눈

- 두 눈 실명 100%
- 한 눈 실명 50%
- 한 눈 교정시력 0.02 이하 35%
- 한 눈 교정시력 0.06 이하 25%
- 한 눈 교정시력 0.1 이하 15%
- 한 눈 교정시력 0.2 이하 5%

B 귀

- 두 귀 청력 완전상실 80%
- 한 귀 완전상실 + 다른 귀 심한 장해 45%
- 한 귀 완전상실 25%
- 한 귀 심한 장해 15%
- 한 귀 약간의 장해 5%
- 귓바퀴 대부분 결손 10%

C 코

- 코 호흡기능 완전상실 15%
- 코 후각기능 완전상실 5%
- 코 기능장해는 추상장해와 **별도 판단** 가능

D 씹기·말하기

- 둘 다 심한 장해 100%
- 씹기 심한 장해 80%
- 말하기 심한 장해 60%
- 둘 다 뚜렷한 장해 40%
- 하나만 뚜렷한 장해 20%
- 하나만 약간의 장해 5%

E 척추·디스크

- 척추 심한 운동장해 40%
- 척추 뚜렷한 운동장해 30%
- 척추 약간의 운동장해 10%
- 척추 심한 기능장해 50%
- 척추 뚜렷한 기능장해 30%
- 척추 약간의 기능장해 15%
- 심한 디스크 20% · 뚜렷 15% · 약간 10%

F 손가락

- 한 손 5손가락 모두 상실 55%
- 첫째 손가락 상실 15%
- 다른 손가락 상실 각 10%
- 5손가락 모두 뚜렷한 장해 30%
- 첫째 손가락 뚜렷한 장해 10%
- 다른 손가락 뚜렷한 장해 각 5%

G 발가락

- 한 발 리스프랑관절 이상 상실 40%
- 5개 발가락 모두 상실 30%
- 첫째 발가락 상실 10%
- 다른 발가락 상실 각 5%

H 신경계·정신행동

- 뇌혈행장해(뇌졸중·TIA·뇌 등) 10~100%
- 약간의 치매 CDR 2점 40%
- 뚜렷한 치매 CDR 3점 60%
- 심한 치매 CDR 4점 80%
- 극심한 치매 CDR 5점 100%
- 마비·간질·뇌병변도 해당 가능

③ 청구 전 꼭 체크 서류 · 항목 · 구간 · 중복

필요 서류
진단서, 진료기록지, 검사결과지, **장해 고정 후 평가서** 등
보험사마다 추가 서류가 요청될 수 있습니다.

필요 항목
후유장해진단서, 진단서, 의무기록, 검사결과, 영상자료, 일상생활기록 등

약관 차이
상품마다
3~10%, 50% 이상, 80% 이상 등
지급 구간이 다릅니다.

중요한 내용
기존 장해·재해장해가 있으면 **차액 지급**이 될 수 있고, 중복 부위는 높은 지급률을 적용할 수 없으므로 약관 적용 여부를 확인하세요.

★ BARUM 엑셀 연동 — 담보명에 (80세)가 붙으면 질병후유3% 행, (80%)·고도가 붙어야 질병후유80% 행이다(제154조 ⑦). 20% 이상 담보는 마스터에 행이 없어 [확인]으로 간다. 재해(상해)고도장해는 상해후유80% 행이다.

※ 실제 보험금 지급 여부와 장해율은 보험약관·가입시기·면책사항·의학적 판정에 따라 달라질 수 있습니다.

CI 약관 — 「중대한」 3대 질병 정의

CI(중대한 질병) 진단비는 일반 진단비와 **지급 조건이 다르다.** 같은 암·심근경색·뇌졸중이라도 아래 약관 정의를 **모두** 채워야 지급된다.

Ⅰ. 중대한 암 Critical Cancer

① 「중대한 암」이란 악성종양세포가 존재하고 또한 주위 조직으로 악성종양세포의 **침윤파괴적 증식**으로 특징 지을 수 있는 악성종양을 말합니다.

② 진단은 **병리 진단(조직검사)**으로 확정해야 합니다.

제외(상품마다 다름): 상피내암 · 경계성종양 · 기타피부암 · 초기 갑상선암 · 초기 전립선암 등 약관에 적힌 항목

Ⅱ. 중대한 급성심근경색증 Critical Acute Myocardial Infarction

① 관상동맥의 폐색으로 심근으로의 혈액공급이 급격히 감소되어 **전형적인 흉통**과 함께 해당 **심근조직의 비가역적인 괴사**를 가져오는 질병으로서 발병 당시 다음 2가지 특징을 **모두** 보여야 합니다.

가. **전형적인 급성심근경색 심전도 변화(ST분절, T파, Q파)가 새롭게 출현**

나. **CK-MB를 포함한 심근효소의 발병당시 새롭게 상승** **(단, TROPONIN은 제외)**

Ⅲ. 중대한 뇌졸중 Critical Stroke

① 거미막밑출혈, 뇌내출혈, 뇌경색이 발생하여 뇌혈액순환의 급격한 차단이 생겨서 그 결과 **영구적인 신경학적 결손**이 나타나는 질병을 말합니다.

② 진료기록부상 전형적인 병력이 기초 · 주관적인 자각증상이 아니라 신경학적 검사를 기초로 한 객관적인 신경학적 증후로 나타난 장애로서, 장해분류표 **「신경계에 장애가 남아 일상생활 기본동작에 제한을 남긴 때」**의 **지급률이 25% 이상인 장해상태**에 해당해야 합니다.

상담 포인트 · 일반 진단비 = 진단 즉시 / CI = **조건 충족 시에만** · 협심증·일과성 허혈발작(TIA)·외상성 출혈은 대상이 아니다 · 뇌졸중은 결손이 **영구적**이어야 해서 진단 직후 바로 받기 어렵다

보장분석 · 「중대한 OO」은 일반 진단비 칸에 합산하지 않는다(CI/GI/리빙케어) · 진단서 4쪽 CI 카드와 같은 정의 · 문구는 가입 시기·회사마다 다르니 **증권 약관 원문 확인**

CI 약관 — 그 밖의 「중대한」 담보

CI보험금은 아래 **중대한 질병 · 중대한 수술 · 중대한 화상** 중 **최초 1회**만 지급되는 상품이 많다. 어떤 항목이 들어 있는지는 **상품·가입 시기마다 다르다.**

Ⅳ. 말기신부전증

양쪽 신장 모두 **비가역적 기능부전** · 보존요법으로 치료가 안 되어 **혈액투석·복막투석**을 받고 있는 경우

일시적 투석은 제외

Ⅴ. 말기간질환

간경화로 인한 말기 간질환 · **영구적 황달 · 복수 · 간성뇌증 · 식도 정맥류** 등 증상이 나타나야 함

충족 개수·기준은 약관 원문 확인

Ⅵ. 말기폐질환

만성 폐질환의 **말기 상태** · 폐기능검사 수치와 **지속적인 산소 치료** 기준을 함께 봄

수치 기준은 상품마다 다름 — 원문 확인

Ⅶ. 중대한 화상 및 부식

화상·화학약품 부식이 **체표면 20% 이상** · **3도 이상**

일반 화상진단비(2도 등)와 기준이 다름

Ⅷ. 중대한 수술 Critical Surgery

관상동맥(심장동맥)우회술 관상동맥질환 치료 목적으로 **개흉 후** 자가 우회도관(대복재정맥·내유동맥 등)을 연결하는 수술 · **카테터·스텐트 시술은 해당 없음**

대동맥(류)인조혈관치환수술 대동맥을 **인조혈관으로 바꾸는** 개흉·개복 수술

심장판막수술 판막을 바꾸거나 고치는 **개흉** 수술

5대장기이식수술 **간 · 신장 · 심장 · 췌장 · 폐** 이식(받는 사람 기준)

그 밖에 상품에 따라 들어가는 것

중증 재생불량성빈혈 · 루게릭병 · 다발경화증 · 중증 루푸스신염 · 원발성 폐동맥고혈압 · 중증치매·장기요양상태(LTC) · 중대한 장해(실명·사지 절단·마비 등)

상담 포인트 · CI는 「병명」이 아니라 **약관 정의**로 판단 · 대부분 **최초 1회**·선지급 후 사망보험금 감소 · 스텐트·풍선 같은 시술은 중대한 수술이 아니다

보장분석 · 「중대한 OO」은 일반 칸에 합산하지 않는다 · 들어 있는 항목은 **증권의 CI 보장 목록과 약관 별표**로 확인

보험금 청구 — 무료 필수서류 4종 · 청구 방법 질병코드 있으면 무조건 챙긴다

병원 나올 때 4종을 그 자리에서 받는다 — 전부 무료. 통원 10만원 이하는 진단서 없이 처방전(질병코드)으로 된다(금감원 기준). 나중에 다시 가면 수수료·시간.

01 환자 보관용 처방전

단순 통원 때

병원 방문·진료 사실 확인 · 질병코드 ◯ · 무료

이렇게 생겼다

환자 성명 · 발행일 · 병원명 · 진료과

상병코드(J00 · E11 · M54…) · 치료 내용 · 일수

담당의사 · 직인

02 진료 · 통원 확인서

검사·치료 때

진료일 · 통원 기간 확인 · 질병코드 ◯ · 무료

이렇게 생겼다

환자 성명 · 발행일 · 병원명 · 진료과

상병코드 · 치료 내용 · **통원 기간**(처음~마지막 날)

담당의사 · 직인

03 진료비 상세계산서 · 상세내역서

모든 청구

항목별 금액 · 세부내역서는 실손 필수 · 무료(의무기록 사본만 수수료)

이렇게 생겼다

진찰료 · 검사료 · 치료료 · 처치료 · 약제비 — 항목별 금액

상세내역서 = 검사·치료를 더 잘게(혈액검사 · 영상 · 물리치료 · 도수치료)

합계 금액 · 병원장 직인

04 약 봉투(투약내역서)

처방약 받을 때

약 이름 · 복용법 — 약제비 실손 · 무료

이렇게 생겼다

성명 · 조제일 · 약국명

약 이름 · 1일 횟수 · 일수

주의 사항

통원 3만 이하	청구서 + 영수증 — 금감원 2014.11 「통원 10만원 이하 청구 간소화」
통원 3만~10만	청구서 + 영수증 + **처방전(질병분류기호 포함)** — 진단서 대신 처방전(같은 금감원 기준)
통원 10만 초과	영수증 + 세부내역서 + 진단서 **또는 진료확인서** — 회사별 **[확인]** · 고액·진단비는 진단서
입원	입퇴원확인서(진단명 포함) · 영수증 · 세부내역서 · 50만 초과는 진단서 요구가 많음(회사별) (+수술확인서)
청구 방법	① 앱(사진 촬영) → ② 팩스(50쪽 회사별 번호 · 금액 한도 있는 곳 주의) → ③ 우편 · 방문
기한	보험금 청구권 3년(상법 662조) — 지났어도 일단 청구
자주 반려	질병코드 없는 영수증 · 세부내역서 누락 · 통원일 빠짐 · 수익자 계좌 불일치

창구에서 이렇게 말한다 — 「보험 청구용으로 처방전 환자보관용이랑 진료비 세부내역서 주세요. 질병코드 꼭 찍어 주세요.」 검사·치료가 있었으면 「통원확인서도요」. 금액 구간 출처: 금감원 2014.11 발표(3만 이하 영수증 · 3만~10만 처방전) · 10만 초과·입원은 회사별 — 그 회사 청구 안내가 정본.

각사 콜센터 · 모니터링 인콜 · 보험금 청구 FAX 2026.10 · 빈칸 = 콜센터에서 부여

60
청구 팩스

손해보험사

회사	콜센터	모니터링 인콜	보험금 청구 FAX	비고
삼성화재	1588-5114	1566-0553	**0505-162-0872**	
현대해상	1588-5656	1577-3223	**0507-774-6060**	
DB손보	1588-0100	1566-0757	**0505-181-4862**	08시~20시에만 접수(월~금)
KB손보	1544-0114	1544-0019	**0505-136-6500**	장기 0505-136-6500 / 일반 0505-136-6600
메리츠화재	1566-7711	1577-7711	**0505-021-3400**	질병 0505-021-3400 / 상해 0505-021-3500
한화손보	1566-8000	1670-1882	**0502-779-1004**	또는 0502-777-6488
흥국화재	1688-1688	1688-6997	콜센터 부여	콜센터에서 팩스번호 부여
MG손보	1588-5959	1577-3777	**0505-088-1646**	0505-088-1646~9
롯데손보	1588-3344	1600-5182	**0507-333-9999**	또는 02-2094-5572~6
NH농협손보	1644-9000	1644-9600	**0505-060-7000**	
하나손보	1566-3000	1660-4590	**0505-170-0765**	
라이나손보(에이스)	1566-5800	1833-9513	**02-2127-2308**	치아보험 02-6913-8482
AIG(차티스)	1544-2792	1600-4600	**02-2011-4607**	
AXA손보	1566-1566	—	콜센터 부여	콜센터에서 팩스번호 부여
BNP파리바카디프	1544-2580	—	**02-2050-8111**	
캐롯손보	1566-0300	—	콜센터 부여	콜센터에서 팩스번호 부여

생명보험사

회사	콜센터	모니터링 인콜	보험금 청구 FAX	비고
삼성생명	1588-3114	1588-3115	콜센터 부여	1577-4118로 전화해서 팩스번호 부여
한화생명	1588-6363	1800-6633	콜센터 부여	콜센터에서 팩스번호 부여
교보생명	1588-1001	1588-1636	콜센터 부여	1588-1810 팩스번호 부여
NH농협생명	1544-4000	1544-4422	**02-6971-6040**	
신한라이프	1588-5580	1522-2285	콜센터 부여	콜센터 팩스 / 500만원 이하 접수 · 팩스번호 발급일에만 사용 가능(평일 09~18시)
동양생명	1577-1004	080-899-1004	**02-3289-4517**	정액 02-3289-4517 / 실손 02-3289-4516
흥국생명	1588-2288	1877-7006	콜센터 부여	콜센터에서 팩스번호 부여
미래에셋생명	1588-0220	1588-0220	콜센터 부여	콜센터에서 팩스번호 부여
KDB생명	1588-4040	1588-4040	**02-2669-7930**	콜센터 접수 후 팩스
ABL생명	1588-6500	1566-1002	**02-3299-5544**	
AIA생명	1588-9898	1588-2513	**02-2021-4540**	
메트라이프	1588-9600	1588-9609	콜센터 부여	콜센터에서 팩스번호 부여(설계사 받을 수 있음)
DB생명	1588-3131	02-6470-7911~7932	**0505-129-3134**	
푸본현대생명	1577-3311	1577-3311	**0505-106-0311**	
KB라이프	1588-3374	1566-2730	**02-6220-9912**	
iM라이프	1588-4770	1588-4770	**0505-083-5420**	100만원 이하 접수 가능
라이나생명	1588-0058	1588-2442	**02-6944-1200**	300만원 이하 접수 가능
처브라이프	1599-4600	1599-4600	**02-3480-7801**	또는 0505-181-4861
하나생명	1577-1112	1577-1112	콜센터 부여	콜센터에서 팩스번호 부여
우체국	1588-1300	—	콜센터 부여	지역별 센터 보상팩스 이용(창원 0505-005-1623)
한국교직원공제	1577-3400	—	**02-3278-9696**	

※ 금액 한도 있는 곳: 신한라이프 500만 · 라이나생명 300만 · iM라이프 100만 이하만 팩스 접수 · DB손보 평일 08~20시 · 번호는 바뀔 수 있으니 첫 발송 전 콜센터로 확인. HELPER 📠에 같은 번호가 들어 있다.